UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Departamento de Economía Aplicada

Programa de Doctorado en Economía

Eficiencia hospitalaria, estructura organizativa y teoría de agencia

Un análisis de frontera estocástica del sistema hospitalario español

Tesis Doctoral

José María Elena Izquierdo

Salamanca, 2026

Resumen

La organización hospitalaria determina quién diseña los incentivos del profesional sanitario, qué dimensiones del *output* son verificables por el financiador y cómo se distribuyen el riesgo y el control entre los agentes que intervienen en la prestación: es, por eso, un objeto situado en la intersección entre el diseño institucional, la economía de los incentivos y el Derecho sanitario. El ordenamiento español ha configurado un sistema hospitalario que permite la coexistencia de formas de gestión con grados muy distintos de autonomía directiva, régimen de personal y capacidad contractual. Esa configuración arranca del reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud y se articula a través de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión y el Estatuto Marco del personal estatutario. Esta pluralidad organizativa no es un dato meramente descriptivo: condiciona de forma sustantiva los resultados en eficiencia técnica que el sistema hospitalario puede alcanzar.

Esta tesis analiza las consecuencias de esa arquitectura institucional sobre la eficiencia hospitalaria. Para ello, desarrolla un modelo de agencia multitarea con tres agentes —financiador público, hospital y médico— que producen conjuntamente dos *outputs* asimétricos: la cantidad de atención prestada (que depende del esfuerzo conjunto del hospital y del médico) y la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio (que depende exclusivamente del esfuerzo del médico). El modelo genera predicciones diferenciadas según la estructura organizativa: la descentralización contractual mejora la eficiencia en cantidad pero, cuando las tareas del médico son sustitutas, deteriora la eficiencia en intensidad. El tipo de pago y el grado de complementariedad entre tareas —aproximado en la tesis por la naturaleza quirúrgica o médica del servicio— moderan ese efecto de forma asimétrica.

El contraste empírico utiliza técnicas de frontera estocástica con cuatro diseños complementarios y datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023. Los resultados confirman que la descentralización reduce significativamente la ineficiencia en cantidad (en las siete especificaciones de robustez estimadas), aunque sin la inversión de signo predicha en la dimensión de intensidad. No obstante, la asimetría entre ambas dimensiones es estadísticamente

significativa y consistente con el modelo bajo sustitución moderada. La proporción de actividad quirúrgica —proxy de alta complementariedad entre tareas— modera asimétricamente el efecto de la estructura organizativa, con signos opuestos entre la frontera quirúrgica y la médica. Este constituye el resultado individual más robusto del análisis. Finalmente, el test conjunto confirma que los determinantes institucionales de la ineficiencia operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del *output* hospitalario.

La contribución de la tesis es triple. En el plano institucional, sistematiza el marco jurídico que hace inteligible la diversidad organizativa hospitalaria española y muestra que las categorías del Derecho sanitario —forma de gestión, régimen del personal, mecanismo de financiación— son variables analíticamente relevantes para un problema de incentivos. En el plano teórico, extiende los modelos clásicos de multitarea al caso de tres agentes con dos *outputs* asimétricos en un contexto hospitalario. En el plano empírico, proporciona la primera contrastación directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español, con estimación simultánea de fronteras para cantidad e intensidad que permite captar los efectos asimétricos que un modelo de eficiencia multiproducto convencional no podría identificar.

Los resultados tienen implicaciones directas para el diseño institucional del sistema hospitalario. La evidencia confirma que la estructura organizativa produce efectos estadísticamente significativos y cualitativamente distintos sobre las dos dimensiones del *output*: un enfoque de política de gestión hospitalaria que ignore esa multidimensionalidad —ya sea apostando por la centralización total o por la descentralización generalizada— agrega efectos de signo contrario y puede inducir conclusiones erróneas sobre el desempeño real de los hospitales. Una política informada por estos resultados debería incorporar indicadores separados de eficiencia en volumen e intensidad en los contratos-programa autonómicos y en los pliegos de los contratos de concesión, y extender el pago por actividad ajustado por complejidad a toda la red concertada. Los resultados no establecen causalidad de forma concluyente puesto que la asignación de hospitales a formas descentralizadas no es aleatoria, pero son consistentes con los mecanismos predichos por el modelo teórico y robustos frente a las especificaciones alternativas estimadas. En cualquier caso, la tesis constituye un primer paso en la dirección de una agenda de investigación que integre el análisis institucional, teórico y empírico para comprender el desempeño del sistema hospitalario español y orientar su diseño futuro.

Palabras clave: eficiencia hospitalaria, frontera estocástica, teoría de agencia, multitarea, estructura organizativa, sistema hospitalario español, formas de gestión sanitaria, información asimétrica

Clasificación JEL: I11, I18, D82, D86, C23

Abstract

Hospital organisation determines who designs the incentives of healthcare professionals, which dimensions of *output* are verifiable by the payer, and how risk and control are distributed among the agents involved in care delivery: it is, for that reason, an object situated at the intersection of institutional design, the economics of incentives, and health law. The Spanish legal framework has configured a hospital system that allows the coexistence of management forms with very different degrees of managerial autonomy, employment regime, and contractual capacity. That configuration originates in the constitutional recognition of the right to health protection and is articulated through the General Health Act, the Act on Cohesion and Quality of the National Health System, Act 15/1997 on new management forms, and the Framework Statute for statutory healthcare personnel. This organisational plurality is not merely descriptive: it substantively conditions the technical efficiency outcomes that the hospital system can achieve.

This thesis analyses the consequences of that institutional architecture for hospital efficiency. To do so, it develops a multitask agency model with three agents —public payer, hospital, and physician— who jointly produce two asymmetric *outputs*: the quantity of care delivered (which depends on the joint effort of the hospital and the physician) and the diagnostic-therapeutic intensity per episode (which depends exclusively on the physician's effort). The model generates differentiated predictions according to organisational structure: contractual decentralisation improves efficiency in quantity but, when the physician's tasks are substitutes, deteriorates efficiency in intensity. The payment mechanism and the degree of complementarity between tasks —proxied in the thesis by the surgical or medical nature of the service— moderate that effect asymmetrically.

The empirical test uses stochastic frontier techniques with four complementary designs and panel data from the Spanish hospital system for the period 2010–2023. The results confirm that decentralisation significantly reduces inefficiency in quantity (across all seven robustness specifications estimated), albeit without the sign reversal predicted for the intensity dimension. Nevertheless, the asymmetry between both dimensions is statistically significant and consistent with the model under moderate substitution. The proportion of surgical activity —a proxy for

high complementarity between tasks— asymmetrically moderates the effect of organisational structure, with opposite signs across the surgical and medical frontiers. This is the single most robust result of the analysis. Finally, the joint test confirms that the institutional determinants of inefficiency operate in qualitatively distinct ways across the two dimensions of hospital *output*.

The contribution of the thesis is threefold. At the institutional level, it systematises the legal framework that makes the organisational diversity of Spanish hospitals intelligible and shows that the categories of health law —management form, employment regime, financing mechanism— are analytically relevant variables for an incentive problem. At the theoretical level, it extends classic multitask models to the case of three agents with two asymmetric *outputs* in a hospital context. At the empirical level, it provides the first direct test of a multitask agency model in the Spanish hospital sector, with simultaneous estimation of frontiers for quantity and intensity that allows capturing the asymmetric effects that a conventional multi-output efficiency model could not identify.

The results have direct implications for the institutional design of the hospital system. The evidence confirms that organisational structure produces statistically significant and qualitatively distinct effects on the two dimensions of *output*: a hospital management policy that ignores this multidimensionality —whether by advocating full centralisation or wholesale decentralisation— aggregates effects of opposite sign and may lead to erroneous conclusions about the actual performance of hospitals. A policy informed by these results should incorporate separate indicators of efficiency in volume and intensity into regional performance contracts and into the terms of concession contracts, and extend activity-based payment adjusted for complexity to the entire contracted network. The results do not establish causality conclusively, since the assignment of hospitals to decentralised forms is not random, but they are consistent with the mechanisms predicted by the theoretical model and robust across the alternative specifications estimated. In any case, the thesis constitutes a first step towards a research agenda that integrates institutional, theoretical, and empirical analysis to understand the performance of the Spanish hospital system and guide its future design.

Keywords: hospital efficiency, stochastic frontier analysis, agency theory, multitasking, organizational structure, Spanish hospital system, health care management formulas, asymmetric information

JEL Classification: I11, I18, D82, D86, C23

Agradecimientos

[Pendiente de redacción]

Índice general

Resumen **i**

Abstract **v**

Agradecimientos **vii**

1. Introducción **1**

1.1. Planteamiento del problema 1

1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español 4

1.3. Objetivos y contribución 5

1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional 7

1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas . . 7

1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español 8

1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones . 9

1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España 10

1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español 11

1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA 12

1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica 12

1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada 14

1.5.3. Justificación de la forma funcional translog 14

1.6. Estructura de la tesis 15

2. Marco jurídico e institucional de la organización hospitalaria en España **17**

2.1. Actualidad y persistencia del debate sobre la organización hospitalaria 17

2.2. Fundamento constitucional y marco legal básico 19

2.2.1. El derecho a la protección de la salud y el margen de configuración legislativa 19

2.2.2. Distribución competencial y descentralización sanitaria . . 19

2.2.3. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) 20

2.2.4. Ley de Cohesión y Calidad (Ley 16/2003) 20

2.2.5. Ley 15/1997: habilitación de nuevas formas de gestión . . . 21

2.2.6. Real Decreto 29/2000: desarrollo reglamentario 22
2.2.7. Ley 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario . . . 22
2.2.8. Síntesis 22
2.3. Tipología de las formas de gestión y contratación hospitalaria . . 23
2.3.1. Gestión directa 23
2.3.2. Gestión indirecta y contratación con el sector privado . . . 25
2.3.3. Síntesis analítica 26
2.4. Régimen del personal, autonomía de gestión y gobernanza interna 27
2.4.1. El personal estatutario: marco general 27
2.4.2. Estructura retributiva y margen para incentivos 28
2.4.3. Personal laboral en entes instrumentales 28
2.4.4. Autonomía del gestor hospitalario 29
2.4.5. Directivos de hospital 29
2.4.6. Conexión con el modelo teórico 30
2.5. Financiación hospitalaria y verificabilidad del output 30
2.5.1. Presupuesto global retrospectivo 30
2.5.2. Contratos-programa 31
2.5.3. Pago por actividad: GRD y sistemas de clasificación de pacientes 31
2.5.4. Módulos de concierto 32
2.5.5. Pago capitativo 32
2.5.6. Conexión con el modelo teórico y la variable empírica . . . 33
2.6. Del lenguaje jurídico de la organización sanitaria al lenguaje económico de la agencia 33
2.6.1. El hospital como organización compleja con múltiples agentes 34
2.6.2. Estructura organizativa como estructura de agencia 35
2.6.3. Mecanismos de pago como señales de output 35
2.6.4. El parámetro ψ_{12} y la naturaleza del servicio 36
2.6.5. Síntesis de correspondencias 37
2.7. Conclusión: pluralismo organizativo, información asimétrica y necesidad de evaluación empírica 37

3. Modelo teórico: incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria 39
3.1. Introducción 39
3.2. Planteamiento del modelo 41
3.2.1. Los dos outputs y su asimetría 41
3.2.2. Preferencias de los agentes 42
3.2.3. El parámetro clave: ψ_{12} 42

3.3. La solución de primer *best* 43
3.4. Riesgo moral bajo estructura centralizada 44
3.4.1. Especificación funcional 44
3.4.2. Solución de segundo *best* centralizado 45
3.4.3. Implicaciones para distintos mecanismos de financiación . . 46
3.5. Riesgo moral bajo estructura descentralizada 47
3.5.1. El problema del hospital 48
3.5.2. El problema del principal 48
3.5.3. Caso especial: tareas independientes ($\psi_{12} = 0$) 48
3.6. Comparación de estructuras organizativas: simulaciones 49
3.6.1. Efecto del parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12}) . . . 50
3.6.2. Casos especiales: medición perfecta de uno de los outputs . 50
3.6.3. Efecto del ruido en la medición de la cantidad (σ_1) 51
3.6.4. Efecto del ruido en la medición de la intensidad (σ_2) . . . 51
3.7. Predicciones contrastables 52
3.8. Discusión y conexión con la literatura 54
3.8.1. Relación con Holmström-Milgrom (1991) 54
3.8.2. Relación con Jelovac-Macho-Stadler (2002) 55
3.8.3. Relación con Eggleston (2005) 55
3.8.4. Relación con Kaarboe-Siciliani (2011) 56
3.9. Conclusiones del modelo teórico 56

4. Estrategia empírica **61**
4.1. Motivación empírica 61
4.2. Marco general: análisis de frontera estocástica 61
4.3. Especificación de la frontera de producción 62
4.4. Ecuación de ineficiencia 63
4.5. Los cuatro diseños de estimación 64
4.5.1. Diseño D — Función de distancia output 64
4.5.2. Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad 65
4.5.3. Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico 66
4.5.4. Diseño C — Panel hospital × servicio 66
4.6. Estimación e inferencia 66
4.7. Justificación de las elecciones metodológicas adicionales 67
4.7.1. La función de distancia output frente a la función de producción 67
4.7.2. Efectos aleatorios verdaderos frente a efectos fijos 67
4.7.3. Tratamiento de la multicolinealidad en la especificación translog 68

5. Datos y variables **71**
5.1. Fuentes de datos 71
5.1.1. SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada) 71
5.1.2. CNH (Catálogo Nacional de Hospitales) 72
5.1.3. CMBD parcial (pesos GRD) 73
5.1.4. Consideraciones sobre protección de datos 73
5.2. Muestra de estimación 74
5.3. Descripción de las variables 75
5.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc}) 75
5.5. Estadísticos descriptivos 77
5.6. Las siete categorías del CNH y la construcción de D^{desc} 77
5.7. Distribución geográfica y temporal de la muestra 79
5.7.1. Distribución por comunidades autónomas 79
5.7.2. Distribución temporal 80
5.7.3. Tratamiento de los años COVID (2020–2022) 80
5.7.4. Estadísticos descriptivos por año 81
5.8. Construcción detallada de variables clave 82
5.8.1. El índice tecnológico K^T 82
5.8.2. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag} 83
5.8.3. La variable de estructura organizativa D^{desc} 84

6. Resultados **87**
6.1. Eficiencia técnica: valores medios 87
6.2. Diseño D: función de distancia output 88
6.3. Diseño A: cantidad versus intensidad 89
6.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos 92
6.5. Diseño C: panel hospital × servicio 93
6.6. Test P*: contraste conjunto 95
6.7. Interpretación económica integrada de los resultados 95
6.7.1. ¿Qué mide realmente el coeficiente de D^{desc}? 95
6.7.2. Interpretación del Diseño D: ineficiencia en el output compuesto 96
6.7.3. El papel de los parámetros estructurales β_k de la frontera . 97
6.7.4. Correlación entre ineficiencias: evidencia del mecanismo de sustitución 97

7. Robustez, tests de especificación y discusión **99**
7.1. Tests formales de especificación 99
7.2. Análisis de robustez 99
7.3. Síntesis de resultados 101

7.4. Interpretación económica de P2 101
7.5. Discusión económica adicional 102
7.5.1. La magnitud del efecto de la descentralización 102
7.5.2. La función de producción translog: interpretación de los coeficientes 102
7.5.3. El papel moderador de pct^{SNS} 103
7.5.4. La heterogeneidad regional en la ecuación de ineficiencia . 104
7.6. Limitaciones metodológicas 104

8. Implicaciones de política hospitalaria 107
8.1. Sobre la estructura organizativa 107
8.1.1. La descentralización no es unidimensionalmente superior . 107
8.1.2. La cautela ante las reversiones de concesiones 108
8.2. Sobre los mecanismos de pago 108
8.2.1. La potencia de los incentivos debe calibrarse al output relevante 108
8.2.2. Los incentivos al médico deben diseñarse en función de la estructura organizativa 109
8.3. Sobre la medición del output hospitalario 109
8.3.1. La necesidad de medir la intensidad 109
8.3.2. El papel de ψ_{12} en la política de servicios 110
8.4. Perspectiva internacional: lecciones de otros sistemas 110
8.4.1. El NHS inglés: separación de comprador y proveedor y *payment by results* 110
8.4.2. El sistema alemán de GRD (G-DRG) 111
8.4.3. Las reformas nórdicas: *patient choice* y competencia regulada 111
8.4.4. Implicaciones comparadas para España 111
8.5. Limitaciones de las recomendaciones 112
8.6. Cautelas para la interpretación de las recomendaciones de política 113
8.6.1. Endogeneidad de la estructura organizativa y sesgo de selección 113
8.6.2. Validez externa: ¿son generalizables los resultados? 113
8.6.3. Correlación versus causalidad 114
8.7. Hacia un diseño institucional informado por la evidencia 114

9. Conclusiones 117
9.1. Síntesis general 117
9.2. Contribuciones originales 118
9.3. Limitaciones y líneas de extensión 119
9.4. Agenda de investigación futura 120
9.4.1. Explotación de variación exógena para identificación causal 120

9.4.2. Extensión temporal y datos post-COVID 121
9.4.3. Vinculación con datos de procedimientos CMBD-RAE . . 121
9.4.4. Modelos de frontera con heterogeneidad persistente (Greene 2005) 122
9.4.5. Modelos de cópula para la dependencia entre dimensiones de eficiencia 122
9.4.6. Heterogeneidad sectorial y subespecialidades 123
9.5. Reflexión final 123

A. Simulaciones numéricas del modelo teórico 125
A.1. Variación en ψ_{12}: de complementariedad a sustitución 125
A.2. Casos especiales: medición perfecta 126
A.3. Variación en el ruido de cantidad (σ_1) 129
A.4. Variación en el ruido de intensidad (σ_2) 131

B. Construcción de variables y pipeline de datos 133
B.1. Estructura del proyecto 133
B.2. Orden de ejecución 133
B.3. Armonización de formatos TXT y XML 134
B.4. Proceso de *fuzzy matching* NCODI–CNH 134
B.5. Armonización de variables i_{diag}: validación de bridges C1_16 v3 . 135
B.6. Modelo de imputación de case-mix: detalles metodológicos 136
B.6.1. Variables predictoras 136
B.6.2. Procedimiento de estimación 136

C. Tablas complementarias 139
C.1. Coeficientes de la frontera de producción 139
C.2. Estadísticos descriptivos adicionales 140
C.3. Distribución de eficiencias técnicas por grupo de tamaño 140
C.4. Distribución de eficiencias técnicas 140
C.5. Notas sobre figuras 140

Índice de cuadros

2.1. Formas de gestión directa en el sistema hospitalario español . . . 24
2.2. Correspondencias entre categorías institucionales y parámetros del modelo de agencia . . . 37

3.1. Predicciones contrastables del modelo teórico . . . 54

4.1. Diseños de estimación y su papel en el análisis . . . 65

5.1. Variables del modelo SFA . . . 75
5.2. Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra Diseño A) . . . 77
5.3. Distribución de observaciones por categoría CNH y clasificación D^{desc} 79
5.4. Evolución temporal de variables principales (medias anuales, muestra Diseño A) . . . 82

6.1. Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa . 87
6.2. Diseño D: Ecuación de ineficiencia (ODF) . . . 88
6.3. Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad) . . . 89
6.4. Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico) . . . 92
6.5. Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio) . . 94
6.6. Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$ . . . 95

7.1. Tests formales de especificación . . . 99
7.2. Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad 100
7.3. Síntesis: predicciones del modelo vs. evidencia empírica . . . 101

B.1. Pipeline de scripts R . . . 133

C.1. Distribución de observaciones por comunidad autónoma y estructura organizativa . . . 140
C.2. Eficiencias técnicas por grupo de complejidad (Diseño A) . . . 141

Índice de figuras

3.1. Cronograma de la contratación bajo estructura centralizada. El principal contrata simultáneamente con el hospital ($b(q)$) y el médico ($w(q,i)$). 45
3.2. Cronograma de la contratación bajo estructura descentralizada. El principal solo contrata con el hospital ($b(q)+d\cdot i$); el hospital diseña autónomamente el contrato interno con el médico (B, D). 47

A.1. Incentivos óptimos para distintos valores de ψ_{12} 126
A.2. Diferencial de esfuerzos para distintos valores de ψ_{12} 127
A.3. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_1 = 0$ (medición perfecta de cantidad) 128
A.4. Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_2 = 0$ (medición perfecta de intensidad) 128
A.5. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 130
A.6. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$) 130
A.7. Incentivos óptimos cuando aumenta σ_2 ($\psi_{12} = 0.5$) 131
A.8. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas sustitutas, $\psi_{12} = 0.5$) 132
A.9. Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas complementarias, $\psi_{12} = -0.5$) 132

C.1. Distribución de eficiencias técnicas — muestra completa 141
C.2. Distribución de eficiencias técnicas por estructura organizativa. Azul: hospitales centralizados; rojo: hospitales descentralizados. . 141
C.3. Evolución temporal de la eficiencia técnica media en cantidad (Diseño A, estimador JLMS). Línea azul sólida: muestra principal 2010–2019. Línea gris discontinua: años COVID 2020–2022. Banda sombreada: ±1 desviación típica entre hospitales. 142

Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

La organización hospitalaria es un objeto de investigación particularmente exigente para la economía aplicada porque combina, en un mismo marco institucional, un mandato público de provisión y tutela de la salud y una realidad productiva y organizativa donde la relación entre recursos y resultados no se resume bien en un único indicador. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. Este punto de partida es normativo y finalista; es decir, no describe por sí mismo una tecnología hospitalaria ni prescribe un único diseño organizativo.

La legislación sanitaria básica concreta esa orientación con un doble movimiento: define estructuras, derechos y prestaciones, y al mismo tiempo, admite diversidad organizativa. La Ley 14/1986, General de Sanidad tiene por objeto la regulación de las acciones que permitan hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 43 CE y configura el hospital como un centro de atención especializada, en el que se integran funciones de internamiento clínico junto con actividades diagnósticas, terapéuticas y de apoyo a la atención sanitaria en su ámbito territorial. Por su parte, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece un catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y concibe la atención especializada de forma amplia, no limitada al internamiento hospitalario. El resultado es una definición legal del producto hospitalario necesariamente multidimensional: no solo estancias o intervenciones, sino un conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de continuidad asistencial, con componentes de calidad y seguridad que no se agotan en el volumen de actividad (Pemán Gavín, 2005).

Esta multidimensionalidad tiene consecuencias analíticas inmediatas. En un

entorno donde existen varias tareas y varios outputs relevantes, los mecanismos de incentivos y control enfrentan un problema estructural de medición y verificación. Por un lado, es posible medir con relativa facilidad ciertos *proxies* como actividad, tiempos de espera, listas, pero otras dimensiones —calidad clínica, adecuación diagnóstica, coordinación asistencial, experiencia del paciente— son costosas de observar y, sobre todo, de hacer contractualmente exigibles. En la teoría económica, esta tensión está en el centro de los modelos de agencia multitarea (Holmström y Milgrom, 1991) conforme a los cuales, cuando algunas tareas son más medibles que otras, los esquemas de incentivos pueden generar reasignaciones de esfuerzo hacia lo medible en detrimento de lo valioso pero difícil de verificar.[1] Esto justifica que la tesis plantee la organización hospitalaria no como un mero problema de asignación eficiente de inputs, sino como un problema de diseño institucional bajo información asimétrica y contratos inevitablemente incompletos.

Además, el hospital es una organización con múltiples agentes y niveles de decisión. El marco jurídico-institucional del sistema sanitario español se caracteriza por combinar un financiador público y una estructura administrativa compleja con arreglos de gestión que pueden asignar a distintas entidades —públicas o con técnicas de derecho privado— grados distintos de autonomía de dirección, contratación y gestión de personal (Domínguez Martín, 2006). En la cadena de provisión hospitalaria, el financiador público y la administración sanitaria fijan objetivos, reglas e instrumentos (presupuesto, cartera de servicios, indicadores), pero no observan perfectamente el esfuerzo clínico ni la calidad en todas sus dimensiones; la dirección del hospital traduce esos objetivos en organización interna y supervisión, condicionada por reglas de empleo y contratación; y los profesionales clínicos toman decisiones con alto contenido técnico bajo información local que no es plenamente transmisible. En términos económicos, esto configura una cadena de relaciones principal–agente donde la capacidad del principal para observar acciones y resultados es imperfecta, y donde cada eslabón opera condicionado por reglas de función pública, presupuestación, empleo estatutario o contratación pública.

La clave para esta tesis es que el ordenamiento español ha permitido, al menos desde finales de los años noventa, una pluralidad de fórmulas organizativas y de gestión en el ámbito sanitario público. Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, habilita la gestión

[1] En la literatura de gestión pública, este mecanismo recibe el nombre de *visión del túnel* (*tunnel vision*): la concentración de esfuerzo en los indicadores medibles desplaza la atención de dimensiones del desempeño igualmente relevantes pero no verificables (Smith, 1995). En el contexto hospitalario, la visión del túnel puede manifestarse cuando los esquemas de incentivos orientados al volumen de actividad —más fácilmente medible— reducen el esfuerzo dedicado a la intensidad diagnóstico-terapéutica, que es precisamente la asimetría que esta tesis contrasta empíricamente.

y administración de centros y servicios sanitarios de forma directa o indirecta a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho; el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud, desarrolla reglamentariamente esa habilitación, articulando órganos de gobierno y elementos de funcionamiento de las nuevas formas de gestión. En consecuencia, la forma de gestión no es un mero envoltorio legal si no que es un determinante potencial de la autonomía real del gestor, del reparto de riesgos, del régimen de control y de la capacidad contractual con terceros.

A esta arquitectura se superpone el régimen del personal. La Ley 55/2003 define el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud como base reguladora de una relación funcionarial especial, lo que sitúa el empleo estatutario en el núcleo de la gobernanza hospitalaria pública. La combinación de normas de personal, presupuestación y control administrativo condiciona de facto el conjunto de instrumentos disponibles para alinear incentivos: qué puede delegarse, qué puede retribuirse por desempeño, qué puede reorganizarse internamente y con qué márgenes temporales. Desde un punto de vista de teoría de contratos, esto refuerza la idea de incompletitud contractual. Incluso con voluntad de diseñar esquemas sofisticados, la capacidad de escribir y ejecutar contratos completos sobre todas las dimensiones relevantes del output hospitalario es limitada.

Este conjunto de rasgos mencionados —multitarea, multiagente, dificultades de verificación y diversidad organizativa— fundamenta la pregunta de investigación que vertebra esta tesis. El modelo teórico que se desarrolla en el Capítulo 3 formaliza esta estructura como un juego de tres agentes (financiador, hospital y médico) que producen conjuntamente dos *outputs* con tecnologías asimétricas (la cantidad de atención que depende del esfuerzo de hospital y médico y la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio que depende exclusivamente del esfuerzo del médico). La cuestión central es qué consecuencias tiene la arquitectura institucional y contractual sobre el desempeño diferencial en cada dimensión, en un contexto donde la medición del *output* es imperfecta y donde diferentes objetivos coexisten y pueden entrar en conflicto.

El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional en el que opera esta pluralidad organizativa. Sobre esa base, el modelo teórico trata de hacer una traslación de la diversidad institucional hacia parámetros económicos manejables, aunque indudablemente simplificadores, y prepara el terreno para la evaluación empírica mediante técnicas de frontera estocástica. Los resultados de esa evaluación, desarrollados en los Capítulos 4 a 7, permiten derivar implicaciones directas para el diseño de contratos hospitalarios y la regulación de las formas descentralizadas de gestión, que se abordan en el Capítulo 8.

1.2. Actualidad del debate y relevancia del caso español

La organización hospitalaria en España es un debate estructural, no una controversia coyuntural. La actualidad de 2026 lo ilustra al menos por dos vías complementarias: reformas normativas en tramitación y conflictividad profesional en torno al empleo y la gobernanza.

Con fecha 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó para su tramitación el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, cuya propia exposición institucional sitúa como objetivo reforzar la prioridad de la gestión pública directa, regular la gestión indirecta como excepcional y derogar expresamente la Ley 15/1997 (Ministerio de Sanidad, 2026b). Sin anticipar el resultado legislativo, el solo hecho de que se plantee una reforma de este alcance confirma que la arquitectura de la gestión —directa o indirecta, instrumentos de control, transparencia, reversión— sigue siendo un objeto de decisión política y jurídica de primer orden.

En paralelo, el Ministerio publicó en enero de 2026 el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario (Ministerio de Sanidad, 2026a), en un contexto de negociación y contestación por parte de las organizaciones profesionales médicas. En la práctica, 2026 ha visto convocatorias de huelga y movilizaciones ligadas a la reforma del Estatuto Marco y a la demanda de un marco regulatorio específico para la profesión médica. Desde el punto de vista de esta tesis, el interés de estos hechos no es su dimensión mediática, sino su contenido institucional al poner el foco en el régimen del personal, la dirección efectiva del trabajo clínico, la asignación de tiempos y guardias, y, en general, en cómo se estructura la autoridad dentro de las organizaciones sanitarias. Esto conecta directamente con el núcleo del análisis económico de la tesis: incentivos y esfuerzo en un entorno multitarea donde el desempeño no se puede observar completamente.

La relevancia del caso español para una tesis en economía aplicada se refuerza por su configuración institucional. El Sistema Nacional de Salud descansa sobre una estructura de provisión profundamente descentralizada, resultado de un proceso de transferencias sanitarias desde el antiguo INSALUD a las comunidades autónomas que culminó en enero de 2002, fecha a partir de la cual todas disponen de las competencias sanitarias previstas en el ordenamiento (Bernal-Delgado et al., 2024). El sistema se concibe como conjunto coordinado de los servicios de salud autonómicos, articulado mediante instrumentos de cohesión entre los que destaca el Consejo Interterritorial del SNS, órgano de coordinación integrado por la persona titular del Ministerio y los consejeros autonómicos de sanidad.

Esta combinación, *descentralización efectiva y coordinación institucionalizada*,

crea un entorno particularmente útil para el análisis comparado interno pues permite observar variación organizativa bajo un paraguas constitucional y legal común, concentrando el análisis en diferencias institucionalmente pertinentes sin el *ruido* de comparar sistemas sanitarios completamente distintos. El *European Observatory on Health Systems and Policies* describe el sistema español como descentralizado, con cobertura virtualmente universal, financiación principalmente impositiva y provisión predominantemente pública (Bernal-Delgado et al., 2024). Esta caracterización permite situar el caso español en una tipología internacional reconocible y justifica que la variación organizativa española pueda entenderse como una manifestación concreta de tensiones presentes en muchos sistemas sanitarios descentralizados.

El propio marco legal asume la necesidad de evaluación comparada. La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, prevé un Observatorio del Sistema Nacional de Salud con la función de proporcionar un análisis permanente de los servicios de salud autonómicos en ámbitos que incluyen organización, provisión, gestión y resultados. Esta previsión refuerza, creemos, la legitimidad de una tesis que se propone evaluar el desempeño hospitalario con enfoque empírico. En este sentido, la evaluación no es una imposición externa al sistema, sino una función prevista normativamente.

1.3. Objetivos y contribución

Los objetivos principales de este trabajo de tesis doctoral son cuatro:

(I) Sistematizar el marco jurídico e institucional que regula la organización hospitalaria en España y traducir sus categorías al lenguaje analítico de la teoría económica de la agencia, con el propósito de enriquecer el diálogo entre ambas disciplinas y proporcionar una base empírica rigurosa para la evaluación y el diseño de reformas normativas del sistema sanitario.

(II) Desarrollar un modelo teórico de agencia multitarea que caracterice las relaciones contractuales entre financiador, hospital y médico bajo riesgo moral, y que genere predicciones contrastables sobre los efectos diferenciales de la estructura organizativa en las dos dimensiones del output hospitalario.

(III) Diseñar y ejecutar una estrategia empírica que permita contrastar esas predicciones utilizando técnicas de frontera estocástica (SFA) con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023.

(IV) Derivar implicaciones de política sanitaria sobre el diseño de la estructura organizativa y los mecanismos de pago a hospitales, fundamentadas tanto

en la teoría como en la evidencia empírica.

En consonancia con la investigación llevada a cabo, la contribución de esta tesis es quíntuple.

En primer lugar, en el plano jurídico-institucional, la tesis sistematiza el marco normativo que regula la organización hospitalaria en España y lo traduce al lenguaje analítico de la teoría económica de la agencia. Esta traducción no es un ejercicio meramente descriptivo sino una operación metodológica que permite conectar categorías jurídicas como la forma de gestión, el régimen del personal o el mecanismo de financiación con parámetros económicos precisos cuyos efectos son empíricamente contrastables. La contribución es relevante tanto para la ciencia jurídica, que dispone así de evidencia empírica rigurosa para evaluar reformas normativas, como para la economía aplicada, que encuentra en el derecho sanitario español un laboratorio institucional de variación organizativa difícilmente disponible en otros sistemas.

En segundo lugar, en el plano teórico, el modelo desarrollado extiende los resultados clásicos de la teoría de la agencia en presentica de multitareas (Holmström y Milgrom, 1991) al caso de tres agentes y dos outputs producidos asimétricamente, derivando predicciones sobre la interacción entre estructura organizativa, tipo de pago y complementariedad/sustitución entre tareas que, hasta donde conocemos, no están disponibles en la literatura previa. En particular, el resultado de que el efecto de los incentivos en el hospital sea función de ψ_{12}, el parámetro de complementariedad o sustitución tecnológica entre tareas, en la estructura descentralizada pero no en la centralizada (*potencia de incentivos secuencialmente inducida*) es una contribución analítica nueva.

En tercer término, en el plano empírico, la estimación de un sistema de dos fronteras estocásticas, una para cada dimensión del output, constituye la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español. El diseño empírico permite identificar si los efectos de la descentralización son efectivamente de signo opuesto (o al menos asimétricos) entre la cantidad y la intensidad, algo que un modelo con un único término de ineficiencia no puede captar.

En cuarto lugar, en el plano metodológico, la tesis contribuye a la literatura de análisis de fronteras estocásticas (SFA) en el sector hospitalario al proporcionar cuatro diseños complementarios de estimación —función de distancia output, sistema bivariado cantidad/intensidad, sistema bivariado quirúrgico/médico y panel hospital×servicio— que explotan distintas fuentes de variación y permiten una triangulación de los resultados. Esta estrategia de triangulación es replicable y extensible a otros sistemas sanitarios con datos de estructura similar.

Finalmente, como quinta aportación y en el plano de política hospitalaria, la tesis proporciona criterios empíricamente fundamentados para el diseño de contratos entre financiadores públicos y proveedores hospitalarios. Los resultados permiten identificar el nivel óptimo de dependencia financiera del SNS en los contratos de concierto, distinguir qué tipos de servicio se benefician más de la autonomía descentralizada y justificar la incorporación de indicadores de intensidad diagnóstica en los contratos-programa autonómicos. Esta contribución adquiere especial relevancia en el contexto de las reformas normativas actualmente en tramitación, cuya evaluación de impacto puede apoyarse directamente en los resultados de esta investigación.

1.4. El sistema hospitalario español: contexto institucional

1.4.1. Estructura del SNS tras las transferencias autonómicas

El Sistema Nacional de Salud español, configurado por la Ley General de Sanidad de 1986, descansa sobre tres principios: universalidad, equidad y financiación pública. Hasta el año 2002, varias comunidades autónomas gestionaban ya sus propias redes hospitalarias (Cataluña desde 1981, Andalucía desde 1984, País Vasco y la Comunidad Valenciana desde 1987, Navarra desde 1990 y Galicia y las Islas Canarias desde 1994). La reforma del sistema de financiación autonómica aprobada en 2001 y efectiva en 2002 completó el proceso de transferencias sanitarias al conjunto de las comunidades autónomas, poniendo fin al INSALUD como gestor directo de los servicios sanitarios en las comunidades que permanecían bajo gestión central.

El resultado es un sistema descentralizado en el que diecisiete servicios autonómicos de salud ejercen la función de compradores de servicios hospitalarios dentro de sus respectivos territorios (Repullo y Freire, 2008). Esta estructura descentralizada ha generado una creciente heterogeneidad tanto en los modelos organizativos de los hospitales como en los mecanismos de pago y contratación del personal sanitario, haciendo del sistema hospitalario español un objeto de análisis especialmente rico para la economía de la salud.[2]

[2]Repullo y Freire (2008) advierten que este modelo de descentralización, aunque relativamente estable a corto plazo, plantea problemas estructurales de sostenibilidad y gobernabilidad. En particular, señalan la dificultad de aprovechar las economías de escala del sistema y de garantizar la equidad interterritorial, y proponen redefinir el papel del gobierno central como instancia de coordinación con capacidad efectiva para hacer converger los distintos servicios autonómicos de salud. Sin embargo, estas tensiones entre autonomía regional y cohesión sistémica son

1.4.2. Tipología de hospitales del sistema español

La diversidad organizativa del sistema hospitalario español puede clasificarse en cinco grandes categorías según la dependencia funcional y el régimen de gestión (Menéndez Rexach, 2008).

(I) **Hospitales públicos integrados del SNS:** Constituyen la columna vertebral del sistema. El personal es estatutario (funcionario o laboral especial) y las condiciones de contratación están sujetas a la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La financiación proviene del presupuesto del servicio autonómico de salud, generalmente mediante contratos-programa anuales que establecen objetivos de actividad y calidad. El hospital no tiene autonomía para fijar libremente retribuciones ni para despedir personal.

(II) **Fundaciones sanitarias públicas:** Surgieron en los años noventa como fórmula para introducir flexibilidad de gestión manteniendo la titularidad pública (Menéndez Rexach, 2008). Los trabajadores tienen contratos laborales ordinarios, lo que permite al hospital adaptar las plantillas y retribuciones con mayor agilidad. Galicia y Cataluña fueron las comunidades pioneras en este modelo, junto con experiencias posteriores en Baleares y La Rioja.[3]

(III) **Empresas públicas hospitalarias:** Entidades de titularidad íntegramente pública organizadas bajo formas de derecho privado o regímenes jurídico-organizativos híbridos, que presentan una mayor autonomía relativa de gestión respecto a los modelos administrativos tradicionales. Entre los ejemplos más relevantes se encuentran determinadas empresas públicas sanitarias y entes instrumentales como la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias o las agencias públicas empresariales en el ámbito autonómico andaluz. En estos modelos, el personal suele estar sujeto a un régimen laboral de derecho privado, lo que permite una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y, potencialmente, en el diseño de incentivos.

precisamente las que generan la variación institucional que esta tesis explota analíticamente.

[3]El régimen jurídico de las fundaciones sanitarias experimentó un giro relevante con la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo artículo 111 intentó reconducir al derecho público una modalidad que hasta entonces se había articulado como entidad de derecho privado en mano pública al amparo de la Ley de Fundaciones de 1994 (Ley 30/1994,de 24 de noviembre,de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general). La nueva figura, denominada fundación pública sanitaria, se configuró como organismo público asimilado a las entidades públicas empresariales, manteniendo la posibilidad de actuar en régimen de derecho privado en sus relaciones con terceros. Esta dualidad público-privada es precisamente la que genera la ambigüedad clasificatoria que se aborda en la Sección 5.6 al construir la variable D^{desc}.

(IV) **Concesiones administrativas (modelo Alzira):** La Comunidad Valenciana introdujo en 1999 la concesión administrativa del hospital de La Ribera (Alzira) a una empresa privada (inicialmente Adeslas-Ribera Salud), que asumía tanto la gestión hospitalaria como la atención primaria de su área de salud a cambio de una tarifa capitativa pactada por habitante y año. Este modelo, extendido posteriormente a otros hospitales valencianos (Torrevieja, Dénia, Manises, Vinalopó) y adaptado, con diferencias, en la Comunidad de Madrid, constituye uno de los ejemplos más avanzados de descentralización organizativa en el sistema sanitario español. En este esquema, el concesionario dispone de una amplia autonomía en la gestión de recursos humanos, incluyendo la contratación del personal bajo régimen laboral y el diseño de sistemas retributivos con componentes variables. Por ello, los hospitales gestionados bajo concesión administrativa representan un caso especialmente adecuado para el análisis empírico de estructuras descentralizadas en el marco del modelo teórico.

(V) **Hospitales privados concertados:** Hospitales de titularidad privada (con o sin ánimo de lucro) que prestan servicios al Sistema Nacional de Salud mediante contratos de concierto. Estos centros reciben una financiación pactada según distintas modalidades (por acto, proceso, estancia o combinaciones de las anteriores) y disponen de una amplia autonomía en la gestión de recursos humanos, al operar bajo un régimen laboral de derecho privado. Entre los ejemplos más representativos se encuentran numerosos centros vinculados a congregaciones religiosas y, en el caso catalán, hospitales integrados en la red sanitaria de utilización pública (SISCAT, anteriormente XHUP), caracterizada por la coexistencia de entidades de diversa naturaleza jurídica.

1.4.3. Evolución reciente: expansión y reversión de concesiones

El período 2003–2012 puede considerarse la fase de mayor expansión de los modelos de gestión privada en el sistema sanitario español. En particular, la Comunidad de Madrid impulsó la construcción de nuevos hospitales bajo fórmulas de colaboración público-privada, en las que la empresa privada asumía la financiación, construcción y gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la prestación clínica permanecía en manos de personal estatutario (Villar Rojas, 2009). Este modelo, menos descentralizado que las concesiones administrativas valencianas, contribuyó no obstante a ampliar de forma significativa la participación del sector privado en la provisión hospitalaria.

A partir de 2012, la crisis económica y el cambio de ciclo político dieron lugar a un proceso gradual y heterogéneo de revisión de estos modelos. En la Comunidad Valenciana, el hospital de Alzira revirtió a gestión pública en 2018, tras el vencimiento de la concesión y la decisión de no renovarla, en un contexto de debate sobre sus efectos en términos de costes y continuidad asistencial. Este proceso se extendió posteriormente a otros hospitales, como Torrevieja en 2021, dentro de una estrategia progresiva de reintegración en la red pública. En la Comunidad de Madrid, el proceso de externalización de hospitales fue abandonado en 2015 tras su suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Estas dinámicas han alimentado un intenso debate académico sobre los efectos de la estructura organizativa en la eficiencia del sistema sanitario (Martín et al., 2019), al que esta tesis pretende contribuir mediante evidencia empírica rigurosa.

1.4.4. Mecanismos de pago hospitalario en España

Los mecanismos de pago al hospital son un determinante central de los incentivos de eficiencia, tal como se enfatiza posteriormente en el modelo teórico. En el sistema hospitalario español coexisten tres grandes mecanismos a nivel general:

(a) **Presupuesto global retrospectivo:** Típico de los hospitales públicos integrados en la etapa anterior a los contratos-programa. El hospital recibe una asignación presupuestaria global, con escasa vinculación a la actividad realizada. Este esquema equivale al pago fijo del modelo teórico: los incentivos de volumen son débiles o inexistentes (García-Lacalle et al., 2009).

(b) **Contratos-programa con pago por actividad (GRD):** A partir de los años noventa, los servicios autonómicos de salud empezaron a vincular parte de la financiación hospitalaria a la actividad, utilizando los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) como unidad de medida de la complejidad del caso (Cots et al., 2001). El contrato-programa establece un volumen de actividad objetivo y una tarifa por GRD; los hospitales que superan el objetivo reciben una compensación adicional (a menudo a tarifa marginal reducida). En algunas comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco), este sistema de pago por actividad está relativamente desarrollado y se extiende también a los hospitales concertados.

(c) **Capitación ajustada:** Las concesiones administrativas de tipo Alzira se financian mediante una tarifa capitativa anual ajustada por el estado de salud de la población del área (Acerete et al., 2011). Este mecanismo crea incentivos radicalmente distintos a los anteriores: el hospital tiene incentivos

para reducir la utilización por episodio (eficiencia en intensidad) y para mantener a la población sana (prevención y atención primaria).

Esta diversidad de mecanismos de pago se refleja en la variable pct^{SNS} del modelo empírico: los hospitales con alta dependencia del SNS están sujetos predominantemente a financiación pública, aunque el contenido económico de esa dependencia difiere según la forma de gestión. En los hospitales integrados del SNS, pct^{SNS} alto refleja financiación mediante presupuesto global retrospectivo, con incentivos de volumen débiles. En los hospitales descentralizados con alta dependencia del SNS —fundamentalmente hospitales concertados— pct^{SNS} alto refleja actividad sujeta a contrato de actividad con tarifa prospectiva por alta, lo que genera incentivos de volumen moderados pero acotados por un techo contractual. En ambos casos, el aumento de pct^{SNS} reduce el margen de maniobra del gestor para actuar bajo lógica de mercado, aproximando los incentivos del hospital descentralizado a los del hospital integrado. Los hospitales privados de mercado con baja dependencia del SNS representan el polo opuesto: operan bajo esquemas de pago directo o de seguros privados, con plena autonomía de precios y sin restricciones contractuales de volumen.

1.4.5. Datos básicos del sistema hospitalario español

El sistema hospitalario español comprende, en el período analizado (2010–2023), aproximadamente 880 hospitales únicos con internamiento que han declarado actividad en el SIAE en algún momento del período, con una media anual de alrededor de 770 unidades informantes (Ministerio de Sanidad, 2026c). El SIAE clasifica los hospitales en función de su dependencia funcional y su relación con el SNS. La red de hospitales del SNS engloba los hospitales de dependencia pública, la red de hospitales de utilización pública, los hospitales con concierto sustitutorio —que funcionan como hospital de área con población asignada— y los hospitales de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (Ministerio de Sanidad, 2026c). Los hospitales privados son aquellos con dependencia funcional privada que carecen de concierto asistencial o lo tienen únicamente de forma parcial con el SNS. Los hospitales privados con más del 80 % de su actividad financiada con fondos públicos se clasifican como “Privado SNS”, categoría intermedia entre ambos extremos.

En términos cuantitativos, el peso asistencial se concentra netamente en el sector público: el SNS agrupa aproximadamente el 80 % de las camas hospitalarias en funcionamiento y una proporción similar de las altas totales, lo que refleja el mayor tamaño medio de los hospitales públicos. El número total de camas hospitalarias en funcionamiento registró una ligera tendencia descendente en

la primera mitad del período, pasando de aproximadamente 150.000 en 2010 a 139.000 en 2019, seguida de una recuperación moderada hasta aproximadamente 141.000 en 2022. El gasto total en asistencia hospitalaria ascendió en 2022 a aproximadamente 60.500 millones de euros, de los cuales el SNS representó en torno al 89 % (Ministerio de Sanidad, 2026c). El gasto sanitario público total representó en 2022 alrededor del 6,5 % del PIB, equivalente a unos 105.145 millones de euros, lo que supone aproximadamente tres de cada cuatro euros de gasto sanitario en España (ConSalud.es, 2025). El gasto sanitario privado en 2022 ascendió a unos 37.628 millones de euros, equivalente a aproximadamente el 28 % del gasto sanitario total, y se concentra principalmente en pagos directos de hogares, seguros privados e instituciones sin ánimo de lucro (BBVA, 2025).

En el marco del Sistema de Cuentas de Salud, la atención hospitalaria y especializada concentra una parte muy relevante del gasto público, con unos 60.000 millones de euros asociados a servicios hospitalarios y de atención especializada en 2023, según la Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad (de Sanidad, 2024). En cambio, el gasto privado desglosado específicamente por atención hospitalaria no está habitualmente disponible en términos de euros, sino que se aborda en términos de actividad y financiación mixta a través de estudios sectoriales sobre la sanidad privada y los conciertos con el SNS (BBVA, 2025; ConSalud.es, 2025).

La Comunidad de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de hospitales privados concertados, mientras que la distribución de concesiones administrativas se concentraba en la Comunidad Valenciana hasta las reversiones de 2018–2021.

1.5. Justificación metodológica: SFA versus DEA

1.5.1. Por qué análisis de frontera estocástica

La medición de la eficiencia hospitalaria puede abordarse mediante dos grandes familias de técnicas: el análisis envolvente de datos (DEA), de naturaleza no paramétrica, y el análisis de frontera estocástica (SFA), de naturaleza paramétrica (Coelli et al., 2005). La elección de SFA en esta tesis no es arbitraria; está justificada por cuatro razones metodológicas y una sustantiva.

Primera, el SFA distingue explícitamente entre ineficiencia técnica y ruido estadístico. Dado que los datos hospitalarios contienen errores de medición sustanciales —en particular en las variables de output como las altas ponderadas por case-mix— mezclar ruido e ineficiencia produciría estimaciones sesgadas. El DEA no tiene término de error aleatorio: toda desviación de la frontera se atribuye a ineficiencia. El SFA descompone la desviación en v_{it} (ruido) y u_{it} (ineficiencia), lo que es más

apropiado cuando la variable de output es una medida imperfecta del output verdadero (Aigner et al., 1977; Meeusen y van den Broeck, 1977; Kumbhakar y Lovell, 2000).

Segunda, la disponibilidad de datos de panel para el período 2010–2023 permite explotar la variación temporal dentro del hospital para identificar los efectos de los determinantes de la ineficiencia. El SFA de panel con efectos heterogéneos en la media de la distribución de ineficiencia (Battese y Coelli, 1995; Wang y Schmidt, 2002) es el marco natural para este análisis. Las extensiones de panel del DEA (DEA de Malmquist) no permiten incorporar covariables de la ineficiencia de forma tan directa.

Tercera, el SFA produce errores estándar para los coeficientes de la ecuación de ineficiencia, lo que permite contrastar formalmente las predicciones del modelo teórico (tests t, LR, Kodde-Palm). El DEA no tiene distribución muestral conocida para los índices de eficiencia, aunque Simar y Wilson (2007) propone métodos de bootstrap; sin embargo, estos métodos no están disponibles para modelos con covariables en la ecuación de ineficiencia de panel. Para una presentación exhaustiva de las opciones de estimación SFA, véanse Kumbhakar y Lovell (2000) y Greene (2008).

Cuarta, la función de producción translog especificada en el Capítulo 4 tiene una justificación económica directa: permite testar restricciones de curvatura (simetría de las segundas derivadas, rendimientos de escala), estimar elasticidades de sustitución y verificar la consistencia con la teoría de la producción. El DEA no impone ninguna estructura paramétrica a la tecnología, lo que es una ventaja general pero en este contexto específico supone renunciar a las restricciones teóricas que el modelo justifica.

La razón sustantiva es que el objetivo del análisis no es simplemente clasificar hospitales por eficiencia, sino contrastar predicciones de un modelo teórico sobre los determinantes de la ineficiencia. Para ello se necesita un modelo paramétrico que vincule las variables institucionales (estructura organizativa, mecanismo de pago, interacción entre tareas) con la distribución de la ineficiencia a través de una ecuación de media heterogénea. Este tipo de análisis es genuinamente SFA.

En el plano metodológico, Jacobs (2001) compara DEA y SFA sobre el mismo conjunto de datos hospitalarios del NHS y concluye que ambos métodos tienen fortalezas específicas y miden potencialmente aspectos distintos de la eficiencia, recomendando el uso de varias especificaciones como señales de ineficiencia en lugar de estimaciones puntuales. La presente tesis adopta exclusivamente SFA porque, a diferencia del DEA, permite descomponer la desviación respecto a la frontera en ineficiencia y ruido aleatorio, condición necesaria para la inferencia estadística sobre los determinantes institucionales de la ineficiencia que el modelo teórico requiere

contrastar. En un trabajo reciente sobre hospitales públicos españoles, Arbelo-Pérez et al. (2025) refuerzan esta elección argumentando que la SFA es preferible en el contexto hospitalario porque permite desentrañar la heterogeneidad subyacente en las medidas de eficiencia, capturando factores estocásticos y errores de medición que el DEA atribuye mecánicamente a ineficiencia. En una dirección complementaria, Prior (2006) argumenta mediante un modelo dinámico de frontera que la medición de la eficiencia hospitalaria debe incorporar explícitamente variables de calidad junto con las de cantidad, mostrando que ignorar la dimensión cualitativa sesga las estimaciones de eficiencia técnica. La presente tesis extiende esa aproximación en dos dimensiones no cubiertas por la literatura existente: la estimación simultánea de dos fronteras diferenciadas para cantidad e intensidad, y la incorporación de la estructura organizativa como determinante de la ineficiencia con predicciones asimétricas entre dimensiones del *output*.

1.5.2. Ventajas del panel sobre la sección cruzada

El uso de datos de panel (2010–2023) frente a una sección cruzada tiene ventajas sustanciales en el contexto de esta investigación. *Primera*, permite separar la heterogeneidad no observada permanente del hospital de la ineficiencia transitoria (Greene, 2005). Un hospital que siempre opera por debajo de la frontera puede reflejar diferencias tecnológicas permanentes (calidad del equipamiento, localización, cartera de servicios) más que ineficiencia propiamente dicha. *Segunda*, la variación temporal en la variable D^{desc} —derivada principalmente de los cambios en la dependencia funcional registrada en el CNH y de las entradas y salidas de hospitales de la muestra— proporciona identificación adicional del efecto causal de la estructura organizativa sobre la ineficiencia. *Tercera*, el panel permite estimar tendencias de progreso técnico (t y t^2 en la frontera) y controlar cambios macro que afectan a todos los hospitales simultáneamente (reformas regulatorias, crisis económica, COVID).

1.5.3. Justificación de la forma funcional translog

La forma funcional translog (Zuckerman et al., 1994; Linna, 1998) es la estándar en la literatura de eficiencia hospitalaria por tres razones. *Primera*, es una aproximación de segundo orden a cualquier función de producción continua, sin imponer restricciones apriorísticas sobre la curvatura. Esto es importante en hospitales, donde las economías de escala y la complementariedad entre inputs son difícilmente conocidas *ex ante*. *Segunda*, a diferencia de la especificación Cobb-Douglas, permite que las elasticidades de los inputs varíen con el nivel de los inputs, lo que es empíricamente relevante cuando la muestra incluye hospitales

muy heterogéneos en tamaño (de 50 a más de 2.000 camas). *Tercera*, los tests de razón de verosimilitud reportados en la Tabla 7.1 rechazan la Cobb-Douglas frente a la translog en los cuatro diseños de estimación con estadísticos entre 247 y 594.

1.6. Estructura de la tesis

La tesis se organiza del siguiente modo. El Capítulo 2 sistematiza el marco jurídico-institucional de la organización hospitalaria en España: el fundamento constitucional, la tipología de formas de gestión, el régimen del personal, los mecanismos de financiación y la traducción de estas categorías al lenguaje económico de la agencia. El Capítulo 3 presenta el modelo teórico de agencia multitarea: el planteamiento del juego, la solución de primer *best*, los resultados bajo riesgo moral en estructuras centralizadas y descentralizadas, y las predicciones contrastables derivadas del equilibrio. Las simulaciones numéricas detalladas se presentan en el Anexo A, aunque las conclusiones principales se resumen en el cuerpo del capítulo.

El Capítulo 4 desarrolla la estrategia empírica: el marco del análisis de frontera estocástica, la especificación de la frontera de producción y de la ecuación de ineficiencia, y los cuatro diseños de estimación con sus respectivos roles en el análisis.

El Capítulo 5 describe los datos y las variables: las fuentes de información (SIAE, CNH, CMBD), la construcción de las variables principales y la muestra de estimación.

El Capítulo 6 presenta los resultados principales de los cuatro diseños de estimación y los tests formales de hipótesis.

El Capítulo 7 reporta los análisis de robustez, los tests de especificación y una discusión detallada de la interpretación económica de los resultados.

El Capítulo 8 deriva implicaciones de política hospitalaria a partir de los resultados teóricos y empíricos.

El Capítulo 9 recoge las conclusiones generales, las limitaciones de la investigación y las líneas de extensión futura.

Capítulo 2

Marco jurídico e institucional de la organización hospitalaria en España

2.1. Actualidad y persistencia del debate sobre la organización hospitalaria

El debate sobre cómo debe organizarse la gestión hospitalaria pública en España no es un fenómeno reciente. Desde que la Ley 15/1997 habilitó de forma explícita la gestión de centros y servicios sanitarios públicos mediante cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho, el sistema hospitalario español ha acumulado casi tres décadas de experimentación institucional con fórmulas organizativas diversas: fundaciones sanitarias públicas, empresas públicas, consorcios, concesiones administrativas y distintas modalidades de concierto con el sector privado. Esta trayectoria no ha sido lineal: ha alternado fases de expansión de las formas de gestión indirecta con fases de reversión hacia la gestión directa, en un proceso marcado tanto por consideraciones de eficiencia como por cambios en las mayorías políticas autonómicas.

La actualidad de 2026 confirma que la organización hospitalaria sigue siendo un objeto de decisión política y jurídica de primer orden. Dos iniciativas normativas en tramitación ilustran este punto con claridad.

En primer lugar, el 10 de febrero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de Sanidad, 2026b). Según la exposición institucional del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto tiene como objetivos principales garantizar la prioridad de la gestión pública directa en la provisión de servicios sanitarios, regular la gestión indirecta como modalidad excepcional sometida a requisitos

reforzados de justificación y transparencia, y derogar expresamente la Ley 15/1997. Con independencia del resultado del proceso legislativo, la sola tramitación de una reforma de este alcance —que pretende sustituir el marco habilitante que ha regido durante tres décadas— evidencia que las reglas de organización hospitalaria no son un dato fijo del entorno institucional, sino una variable sometida a revisión periódica.

En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad publicó en enero de 2026 el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ministerio de Sanidad, 2026a), con el propósito de actualizar el régimen establecido por la Ley 55/2003. El borrador ha generado un proceso de negociación con las organizaciones sindicales y profesionales médicas que, en la práctica, ha derivado en convocatorias de huelga y movilizaciones durante el primer trimestre de 2026. Desde la perspectiva de esta tesis, el interés de estos hechos reside en su contenido institucional más que en su dimensión mediática: el conflicto pone el foco en el régimen del personal sanitario, la dirección efectiva del trabajo clínico, la asignación de tiempos y guardias, y, en general, en cómo se estructura la autoridad dentro de las organizaciones hospitalarias. Estas son precisamente las variables que determinan la capacidad del gestor hospitalario para diseñar incentivos y modular el esfuerzo de los profesionales —el núcleo del análisis económico de esta tesis.

A estas reformas en tramitación se suma la experiencia acumulada de las reversiones de concesiones administrativas en la Comunidad Valenciana. El modelo de concesión integral inaugurado con el Hospital de La Ribera (Alzira) en 1999 se extendió durante la década de 2000 a otros centros valencianos (Torrevieja, Dénia, Manises, Vinalopó). Sin embargo, a partir de 2018, la Generalitat Valenciana inició un proceso sistemático de reversión: el Hospital de La Ribera fue revertido en 2018, el Hospital de Torrevieja en 2021 y el Hospital de Dénia en 2024. El Hospital de Manises completó su reversión en 2024, mientras que la concesión del Hospital del Vinalopó fue prorrogada hasta 2030. Estas reversiones —confirmadas judicialmente en varios casos, entre ellos por la STS 952/2021 relativa a Alzira— constituyen evidencia empírica de que las formas de gestión hospitalaria no son irreversibles: son decisiones institucionales sujetas a revisión, lo que refuerza la pertinencia de evaluar sus consecuencias sobre el desempeño.

La conclusión de esta breve revisión es directa: si las reglas organizativas no importaran para el funcionamiento de los hospitales, no serían objeto recurrente de reforma legislativa ni de conflicto profesional. Esta tesis analiza precisamente en qué medida esas reglas —la forma de gestión, el régimen del personal, el mecanismo de financiación— afectan al desempeño hospitalario en sus distintas dimensiones.

2.2. Fundamento constitucional y marco legal básico

2.2.1. El derecho a la protección de la salud y el margen de configuración legislativa

El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Este precepto se ubica entre los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I), lo que implica que no configura un derecho fundamental directamente invocable ante los tribunales mediante recurso de amparo, sino un mandato al legislador y a los poderes públicos que, conforme al artículo 53.3 CE, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

La consecuencia analíticamente relevante es que el artículo 43 CE establece un fin —la protección de la salud— y atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de organizar y tutelar, pero no constitucionaliza una única forma de organización de los servicios sanitarios. Existe un amplio margen de configuración legislativa: el legislador puede optar por modelos de gestión directa, indirecta o mixta, siempre que se garantice la efectividad del derecho y se respeten los principios de igualdad (art. 14 CE) y universalidad en el acceso. Esta apertura constitucional es la que ha permitido la diversidad organizativa que caracteriza al sistema hospitalario español y que esta tesis explota analíticamente.

2.2.2. Distribución competencial y descentralización sanitaria

La distribución de competencias en materia sanitaria entre el Estado y las comunidades autónomas se articula mediante dos preceptos constitucionales. El artículo 149.1.16.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. El artículo 148.1.21.ª CE permite a las comunidades autónomas asumir competencias en sanidad e higiene, lo que se ha desarrollado en los respectivos Estatutos de Autonomía.

El resultado práctico ha sido un proceso de transferencias sanitarias que se inició con Cataluña en 1981 y se completó en enero de 2002 con la asunción de competencias por las diez comunidades autónomas que aún permanecían bajo la gestión directa del INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). A partir de esa

fecha, los diecisiete servicios autonómicos de salud —más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— ejercen la función de planificación, financiación y provisión de servicios sanitarios en sus respectivos territorios (Bernal-Delgado et al., 2024). La disolución del INSALUD como gestor directo supuso el fin de un modelo centralizado de provisión y el inicio de una etapa de heterogeneidad institucional en la que cada comunidad autónoma ha podido configurar su red hospitalaria con arreglos organizativos propios, dentro del marco de la legislación básica estatal.

2.2.3. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986)

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE-A-1986-10499), constituye la norma fundacional del Sistema Nacional de Salud. Sus preceptos más relevantes para el análisis de la organización hospitalaria son los siguientes.

El artículo 44 define el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, integrados y coordinados bajo los principios de universalidad, equidad, calidad y participación. El artículo 56 define el hospital como el establecimiento encargado tanto del internamiento clínico como de la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia. Los artículos 65 a 67 estructuran la organización territorial en áreas de salud, cada una con al menos un hospital general, y prevén la vinculación de hospitales privados al sistema público mediante distintas fórmulas. El artículo 90 regula la contratación de servicios con hospitales privados mediante conciertos, estableciendo que los centros concertados deben cumplir los mismos requisitos de calidad, control y accesibilidad que los centros públicos.

La Ley General de Sanidad configuró así un sistema de provisión predominantemente pública, pero abierto desde su origen a la participación del sector privado mediante conciertos, un rasgo que ha condicionado toda la evolución posterior (Pemán Gavín, 2005).

2.2.4. Ley de Cohesión y Calidad (Ley 16/2003)

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE-A-2003-10715), fue la respuesta legislativa a la necesidad de articular un marco de coordinación tras la culminación de las transferencias sanitarias. Sus principales aportaciones son:

El artículo 7 establece un catálogo de prestaciones del SNS que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención especializada, la atención sociosanitaria, la atención de urgencias y las prestaciones farmacéuticas. El artículo 8 regula la cartera común de servicios, distinguiendo entre básica, suplementaria y de

servicios accesorios. Esta definición amplia de las prestaciones —que va más allá del internamiento— tiene una consecuencia analítica directa: el producto hospitalario no se agota en el número de altas o estancias, sino que incluye dimensiones de calidad, adecuación diagnóstica y continuidad asistencial que son difícilmente reducibles a un indicador único.

Los artículos 69 a 73 regulan el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano de coordinación integrado por la persona titular del Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos responsables de sanidad, con funciones de coordinación, cooperación y definición de posiciones comunes. El artículo 63 crea el Observatorio del Sistema Nacional de Salud, con la función de proporcionar un análisis permanente del SNS mediante estudios comparados de los servicios de salud autonómicos en ámbitos que incluyen la organización, la provisión, la gestión y los resultados. Esta previsión legal de evaluación comparada refuerza la legitimidad de una tesis que se propone evaluar el desempeño hospitalario con enfoque empírico.

2.2.5. Ley 15/1997: habilitación de nuevas formas de gestión

La Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (BOE-A-1997-9021), es una norma breve —un artículo único y una disposición adicional— pero de extraordinaria importancia para el objeto de esta tesis. Su artículo único establece:

> *La gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho.*

La formulación es deliberadamente abierta: no enumera un catálogo cerrado de formas jurídicas, sino que habilita cualquier entidad de naturaleza o titularidad pública. Esta apertura proporcionó la base legal para la proliferación de formas de gestión que se produjo en los años siguientes: fundaciones públicas sanitarias, empresas públicas, consorcios, sociedades mercantiles de capital público y, mediante interpretación extensiva, concesiones administrativas a entidades privadas para la gestión de centros sanitarios públicos.

2.2.6. Real Decreto 29/2000: desarrollo reglamentario

El Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del INSALUD, desarrolló reglamentariamente la habilitación de la Ley 15/1997 en el ámbito del entonces existente INSALUD. El RD articuló cuatro figuras organizativas específicas: fundaciones públicas sanitarias, consorcios, sociedades estatales y otras entidades de Derecho público. Para cada una estableció reglas sobre órganos de gobierno, régimen patrimonial, contratación de personal y mecanismos de control. Aunque el RD 29/2000 fue concebido para el INSALUD (disuelto en 2002 tras las transferencias), sus categorías organizativas sirvieron de referencia para las comunidades autónomas en el diseño de sus propios modelos de gestión.

2.2.7. Ley 55/2003: Estatuto Marco del personal estatutario

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE-A-2003-23101), regula la relación de empleo del personal estatutario como una relación funcionarial de carácter especial. La Ley establece las normas sobre acceso (mediante oferta pública de empleo y procedimientos de selección), provisión de plazas, retribuciones (básicas y complementarias), jornada, permisos, situaciones administrativas y régimen disciplinario. La importancia de esta norma para el análisis de la tesis se desarrolla en la Sección 2.4.

2.2.8. Síntesis

El ordenamiento configura un sistema sanitario con fines públicos —protección de la salud, universalidad, equidad— pero formas jurídicas plurales para la organización de la provisión. La Constitución no constitucionaliza un único modelo de gestión; la legislación básica habilita la diversidad organizativa; y las comunidades autónomas disponen de amplias competencias para diseñar sus redes hospitalarias. La STC 84/2015, al resolver un recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones de la legislación sanitaria madrileña, confirmó que la opción por la gestión indirecta de servicios sanitarios no es per se inconstitucional, siempre que se respeten las bases estatales y los principios de igualdad y universalidad del sistema.

Esta pluralidad organizativa —habilitada normativamente, no accidental— es la que genera la variación institucional que la tesis explota analíticamente. El siguiente paso es describir las formas concretas que esa pluralidad ha adoptado en la práctica.

2.3. Tipología de las formas de gestión y contratación hospitalaria

2.3.1. Gestión directa

El hospital integrado en el servicio de salud autonómico

La forma organizativa predominante en el sistema hospitalario español es el hospital público integrado directamente en el servicio de salud de la comunidad autónoma correspondiente. Estos centros carecen de personalidad jurídica propia: son unidades orgánicas del servicio autonómico de salud, sujetas íntegramente al Derecho público en materia de contratación, presupuestación, gestión de personal y control del gasto. Su personal es estatutario (Ley 55/2003), seleccionado mediante oferta pública de empleo, con retribuciones fijadas en mesas sectoriales autonómicas y sujeto a intervención previa del gasto por la intervención general de la comunidad autónoma.

Desde la perspectiva del análisis de incentivos, el hospital integrado representa el extremo del gradiente de autonomía: la dirección del centro dispone de un margen muy limitado para modular las condiciones de trabajo o la retribución del personal médico. Las decisiones sobre plantillas, retribuciones complementarias, carrera profesional y selección de personal se adoptan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

Entes instrumentales con personalidad jurídica propia

Dentro de la gestión directa —entendida como gestión mediante entidades de titularidad pública— existen formas organizativas con personalidad jurídica propia y distintos grados de autonomía. Las principales son:

Organismos autónomos y entidades públicas empresariales. El caso más relevante es Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), configurada como ente público de Derecho privado, lo que le permite una mayor flexibilidad en la contratación y gestión del personal, aunque la práctica ha convergido hacia un régimen próximo al estatutario. En Cataluña, el Institut Català de la Salut (ICS) es una empresa pública adscrita al Departament de Salut que gestiona directamente los hospitales y centros de atención primaria de mayor tamaño.

Consorcios sanitarios. Cataluña ha desarrollado un modelo organizativo singular basado en consorcios sanitarios —entidades de Derecho público con participación de diversas administraciones y, en algunos casos, entidades privadas sin ánimo de lucro— que gestionan hospitales y otros centros asistenciales. La Ley 15/1990, de Ordenación Sanitaria de Cataluña, configuró un sistema plural de

provisión articulado en torno al Servei Català de la Salut (CatSalut) como entidad aseguradora-compradora, que contrata servicios con una red diversa de proveedores: el ICS (gestión directa), consorcios, fundaciones, hospitales municipales, entidades religiosas y centros privados concertados. El sistema se articula a través del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya), que integra a todos los proveedores acreditados.

Fundaciones públicas sanitarias. El Real Decreto 29/2000 articuló las fundaciones públicas sanitarias como una de las nuevas formas de gestión del INSALUD. En Galicia, cinco hospitales fueron constituidos como fundaciones públicas sanitarias durante los años 2000, con personal laboral y mayor autonomía de gestión. Sin embargo, entre 2007 y 2008, la Xunta de Galicia procedió a la extinción de estas fundaciones y a la integración de sus centros en la red del SERGAS (Servizo Galego de Saúde), con la consiguiente estatutarización del personal.

Empresas públicas. En Andalucía, varias Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES) gestionaron hospitales y otros centros durante más de una década con personal laboral sujeto a convenio colectivo propio. A partir de 2019, la Junta de Andalucía inició un proceso de liquidación de estas agencias y de integración de sus centros y personal en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), proceso que se completó entre 2020 y 2022.

Estos ejemplos autonómicos ilustran un patrón relevante para el análisis: las formas de gestión con mayor autonomía (fundaciones, empresas públicas) han experimentado en varios casos un proceso de reversión hacia la gestión integrada con personal estatutario, lo que indica que la tendencia institucional predominante ha sido hacia la homogeneización del régimen de gestión directa.

Cuadro 2.1: Formas de gestión directa en el sistema hospitalario español

Naturaleza jurídica	**Régimen de personal**	**Grado de autonomía**	**Ejemplos**
Hospital integrado en servicio de salud	Estatutario	Muy limitada	Mayoría de hospitales SNS
Organismo autónomo / EPE	Estatutario o laboral	Media	Osakidetza, ICS
Consorcio sanitario	Laboral (convenio propio)	Media-alta	Consorcios catalanes
Fundación pública sanitaria	Laboral	Alta	Fundaciones gallegas (extintas)
Empresa pública	Laboral (convenio propio)	Alta	APES andaluzas (liquidadas)
Sociedad mercantil pública	Laboral	Alta	Casos puntuales

2.3.2. Gestión indirecta y contratación con el sector privado

Concesión administrativa

La concesión administrativa de servicios sanitarios ha adoptado en España dos modalidades principales que es imprescindible distinguir analíticamente.

La primera es la *iniciativa de financiación privada* (PFI, por sus siglas en inglés), en la que una empresa privada construye y financia la infraestructura hospitalaria y gestiona los servicios no clínicos (mantenimiento, limpieza, restauración, logística), mientras que la asistencia sanitaria es prestada por personal estatutario del servicio de salud. La Comunidad de Madrid aplicó este modelo en la construcción de siete nuevos hospitales entre 2005 y 2008. En este esquema, la dirección clínica sigue siendo pública y el régimen del personal es estatutario, por lo que la autonomía del gestor para diseñar incentivos del personal médico no difiere sustancialmente de la del hospital integrado.

La segunda modalidad es la *concesión integral*, cuyo modelo paradigmático es el Hospital de La Ribera (Alzira, Valencia), inaugurado en 1999. En la concesión integral, el concesionario privado asume la gestión completa del hospital —incluida la asistencia clínica— a cambio de un pago capitativo por habitante asignado al área de salud. El concesionario selecciona y contrata al personal con régimen laboral, diseña autónomamente los esquemas retributivos internos y asume el riesgo económico de la gestión. La Comunidad Valenciana extendió este modelo a otros cuatro hospitales: Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2009) y Vinalopó (2010).

Como se ha señalado en la Sección 2.1, la Comunidad Valenciana inició a partir de 2018 un proceso de reversión de estas concesiones. El Hospital de La Ribera fue revertido en abril de 2018 al expirar la concesión; el Hospital de Torrevieja fue revertido en octubre de 2021, tras un proceso contencioso confirmado judicialmente (STS 952/2021); el Hospital de Dénia fue revertido en 2024; y el Hospital de Manises completó su reversión en 2024. La concesión del Hospital del Vinalopó fue prorrogada hasta 2030. En la Comunidad de Madrid, además de los hospitales PFI, se desarrollaron cuatro concesiones con componente de gestión clínica, aunque con modelos heterogéneos.

Desde la perspectiva del modelo de agencia de esta tesis, la concesión integral es el caso empíricamente más limpio de estructura descentralizada: el financiador público contrata con el concesionario (hospital) para un nivel de servicio, y el concesionario diseña autónomamente los contratos del personal médico. El pago capitativo, además, genera incentivos específicos sobre la eficiencia en intensidad (contención del coste por episodio) que difieren de los incentivos generados por el

pago por actividad.

Concierto sanitario

El concierto sanitario es el instrumento clásico de contratación de servicios hospitalarios con el sector privado, previsto en los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad. Mediante el concierto, el servicio de salud autonómico contrata con un hospital privado la prestación de servicios asistenciales a pacientes del SNS, a cambio de un precio pactado por módulos de actividad (precio por estancia, por alta, por procedimiento o por consulta).

El hospital concertado mantiene plena autonomía sobre la contratación y retribución de su personal —que se rige por el Derecho laboral ordinario— y gestiona internamente sus recursos de acuerdo con su propia estructura organizativa. Sin embargo, su actividad para el SNS está sujeta a los módulos de precio fijados por la administración sanitaria y a los controles de calidad y accesibilidad que establezca el concierto. La red de hospitales concertados es particularmente extensa en Cataluña (donde forma parte del SISCAT) y en la Comunidad de Madrid.

Acción concertada

Algunas comunidades autónomas han desarrollado en los últimos años una modalidad de contratación denominada *acción concertada*, que se diferencia del concierto clásico en aspectos formales y procedimentales. La acción concertada se concibe como un régimen específico para la contratación de servicios sanitarios con entidades privadas, con requisitos propios de acreditación, precios regulados y obligaciones de información. Aunque su extensión es aún limitada, representa una evolución del marco contractual entre el sector público y el privado en materia sanitaria.

2.3.3. Síntesis analítica

La descripción precedente no pretende agotar la taxonomía de formas de gestión hospitalaria en España, sino identificar la variable institucional más relevante para el análisis económico de esta tesis: el *gradiente de autonomía* del gestor hospitalario para diseñar la estructura interna de incentivos.

En un extremo del gradiente se sitúa el hospital público integrado, con personal estatutario, retribuciones centralizadas y escasa autonomía del gestor para modular incentivos individuales. En el otro extremo se sitúan las concesiones integrales y los hospitales privados de mercado, donde la dirección del centro selecciona, contrata y retribuye al personal con plena autonomía, sujeta únicamente al marco

laboral general. Entre ambos extremos se ubican las fundaciones, consorcios, empresas públicas y hospitales concertados, con grados intermedios de autonomía que dependen de su naturaleza jurídica, del convenio colectivo aplicable y de la práctica de gestión.

Las variables institucionales analíticamente relevantes para el modelo de agencia de esta tesis son cuatro:

(I) *Autonomía del gestor para diseñar contratos internos*: determina si el hospital puede vincular la retribución del médico al desempeño y en qué medida.

(II) *Régimen de personal* (estatutario versus laboral): condiciona los instrumentos de contratación, selección y retribución disponibles.

(III) *Reparto de riesgos entre financiador y proveedor*: un hospital financiado por presupuesto global no soporta riesgo de actividad; un hospital con pago capitativo soporta riesgo económico completo.

(IV) *Capacidad de supervisión del financiador*: los mecanismos de control varían desde la intervención previa del gasto (hospitales integrados) hasta el control ex post mediante indicadores contractuales (concesiones y conciertos).

La variable empírica D^{desc} de la estimación econométrica (Capítulo 5) operacionaliza el gradiente de autonomía mediante una clasificación dicotómica que distingue hospitales centralizados (gestión directa con personal estatutario) de hospitales descentralizados (gestión indirecta o privada con mayor autonomía contractual). El Diseño B refina esta clasificación en tres categorías con anclaje económico más preciso.

2.4. Régimen del personal, autonomía de gestión y gobernanza interna

2.4.1. El personal estatutario: marco general

La Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (BOE-A-2003-23101), regula la relación de empleo del personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Esta relación se configura como una relación funcionarial de carácter especial, distinta tanto de la relación funcionarial general (regulada por el EBEP) como de la relación laboral ordinaria (regulada por el Estatuto de los Trabajadores).

El acceso al empleo estatutario se realiza mediante oferta pública de empleo (OPE) y procedimientos de selección (oposición, concurso-oposición o concurso) convocados por las comunidades autónomas, con plazos que en la práctica pueden extenderse durante varios años desde la convocatoria hasta la toma de posesión. Esta rigidez temporal en la selección limita la capacidad de la dirección hospitalaria para adaptar las plantillas a las necesidades asistenciales cambiantes.

2.4.2. Estructura retributiva y margen para incentivos

La estructura retributiva del personal estatutario se compone de retribuciones básicas —sueldo base y trienios, fijados a nivel estatal— y retribuciones complementarias, entre las que se incluyen el complemento de destino, el complemento específico y el complemento de productividad variable. Este último es, en principio, el instrumento disponible para vincular parte de la retribución al desempeño individual o colectivo.

Sin embargo, en la práctica, el margen para incentivos es estrecho. El complemento de productividad variable representa, según la comunidad autónoma, entre el 1,5 % y el 15 % de la retribución total del médico especialista. La fijación de los criterios de productividad se negocia en las mesas sectoriales autonómicas, no a nivel de hospital, y los indicadores utilizados suelen ser agregados (cumplimiento de objetivos del contrato-programa del centro) más que individuales. El resultado es un esquema retributivo con potencia de incentivos muy limitada: la mayor parte de la retribución del médico estatutario es fija e independiente de su desempeño individual (Monereo Pérez et al., 2007).

La carrera profesional, regulada en el artículo 40 de la Ley 55/2003 y desarrollada de forma heterogénea por las comunidades autónomas, constituye el otro instrumento de incentivos a largo plazo. La carrera profesional reconoce el desarrollo profesional mediante niveles o grados asociados a complementos retributivos, y exige la evaluación de competencias, formación y actividad asistencial. Sin embargo, su implantación ha sido desigual y, en varias comunidades, los avances han sido limitados o se han retrasado significativamente.

2.4.3. Personal laboral en entes instrumentales

En los hospitales gestionados por fundaciones públicas, empresas públicas, consorcios u otras entidades con personalidad jurídica propia, el personal se ha regido históricamente por el Derecho laboral, mediante contratos laborales sujetos a convenio colectivo propio de la entidad. Este régimen permite a la dirección del hospital una mayor flexibilidad en la contratación (selección directa, no sujeta a OPE), en la retribución (posibilidad de vincular una parte significativa del salario

al desempeño individual o por unidades) y en la organización del trabajo (mayor capacidad para reasignar funciones y modificar condiciones).

No obstante, la tendencia institucional predominante en la última década ha sido la estatutarización del personal de estos entes instrumentales, como ilustran los casos de las fundaciones gallegas (integradas en el SERGAS entre 2007 y 2008, con posterior estatutarización del personal) y de las APES andaluzas (liquidadas entre 2019 y 2022, con integración del personal en el régimen estatutario del SAS). Esta convergencia hacia el régimen estatutario reduce progresivamente el universo de hospitales públicos con autonomía retributiva plena.

2.4.4. Autonomía del gestor hospitalario

La autonomía del gestor hospitalario —entendida como la capacidad efectiva del director gerente para tomar decisiones sobre la organización interna de recursos humanos, la retribución del personal y la asignación de medios— varía sustancialmente según la forma de gestión.

En los hospitales públicos integrados, la autonomía del gestor es muy limitada. Las plantillas se fijan centralizadamente por el servicio de salud autonómico; las retribuciones se negocian en mesas sectoriales a nivel autonómico; la selección de personal se realiza mediante OPE con plazos que escapan al control de la dirección del centro; y la contratación temporal está sujeta a restricciones presupuestarias y administrativas. La dirección del hospital puede modular en cierta medida la organización funcional interna (distribución de guardias, asignación de tareas, programación quirúrgica), pero no puede alterar significativamente la estructura retributiva del personal médico.

En las concesiones integrales y en los hospitales privados (concertados o de mercado), la dirección dispone de plena autonomía para seleccionar personal, fijar retribuciones, diseñar esquemas de incentivos variables y reorganizar la estructura funcional del centro. Esta autonomía está limitada, en el caso de los hospitales concertados, por los módulos de precio del concierto y por los indicadores de calidad y accesibilidad exigidos por la administración sanitaria.

2.4.5. Directivos de hospital

El régimen de los directivos de los hospitales del SNS es heterogéneo y presenta debilidades reconocidas. La designación del director gerente es, en la mayoría de las comunidades autónomas, un nombramiento de libre designación por la autoridad sanitaria, lo que introduce un componente de discrecionalidad política en la selección. La Ley 55/2003 (art. 26) establece que el personal directivo será nombrado atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad y

publicidad, pero la práctica efectiva dista con frecuencia de estos principios. La rotación frecuente de los directivos hospitalarios —asociada a los ciclos políticos autonómicos— limita la capacidad de implementar reformas organizativas de medio plazo.

2.4.6. Conexión con el modelo teórico

La descripción del régimen de personal tiene una traducción directa en el modelo de agencia de la tesis. En un hospital con personal estatutario, la dirección no puede modular significativamente los incentivos del médico: las retribuciones están fijadas centralizadamente, el complemento variable es marginal y la selección de personal escapa al control del gestor. Esta configuración se aproxima a la *estructura centralizada* del modelo teórico (Capítulo 3): el principal (financiador) contrata de facto tanto con el hospital como con el médico, porque las condiciones esenciales del empleo médico se determinan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

En un hospital con personal laboral o gestión concesional, la dirección diseña autónomamente los contratos del personal médico: selecciona, retribuye y puede vincular una parte sustancial de la retribución al desempeño individual o por unidades funcionales. Esta configuración se aproxima a la *estructura descentralizada*: el principal contrata solo con el hospital, y es el hospital quien diseña el contrato del médico.

El borrador del nuevo Estatuto Marco publicado en enero de 2026 (Ministerio de Sanidad, 2026a) pone de manifiesto que este régimen está en proceso de revisión, lo que refuerza la relevancia del análisis: las reglas del personal no son un dato fijo, sino una variable institucional que puede alterarse mediante reformas normativas.

2.5. Financiación hospitalaria y verificabilidad del output

2.5.1. Presupuesto global retrospectivo

El mecanismo de financiación históricamente dominante en los hospitales públicos del SNS ha sido el presupuesto global retrospectivo: el hospital recibe una asignación presupuestaria anual basada fundamentalmente en el gasto histórico, con ajustes incrementales que reflejan la inflación, las decisiones de inversión y las modificaciones de plantilla. Este mecanismo equivale, en la terminología de la teoría de incentivos, a un pago fijo desvinculado del output: el volumen de financiación que recibe el hospital es esencialmente independiente de su actividad

asistencial o de la calidad de sus resultados.

La debilidad de este esquema como instrumento de incentivos fue identificada tempranamente. El denominado Informe Abril (1991), elaborado por una comisión de análisis y evaluación del SNS, señaló entre sus principales conclusiones la necesidad de vincular la financiación hospitalaria a la actividad y los resultados, superando el modelo de presupuesto histórico. Esta recomendación fue el antecedente inmediato de la introducción de los contratos-programa.

2.5.2. Contratos-programa

El contrato-programa es el principal instrumento de relación entre el servicio de salud autonómico y el hospital público. Introducidos a partir de 1993 por el INSALUD y adoptados posteriormente por los servicios autonómicos de salud, los contratos-programa establecen un marco de objetivos y compromisos entre el financiador y el centro hospitalario.

Un contrato-programa típico especifica: objetivos de actividad (número de altas, estancias, consultas, intervenciones), objetivos de calidad (indicadores de seguridad clínica, tiempos de espera, satisfacción del paciente), objetivos de eficiencia (estancia media, coste por alta, índice de rotación) y, en algunos casos, objetivos de docencia e investigación. El grado de cumplimiento de estos objetivos se vincula al sistema de Dirección por Objetivos (DPO) del centro, que a su vez determina la cuantía del complemento de productividad variable del personal.

El contrato-programa introduce, por tanto, un elemento de pago variable en un esquema que sigue siendo predominantemente de pago fijo. Sin embargo, la potencia efectiva de los incentivos depende de la proporción de la financiación que esté genuinamente vinculada al cumplimiento de objetivos y de la credibilidad de las consecuencias del incumplimiento. En la práctica, el presupuesto base del hospital rara vez se reduce significativamente por incumplimiento de objetivos, lo que limita la potencia del mecanismo.

2.5.3. Pago por actividad: GRD y sistemas de clasificación de pacientes

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) son un sistema de clasificación de pacientes que agrupa los episodios de hospitalización en categorías clínicamente coherentes y de consumo de recursos homogéneo. El sistema permite comparar la actividad hospitalaria ajustada por complejidad (case-mix) y, potencialmente, vincular la financiación a la actividad ponderada.

En España, el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) fue implantado en 1987 como registro normalizado de los episodios de hospitalización, incluyendo los

diagnósticos y procedimientos codificados que permiten la asignación de GRD. El Real Decreto 69/2015 amplió este registro al Registro de Actividad de Atención Especializada (RAE-CMBD), que incluye información sobre hospitalización, cirugía ambulatoria, hospital de día y procedimientos ambulatorios especiales.

En la mayoría de las comunidades autónomas, los GRD se utilizan principalmente como instrumento de gestión interna y de benchmarking entre hospitales, no como mecanismo de pago directo. Cataluña es la comunidad autónoma donde el pago por actividad basado en GRD está más desarrollado: CatSalut utiliza los GRD como base para el cálculo de los pagos a los hospitales de la red SISCAT, tanto públicos como concertados. En el resto de comunidades, el peso de los GRD en la financiación efectiva es menor, aunque su uso en la evaluación del desempeño hospitalario es generalizado.

2.5.4. Módulos de concierto

Los hospitales privados que prestan servicios al SNS mediante concierto sanitario se financian a través de módulos de precio fijados por las comunidades autónomas. Estos módulos establecen tarifas por unidad de actividad —precio por estancia, por alta, por procedimiento quirúrgico, por consulta externa— que constituyen la base económica del concierto. Los módulos de concierto representan un mecanismo de pago por actividad que genera incentivos directos sobre el volumen de producción: el hospital recibe más financiación cuanta más actividad realice, dentro de los límites que establezca el concierto.

2.5.5. Pago capitativo

El pago capitativo consiste en una tarifa fija por habitante asignado al área de salud del hospital, independientemente de la actividad efectivamente realizada. Este mecanismo se ha utilizado en las concesiones administrativas de tipo Alzira, donde el concesionario recibe un pago anual por habitante ajustado que cubre la totalidad de la asistencia sanitaria (hospitalaria y, en algunos modelos, también primaria) de la población asignada.

El pago capitativo genera incentivos radicalmente distintos al pago por actividad: el hospital tiene incentivos para contener el coste por episodio (eficiencia en intensidad) y para reducir la utilización innecesaria, puesto que toda actividad adicional no genera ingreso marginal sino coste adicional. Este mecanismo también opera en el ámbito del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), donde las aseguradoras privadas que cubren a los funcionarios reciben un pago capitativo por persona asegurada.

2.5.6. Conexión con el modelo teórico y la variable empírica

El problema analítico central que emerge de la descripción de los mecanismos de financiación es que las señales de output disponibles para el financiador no son igualmente precisas para todas las dimensiones del producto hospitalario.

El volumen de actividad —número de altas, estancias, intervenciones, consultas— es relativamente fácil de medir, registrar y verificar. Los sistemas de información hospitalaria (SIAE, CMBD/RAE-CMBD) proporcionan datos exhaustivos y normalizados sobre la actividad asistencial. La intensidad de la atención —la adecuación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a la situación clínica de cada paciente, la profundidad del estudio diagnóstico, la pertinencia de las indicaciones terapéuticas— es mucho más costosa de observar, más difícil de codificar en indicadores contractuales verificables y más susceptible de manipulación mediante upcoding o selección de pacientes.

En la notación del modelo teórico (Capítulo 3), esta asimetría en la verificabilidad se captura mediante las varianzas de las señales de output: la señal de cantidad (σ_1^2) es relativamente precisa, mientras que la señal de intensidad (σ_2^2) es ruidosa. La consecuencia, bien establecida en la teoría de multitarea (Holmström y Milgrom, 1991), es que vincular los incentivos a la señal más precisa puede generar un desplazamiento de esfuerzo desde la dimensión menos verificable.

La variable empírica pct^{SNS} de la estimación (Capítulo 5) captura parcialmente esta dimensión: un hospital con alta financiación pública (pct^{SNS} alto) opera predominantemente bajo instrumentos que enfatizan el volumen de actividad (contratos-programa, GRD) y que miden con mayor precisión la cantidad que la intensidad. Un hospital con baja financiación pública opera bajo esquemas de pago directo o de seguros privados que pueden incorporar señales diferentes sobre la calidad y la intensidad de la atención.

2.6. Del lenguaje jurídico de la organización sanitaria al lenguaje económico de la agencia

Los capítulos anteriores de esta tesis han descrito, con anclaje normativo, las formas de gestión habilitadas por el ordenamiento, las diferencias de control entre ellas, el régimen del personal y las fórmulas de financiación y contratación. El propósito de esta sección es explicitar cómo esas categorías jurídico-institucionales se traducen en los parámetros de un problema de análisis económico bajo información asimétrica.

2.6.1. El hospital como organización compleja con múltiples agentes

El Derecho sanitario organiza la provisión hospitalaria mediante una cadena de delegaciones sucesivas. La administración sanitaria autonómica (financiador) fija el marco presupuestario, la cartera de servicios y los instrumentos de control. La dirección del hospital recibe un mandato de gestión —más o menos amplio según la forma jurídica del centro— y organiza internamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los profesionales clínicos —fundamentalmente los médicos— toman decisiones asistenciales con alto contenido técnico y elevada discrecionalidad, en un contexto donde la información relevante (estado del paciente, idoneidad de los procedimientos, esfuerzo efectivamente dedicado) es en gran medida local y no transmisible íntegramente a los niveles superiores de la cadena.

La teoría económica de la agencia (Laffont y Martimort, 2002) ofrece un lenguaje parsimonioso para formalizar esta estructura. En la terminología de los modelos principal–agente, el financiador público actúa como *principal*: define objetivos (salud poblacional, accesibilidad, eficiencia) y diseña instrumentos (presupuestos, contratos-programa, módulos de concierto, indicadores) para inducir al agente a comportarse de acuerdo con esos objetivos. El hospital actúa como primer *agente*: recibe recursos y un mandato, pero dispone de información privada sobre sus costes reales, su capacidad organizativa y su esfuerzo efectivo. El médico actúa como segundo agente —o subagente en una estructura de delegación secuencial—: su esfuerzo determina directamente la cantidad y la calidad de la atención prestada, pero ese esfuerzo no es plenamente observable ni por la dirección del hospital ni, menos aún, por el financiador.

Lo que distingue esta cadena de un problema de agencia estándar es la *multiplicidad de outputs*. El hospital no produce un bien homogéneo. Produce, al menos, un volumen de atención (número de pacientes atendidos, altas, intervenciones) y una intensidad de atención por episodio (recursos diagnósticos y terapéuticos aplicados a cada paciente). Estas dos dimensiones no son independientes en la función de producción: el tiempo y el esfuerzo que el médico dedica a ver más pacientes pueden competir con el tiempo dedicado a aplicar una intensidad diagnóstica adecuada a cada uno. Esta interacción entre tareas —que puede ser de sustitución o de complementariedad según el tipo de servicio— es el mecanismo central del modelo teórico que se desarrolla en el Capítulo 3.

2.6.2. Estructura organizativa como estructura de agencia

Las formas de gestión descritas en la Sección 2.3 no son, desde esta perspectiva, meras categorías administrativas. Cada forma de gestión configura una *estructura de agencia* distinta, que determina quién diseña el contrato del médico, qué instrumentos están disponibles para alinear incentivos y qué restricciones operan sobre la capacidad de supervisión y retribución.

En un hospital público de gestión directa con personal estatutario, el financiador y la administración sanitaria intervienen simultáneamente en la fijación de las condiciones del personal médico: la selección se realiza por oposición centralizada, las retribuciones se determinan en mesas sectoriales autonómicas, y la capacidad de la dirección del hospital para modular incentivos individuales se limita al estrecho margen del complemento de productividad variable. En términos del modelo de agencia, esta configuración se aproxima a una *estructura centralizada*: el principal (financiador) contrata, de facto, tanto con el hospital como con el médico, porque las condiciones esenciales del empleo médico se fijan a un nivel superior al de la dirección hospitalaria.

En un hospital gestionado mediante concesión administrativa, fundación con personal laboral o empresa privada concertada, la situación es cualitativamente distinta. El financiador contrata con la entidad gestora para un determinado nivel de actividad y, en su caso, de calidad. La entidad gestora diseña autónomamente los contratos de sus profesionales: selecciona, retribuye y puede vincular una parte significativa de la retribución al desempeño individual o por unidades. En términos del modelo de agencia, esta configuración se aproxima a una *estructura descentralizada*: el principal contrata solo con el hospital, y es el hospital quien diseña el contrato del médico.

Esta correspondencia no es perfecta —ninguna traducción entre categorías jurídicas y categorías económicas lo es—, pero captura la variable institucional más relevante para el análisis: el grado de autonomía efectiva del gestor hospitalario para diseñar la estructura interna de incentivos. La variable empírica D^{desc} de la estimación econométrica (Capítulo 5) operacionaliza precisamente esta distinción.

2.6.3. Mecanismos de pago como señales de output

Los mecanismos de financiación descritos en la Sección 2.5 tienen una lectura directa en términos de la teoría de contratos. El presupuesto global retrospectivo equivale, en la terminología de los incentivos, a un *pago fijo* desvinculado del output: el hospital recibe recursos independientemente de su actividad o de la calidad de su desempeño. El pago por actividad —sea por GRD, por módulos de concierto o por capitación ajustada— equivale a un *pago variable* vinculado a una

señal observable del output.

El problema analítico central es que las señales disponibles no son igualmente precisas para todas las dimensiones del output. El volumen de actividad (altas, estancias, intervenciones) es relativamente fácil de medir y verificar. La intensidad de la atención —la adecuación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a la situación clínica del paciente— es mucho más costosa de observar, más difícil de codificar en indicadores contractuales y más susceptible de manipulación. En la notación del modelo teórico, esta asimetría se captura mediante las varianzas de las señales de output: la señal de cantidad (σ_1^2) es relativamente precisa, mientras que la señal de intensidad (σ_2^2) es ruidosa.

La consecuencia, bien establecida en la teoría de multitarea (Holmström y Milgrom, 1991), es que vincular los incentivos a la señal más precisa (cantidad) puede generar un desplazamiento de esfuerzo desde la dimensión menos verificable (intensidad). Este mecanismo es el fundamento teórico de la predicción central de esta tesis: la descentralización, al ir asociada a mecanismos de pago más vinculados a la actividad, puede mejorar la eficiencia en volumen pero deteriorar —o al menos no mejorar proporcionalmente— la eficiencia en intensidad.

2.6.4. El parámetro ψ_{12} y la naturaleza del servicio

La última pieza de la traducción concierne al grado de interacción entre las tareas del médico. El Capítulo 2 ha descrito que los hospitales prestan servicios de naturaleza heterogénea: servicios quirúrgicos, donde el acto de intervenir genera per se actividad diagnóstica y terapéutica asociada (preoperatorio, postoperatorio, seguimiento), y servicios médicos no quirúrgicos, donde la atención a un nuevo paciente compite en tiempo con la profundidad diagnóstica dedicada a cada uno.

En el modelo teórico, esta distinción se formaliza mediante el parámetro ψ_{12}, que mide la complementariedad o sustituibilidad entre las dos tareas del médico (producir cantidad y producir intensidad). En los servicios quirúrgicos, las tareas tienden a ser complementarias ($\psi_{12} < 0$): operar más implica per se más intensidad. En los servicios médicos, las tareas tienden a ser sustitutas ($\psi_{12} > 0$): ver más pacientes compite con el tiempo diagnóstico por paciente.

Esta correspondencia entre la naturaleza del servicio clínico y el parámetro de interacción entre tareas es la que justifica dos de los diseños empíricos de la tesis: el Diseño B, que estima fronteras separadas para servicios quirúrgicos y médicos, y el Diseño C, que explota la variación entre tipos de servicio dentro del mismo hospital.

2.6.5. Síntesis de correspondencias

La tabla siguiente resume las correspondencias entre las categorías jurídico-institucionales del Capítulo 2 y los parámetros del modelo de agencia que se formaliza en el Capítulo 3:

Cuadro 2.2: Correspondencias entre categorías institucionales y parámetros del modelo de agencia

Categoría jurídico-institucional	**Parámetro del modelo económico**
Forma de gestión (directa / indirecta)	Estructura de agencia (centralizada / descentralizada)
Régimen del personal (estatutario / laboral)	Capacidad del hospital para diseñar el contrato del médico
Mecanismo de financiación (presupuesto / actividad / capitación)	Tipo de señal de output y potencia de los incentivos
Precisión de los indicadores de control	Varianzas de las señales (σ_1^2, σ_2^2)
Naturaleza del servicio (quirúrgico / médico)	Parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12})
Autonomía del gestor	Derechos residuales de decisión

Estas correspondencias no pretenden agotar la complejidad institucional descrita en las secciones precedentes, sino identificar los ejes analíticos a lo largo de los cuales la diversidad organizativa del sistema hospitalario español genera variación relevante para un análisis de incentivos y eficiencia. El capítulo siguiente formaliza esta estructura en un modelo de agencia multitarea con tres agentes y dos outputs, del cual se derivan predicciones contrastables sobre cómo la estructura organizativa y el mecanismo de pago afectan de forma asimétrica a la eficiencia en cada dimensión del output hospitalario.

2.7. Conclusión: pluralismo organizativo, información asimétrica y necesidad de evaluación empírica

El sistema sanitario español admite, por habilitación legal explícita, una pluralidad de formas organizativas para la gestión hospitalaria. Esa pluralidad no es meramente formal: altera de modo sustantivo la autonomía del gestor, el régimen de contratación y retribución del personal, la distribución de riesgos

entre financiador y proveedor, y los instrumentos disponibles para supervisar y disciplinar el desempeño.

La descripción institucional de este capítulo permite identificar tres rasgos del entorno hospitalario español que justifican un enfoque analítico de agencia multitarea bajo información asimétrica. Primero, la cadena de provisión es multiagente: financiador, hospital y médico operan en niveles distintos con información y objetivos parcialmente divergentes. Segundo, el output hospitalario es multidimensional: la legislación define las prestaciones en términos que incluyen cantidad, calidad, adecuación y continuidad, y no todas estas dimensiones son igualmente observables ni verificables. Tercero, la estructura organizativa —centralizada o descentralizada— determina quién diseña el contrato del médico y con qué instrumentos, lo que tiene consecuencias directas sobre la asignación del esfuerzo entre tareas.

Estos tres rasgos configuran un problema que ni el análisis puramente jurídico ni el análisis económico estándar de eficiencia pueden resolver por separado. El análisis jurídico describe las reglas del juego pero no predice sus consecuencias sobre el desempeño. El análisis de eficiencia convencional —con un único indicador— agrega dimensiones que pueden moverse en direcciones opuestas y pierde información esencial. La contribución de esta tesis es articular ambas perspectivas: el modelo teórico del Capítulo 3 formaliza la estructura institucional como un problema de incentivos con soluciones analíticas y predicciones contrastables; la estimación empírica de los Capítulos 6 y 7 evalúa esas predicciones con datos del sistema hospitalario español; y las implicaciones de política del Capítulo 8 devuelven los resultados al terreno del diseño institucional.

Capítulo 3

Modelo teórico: incentivos y estructura organizativa en la financiación hospitalaria

3.1. Introducción

El capítulo anterior ha descrito cómo el sistema hospitalario español combina pluralidad organizativa, diversidad en los mecanismos de pago y restricciones derivadas del régimen de personal que configuran un entorno de información asimétrica y contratos incompletos. Este capítulo formaliza esa estructura institucional mediante un modelo de agencia multitarea que traduce las variables jurídico-institucionales —forma de gestión, tipo de pago, naturaleza del servicio— en parámetros de un problema de incentivos con soluciones analíticas y predicciones empíricamente contrastables.

La financiación hospitalaria eficiente depende de los arreglos organizativos establecidos entre los distintos agentes que interactúan en la provisión de servicios sanitarios. En este capítulo estudiamos cómo, bajo riesgo moral, diferentes estructuras organizativas moldean el papel de los mecanismos de pago por incentivos para los médicos y los directivos hospitalarios.

La provisión de servicios hospitalarios es, en última instancia, el resultado de la interacción de múltiples agentes. Los financiadores —públicos o privados— compran servicios a los hospitales. Los gestores toman continuamente decisiones sobre la asignación de recursos humanos y materiales. Dentro de cada hospital, una multiplicidad de profesionales —médicos, personal de enfermería, auxiliares, farmacéuticos— realizan tareas distintas cuyas acciones combinadas determinan el conjunto de diagnósticos y procedimientos terapéuticos que intentan mejorar el estado de salud de los pacientes.

La importancia de la multiplicidad de tareas y agentes implicados ha sido estudiada en numerosos trabajos académicos centrados en los efectos sobre la eficiencia de distintos esquemas de financiación. Jelovac y Macho-Stadler (2002), en un enfoque cercano al nuestro, estudian los contratos óptimos tanto para el médico como para el hospital bajo riesgo moral bilateral, analizando las condiciones bajo las cuales es óptimo utilizar contratación centralizada o una estructura descentralizada en la que el principal delega en el hospital el diseño del contrato del médico. Ma (1997) analiza el papel de la información asimétrica en la relación médico-hospital y sus implicaciones para la eficiencia. Eggleston (2005) examina las consecuencias de distintas formas de pago sobre la calidad cuando hay múltiples agentes. Kaarboe y Siciliani (2011) estudian los incentivos del médico hospitalario en un entorno multitarea con información asimétrica.

Las regulaciones legales y administrativas del sistema sanitario influyen de manera fundamental en el funcionamiento de los incentivos. En el caso español, aunque la estructura hospitalaria pública es la forma predominante de provisión, ha aumentado la participación de organizaciones privadas y sin ánimo de lucro junto con las colaboraciones público-privadas (Repullo y Freire, 2008). Más allá de las diferentes estructuras legales, hay una distinción esencial en la que se centra nuestro análisis: el grado de autonomía del que disfrutan los gestores hospitalarios al contratar sus insumos.

En los hospitales públicos del SNS, la autoridad sanitaria regional contrata de forma centralizada y simultánea tanto los servicios hospitalarios como a los miembros del personal. En los hospitales privados y sin ánimo de lucro, los gestores disponen de mayor margen de maniobra a la hora de elegir a los médicos que trabajarán en sus centros y de diseñar los esquemas retributivos internos. Además, cuando los hospitales tienen una dependencia funcional privada o no lucrativa, se utilizan con mayor frecuencia esquemas de pago del tipo *fee-for-service*, mientras que en los hospitales públicos el financiador recurre más a menudo a remuneraciones salariales fijas.

Con este propósito, en las secciones siguientes desarrollamos un modelo teórico de riesgo moral con múltiples tareas bajo diferentes estructuras organizativas, derivando las restricciones de compatibilidad de incentivos y sus implicaciones sobre la potencia óptima de los incentivos y la eficiencia productiva. El objetivo último es obtener predicciones empíricamente contrastables que puedan aplicarse al sistema hospitalario español.

3.2. Planteamiento del modelo

En el modelo interactúan tres agentes. En primer lugar, el asegurador de servicios sanitarios (el principal), que puede ser público o privado. Después, el consejo de dirección del hospital (el hospital, en adelante) y, finalmente, el médico. Hospital y médico producen conjuntamente dos outputs.

3.2.1. Los dos outputs y su asimetría

La primera dimensión del output es la **cantidad** de servicios sanitarios. Esta dimensión cuantitativa es el resultado de las interacciones de esfuerzo de hospital y médico:

$$q(a, t_1) = a + t_1 + \epsilon_1 \tag{3.1}$$

El escalar no negativo a representa el esfuerzo del hospital para producir un cierto nivel de cantidad (por ejemplo, número de ingresos). El esfuerzo del médico dedicado a la cantidad viene dado por $t_1 \geq 0$. Los valores concretos de ambas variables, junto con un shock aleatorio ϵ_1, determinan la cantidad.

La segunda dimensión es la **intensidad** (utilizada como aproximación de la calidad),[1] dada por:

$$i(t_2) = t_2 + \epsilon_2 \tag{3.2}$$

Esta variable es el resultado del esfuerzo del médico t_2 y de un shock aleatorio ϵ_2. El hospital puede influir en la cantidad de altas hospitalarias pero no en la cantidad de servicios diagnósticos o terapéuticos por paciente, una decisión que recae exclusivamente en el médico.

El vector de output es $\boldsymbol{x} = (q, i)$. Los componentes aleatorios $\boldsymbol{\epsilon} = (\epsilon_1, \epsilon_2)$ se distribuyen normalmente con media cero y matriz de varianzas y covarianzas:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

es decir, $\boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$.

Observación 3.1. Esta asimetría en la producción es el núcleo estructural del modelo. Si ambos outputs fueran producidos por los mismos agentes con los mismos incentivos, las predicciones serían simétricas y no habría hipótesis falsificable sobre el efecto diferencial de la estructura organizativa. La asimetría en la producción refleja una realidad institucional del hospital: el médico es el agente con conocimiento privado sobre la idoneidad y la intensidad del tratamiento, mientras que

[1] El concepto de calidad es escurridizo cuando se consideran los servicios hospitalarios; por ello nos centramos en la intensidad de los servicios diagnóstico-terapéuticos por paciente.

el hospital (la dirección) tiene mayor control sobre la capacidad instalada y el flujo de pacientes. Esta distinción es análoga a la distinción entre esfuerzo de *throughput* (volumen de actividad) y esfuerzo de *quality* (intensidad por episodio) en la literatura de economía de la salud (Eggleston, 2005; Kaarboe y Siciliani, 2011).

3.2.2. Preferencias de los agentes

La utilidad de los distintos agentes viene dada por:

$$u_f = s(q,i) - \lambda[b(q,i) + w(q,i)] \tag{3.4}$$

$$u_h(b,a) = u_h[b(q,i) - \tau(a) + z(a)] \tag{3.5}$$

$$u_m(w,t_1,t_2) = u_m[w(q,i) - \psi(t_1,t_2) + \phi(t_1,t_2)] \tag{3.6}$$

donde $s(q,i)$ es la utilidad directa para el financiador de contratar q e i, $b(q,i)$ es el pago al hospital y $w(q,i)$ la renta pagada al médico. Tanto el hospital como el médico asumen costes de ejercer sus respectivos niveles de esfuerzo ($\tau(a)$ y $\psi(t_1,t_2)$). Finalmente, se permiten preferencias altruistas o vocacionales, dependientes del esfuerzo, tanto en el hospital ($z(a)$) como en el médico ($\phi(t_1,t_2)$).

3.2.3. El parámetro clave: ψ_{12}

La función de costes del médico $\psi(t_1,t_2)$ incorpora un parámetro de interacción entre tareas ψ_{12} que mide el grado de complementariedad o sustituibilidad:

- Si $\psi_{12} > 0$ (tareas sustitutas): el médico que dedica más tiempo a ver pacientes reduce la intensidad que dedica a cada uno. Es el caso típico de servicios médicos no quirúrgicos.
- Si $\psi_{12} < 0$ (tareas complementarias): el acto de intervenir genera per se mayor intensidad. Es el caso típico de servicios quirúrgicos.
- Si $\psi_{12} = 0$: las tareas son independientes en la función de costes del médico.

Como se verá en la sección empírica, ψ_{12} no es directamente observable. En la estimación se aproxima mediante la proporción de altas quirúrgicas sobre el total (*ShareQ*) a nivel de hospital-año, o bien se identifica de forma estructural separando los outputs quirúrgico y médico.

3.3. La solución de primer *best*

Cuando el principal tiene información completa sobre los esfuerzos de ambos agentes y contrata bajo una estructura centralizada,[2] el problema de optimización es:

$$\begin{aligned} \max_{a,t_1,t_2} \quad & \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_f] = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}\left[s(q,i) - \lambda[b(q) + w(q,i)]\right] \\ \text{s.a.} \quad & \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_h] \geq u_h(\bar{b}) \\ & \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_m] \geq u_m(\bar{w}) \end{aligned}$$

donde $u_h(\bar{b})$ y $u_m(\bar{w})$ son las utilidades de reserva del hospital y del médico.[3]

El principal puede contratar el nivel óptimo de esfuerzos (a^*, t_1^*, t_2^*) y hacer vinculante la restricción de participación con pagos de suma fija:

$$b(q) = H = \bar{b} + \tau(a^*) - z(a^*) \tag{3.7}$$

$$w(q,i) = M = \bar{w} + \psi(t_1^*, t_2^*) - \phi(t_1^*, t_2^*) \tag{3.8}$$

Las condiciones necesarias de primer orden del problema reducido son:

$$s_q + \lambda z_a = \lambda \tau_a \tag{3.9}$$

$$s_q + \lambda \phi_{t_1} = \lambda \psi_{t_1} \tag{3.10}$$

$$s_i + \lambda \phi_{t_2} = \lambda \psi_{t_2} \tag{3.11}$$

Combinando las ecuaciones (3.9) y (3.10):

$$\tau_a - z_a = \psi_{t_1} - \phi_{t_1} \tag{3.12}$$

y las ecuaciones (3.10) y (3.11):

$$\frac{s_q}{s_i} = \frac{\psi_{t_1} - \phi_{t_1}}{\psi_{t_2} - \phi_{t_2}} = \frac{\tau_a - z_a}{\psi_{t_2} - \phi_{t_2}} \tag{3.13}$$

Resultado 3.1 (Primer *best*)**.** *La ecuación (3.12) establece que los costes marginales netos de altruismo de ambos agentes al producir cantidad deben igualarse. La ecuación (3.13) requiere que la tasa marginal de sustitución para el principal entre ambos outputs sea igual a la tasa marginal técnica de transformación entre cantidad e intensidad. Con estas condiciones se obtienen los niveles de esfuerzo*

[2] Bajo información completa y estructura descentralizada, el principal implementará los mismos niveles de esfuerzo de primer *best*, de modo que no es necesario comparar entre estructuras.

[3] Dada la información completa, el principal no condiciona el pago de cada agente al esfuerzo del otro.

de primer best del médico en ambas tareas y, dado su esfuerzo óptimo en cantidad, el esfuerzo del hospital.

Una implicación relevante es que, si un hospital público o sin ánimo de lucro tiene un componente vocacional más alto ($z(a)$ mayor), entonces en el óptimo el principal debería exigirle un nivel de esfuerzo mayor: el principal explota el beneficio que el agente obtiene de su altruismo. Del mismo modo, si el único agente con preocupación directa por el bienestar del paciente es el médico ($z(a) = 0$), entonces la ecuación (3.13) implica que el principal contratará un mayor nivel de esfuerzo en intensidad respecto a la cantidad en comparación con el caso de un hospital con componente altruista.

3.4. Riesgo moral bajo estructura centralizada

De forma más realista, el principal no es capaz de verificar los esfuerzos de los agentes y debe utilizar el nivel de output como señal ruidosa del esfuerzo realizado. Siguiendo a Holmström y Milgrom (1991), especificamos funciones de utilidad exponenciales (CARA) para los agentes, neutralidad al riesgo del principal ($s(q, i) = q + i$) y esquemas lineales de reembolso.

3.4.1. Especificación funcional

Las funciones de utilidad son:

$$u_h(b, a) = -\mathrm{e}^{-\rho[b(q,i)-\tau(a)+z(a)]} \tag{3.14}$$

$$u_m(w, t_1, t_2) = -\mathrm{e}^{-\eta[w(q,i)-\psi(t_1,t_2)+\phi(t_1,t_2)]} \tag{3.15}$$

donde ρ y η son los coeficientes de aversión absoluta al riesgo del hospital y del médico (Holmström y Milgrom, 1987).

Las funciones de coste del esfuerzo son:

$$\tau(a) = \frac{1}{2}\tau a^2, \quad \tau > 0 \tag{3.16}$$

$$\psi(t_1, t_2) = \frac{1}{2}(\psi_1 t_1^2 + \psi_2 t_2^2) + \psi_{12} t_1 t_2, \quad \psi_1 > 0,\ \psi_2 > 0,\ \psi_{12}^2 \leq \psi_1\psi_2 \tag{3.17}$$

El parámetro ψ_{12} mide la interacción entre tareas.[4]

[4] Si $\psi_{12}^2 = \psi_1\psi_2$, las tareas son sustitutivas perfectas. Si $\psi_{12} = 0$, son independientes. Si $\psi_{12} < 0$, son complementarias.

El componente altruista sigue una especificación lineal:

$$z(a) = z_1 a, \quad z_1 \geq 0 \tag{3.18}$$

$$\phi(t_1, t_2) = \phi_1 t_1 + \phi_2 t_2, \quad \phi_1, \phi_2 \geq 0 \tag{3.19}$$

Los esquemas lineales de compensación son:

$$b(q) = f + bq \tag{3.20}$$

$$w(q, i) = F + Bq + Di \tag{3.21}$$

donde f y F son los componentes fijos, y b, B y D son los componentes variables (incentivos) por cantidad e intensidad respectivamente.

La secuencia temporal de la contratación bajo estructura centralizada se representa en la Figura 3.1. El principal ofrece contratos simultáneamente al hospital y al médico (etapa 1); ambos eligen sus niveles de esfuerzo (etapa 2); se realizan los outputs q e i (etapa 3); y se efectúan los pagos (etapa 4).

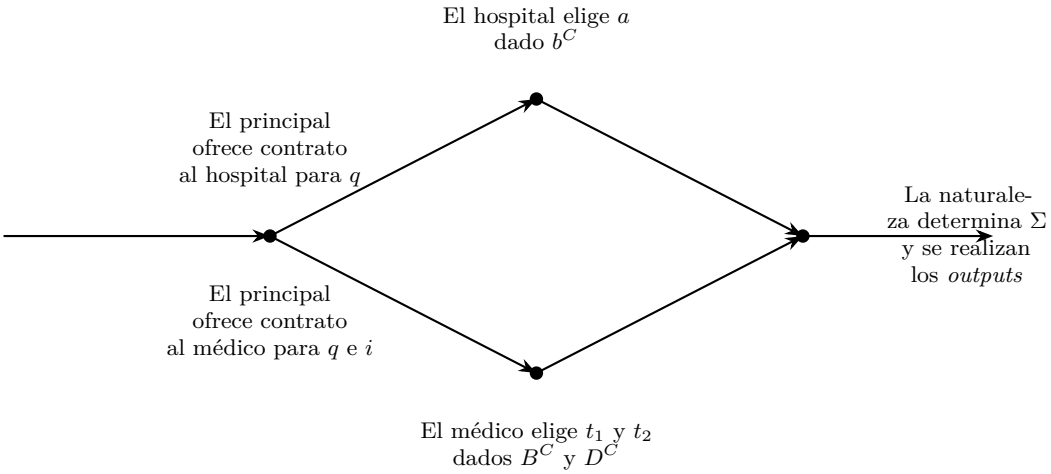


Figura 3.1: Cronograma de la contratación bajo estructura centralizada. El principal contrata simultáneamente con el hospital ($b(q)$) y el médico ($w(q, i)$).

3.4.2. Solución de segundo *best* centralizado

Utilizando el enfoque de primer orden y la definición de equivalentes ciertos,[5] las restricciones de compatibilidad de incentivos producen los esfuerzos óptimos

[5]El equivalente cierto del médico es $\widehat{w}(t_1, t_2) = F + B(\bar{a} + t_1) + Dt_2 + \phi_1 t_1 + \phi_2 t_2 - \frac{1}{2}(\psi_1 t_1^2 + \psi_2 t_2^2) - \psi_{12} t_1 t_2 - \frac{\eta}{2}(B^2\sigma_1^2 + D^2\sigma_2^2 + 2BD\sigma_{12}^2)$ para una realización dada de a. El equivalente cierto del hospital es $\widehat{b}(a) = f + b(a + \bar{t}_1) + z_1 a - \frac{1}{2}\tau a^2 - \frac{\rho}{2} b^2 \sigma_1^2$ dados t_1 y t_2.

de segundo *best*:

$$a^C = \frac{b + z_1}{\tau} \tag{3.22}$$

$$t_1^C = \frac{(B + \phi_1)\psi_2 - (D + \phi_2)\psi_{12}}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \tag{3.23}$$

$$t_2^C = \frac{(D + \phi_2)\psi_1 - (B + \phi_1)\psi_{12}}{\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2} \tag{3.24}$$

Suponiendo independencia entre los componentes aleatorios de los outputs ($\sigma_{12} = 0$), los parámetros óptimos de incentivos son:

$$b^C = \frac{1}{\lambda(1 + \rho\sigma_1^2\tau)} \tag{3.25}$$

$$B^C = \frac{1 + \eta\sigma_2^2(\psi_2 - \psi_{12})}{\lambda[1 + \sigma_1^2\sigma_2^2\eta^2(\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2) + \eta(\sigma_1^2\psi_1 + \sigma_2^2\psi_2)]} \tag{3.26}$$

$$D^C = \frac{1 + \eta\sigma_1^2(\psi_1 - \psi_{12})}{\lambda[1 + \sigma_1^2\sigma_2^2\eta^2(\psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2) + \eta(\sigma_1^2\psi_1 + \sigma_2^2\psi_2)]} \tag{3.27}$$

Resultado 3.2 (Propiedades de los incentivos centralizados)**.** *Los incentivos óptimos bajo estructura centralizada presentan las siguientes propiedades:*

(a) A diferencia de la solución de primer best, el diseño del contrato no depende del grado de altruismo de los agentes. Bajo información asimétrica, el esquema óptimo de pagos es el mismo para hospitales públicos o privados.

(b) Cuando las tareas del médico son sustitutas ($\psi_{12} > 0$), la potencia óptima de los incentivos está directamente relacionada: un aumento del pago incentivador sobre la cantidad debería realinearse con un aumento del pago variable sobre la intensidad (complementariedad de incentivos).

(c) La potencia de los incentivos es independiente entre agentes: cambiar los incentivos del hospital no tiene efecto sobre los del médico.

(d) Cuando la intensidad es difícil de medir (alto σ_2) y los esfuerzos son sustitutivos perfectos, la solución óptima implica ausencia de incentivos para el médico (salario fijo).

3.4.3. Implicaciones para distintos mecanismos de financiación

Bajo una organización centralizada, podemos comparar los niveles de output bajo distintos esquemas de pago incentivador en relación con una línea base de pago puramente fijo:

- **Pago fijo (sin incentivos):** Si no se utilizan incentivos ($b = B = D = 0$), el nivel de esfuerzo del hospital será inferior al de segundo *best*. El esfuerzo del médico depende de sus parámetros: dado que $\psi_1 = \psi_2$ y $\sigma_2 > \sigma_1$, el esfuerzo en intensidad será mayor y el esfuerzo en cantidad será menor que en el óptimo. Los pagos fijos generan una cantidad por debajo de la óptima y una intensidad por encima.

- **Incentivos solo sobre cantidad:** Bajo un esquema que solo incentive la eficiencia en cantidad ($b = b^C$, $B = B^C$, $D = 0$), tanto hospital como médico proporcionan mayor esfuerzo en cantidad, pero el médico infraofrece esfuerzo en intensidad.

- **Esquema mixto:** Si el esquema incluye la potencia óptima para el hospital pero ninguna para el médico ($b = b^C$, $B = D = 0$), dependiendo de los valores de los parámetros, podría observarse infraprovisión tanto de cantidad como de intensidad.

3.5. Riesgo moral bajo estructura descentralizada

En una estructura descentralizada, el principal contrata solo con el hospital para determinados niveles de q e i, y es el hospital quien contrata con el médico. El supuesto de información asimétrica se mantiene también para la relación hospital-médico. La secuencia temporal se recoge en la Figura 3.2: el principal ofrece contrato al hospital (etapa 1); el hospital diseña el contrato con el médico (etapa 2); ambos eligen esfuerzos (etapa 3); se realizan outputs y pagos (etapa 4).

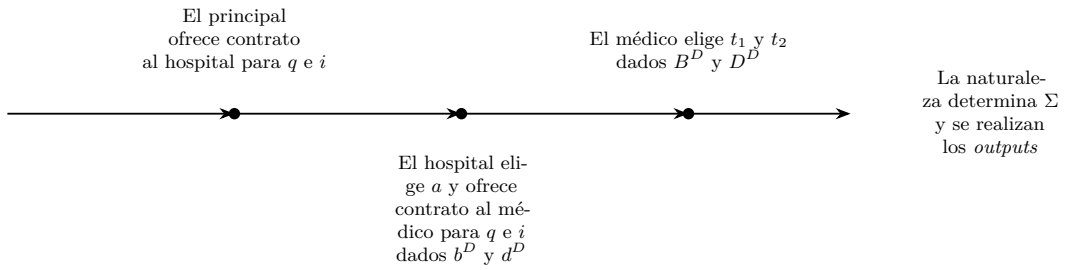


Figura 3.2: Cronograma de la contratación bajo estructura descentralizada. El principal solo contrata con el hospital ($b(q)+d\cdot i$); el hospital diseña autónomamente el contrato interno con el médico (B, D).

3.5.1. El problema del hospital

El esquema de pago del principal al hospital incluye ahora un componente sobre intensidad:

$$b(q, i) = f + bq + di \tag{3.28}$$

Resolviendo por inducción hacia atrás, el hospital maximiza su equivalente cierto (CE_h) eligiendo a, B y D:

$$\begin{aligned} \max_{a,B,D} \ \text{CE}_h &= f + (b - B)(a + t_1) + (d - D)t_2 + z_1 a - M \\ \text{s.a.} \quad t_1 &= t_1^D(B, D), \quad t_2 = t_2^D(B, D), \quad \widehat{w} = \bar{w} \end{aligned}$$

donde M es el coste total del hospital (coste de esfuerzo + prima de riesgo + pago fijo al médico).

Denotando $\theta = \rho + \eta$ y $\delta = \psi_1\psi_2 - \psi_{12}^2$, los componentes óptimos de pago variable al médico son:

$$B^D = \frac{b(1 + \sigma_1^2\rho\psi_1 + \sigma_2^2\theta(\rho\delta\sigma_1^2 + \psi_2)) - d\eta\sigma_2^2\psi_{12}}{1 + \psi_1\theta\sigma_1^2 + \theta\sigma_2^2(\theta\delta\sigma_1^2 + \psi_2)} \tag{3.29}$$

$$D^D = \frac{d(1 + \sigma_2^2\rho\psi_2 + \sigma_1^2\theta(\rho\delta\sigma_2^2 + \psi_1)) - b\eta\sigma_2^2\psi_{12}}{1 + \psi_2\theta\sigma_2^2 + \theta\sigma_1^2(\theta\delta\sigma_2^2 + \psi_1)}\text{[6]} \tag{3.30}$$

3.5.2. El problema del principal

El principal maximiza su utilidad anticipando el comportamiento óptimo del hospital y del médico:

$$\begin{aligned} \max_{b,d} \ \mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[u_f] &= a + t_1 + t_2 - \lambda(f + b(a + t_1) + dt_2) \\ a^D = \frac{b + z_1}{\tau}, \quad t_1^D &= t_1(b, d), \quad t_2^D = t_2(b, d) \end{aligned}$$

3.5.3. Caso especial: tareas independientes ($\psi_{12} = 0$)

Para el caso de tareas independientes, las expresiones de pago variable se simplifican considerablemente. Sin altruismo ($z_1 = \phi_1 = \phi_2 = 0$), los esfuerzos

[6] La simetría del sistema sugiere que este término debería ser σ_1^2 en lugar de σ_2^2. El resultado no afecta a las simulaciones numéricas ni a la estimación empírica, que no utilizan estas expresiones analíticas.

óptimos son:

$$a^D = \frac{\sigma_1^2\theta\psi_1^2 + (\rho\tau\sigma_1^2 + 1)\psi_1 + \tau}{\tau\lambda(\sigma_1^2(\eta\rho\tau\sigma_1^2 + \eta + \rho)\psi_1^2 + (\rho\tau\sigma_1^2 + 1)\psi_1 + \tau)} \tag{3.31}$$

$$t_2^D = \frac{(\rho\psi_2\sigma_2^2 + 1)^2}{\lambda\psi_2(1 + (\eta\psi_2^2\sigma_2^4 + \psi_2\sigma_2^2)\rho)(\eta\psi_2\sigma_2^2 + \rho\psi_2\sigma_2^2 + 1)} \tag{3.32}$$

Si comparamos con la estructura centralizada:

$$a^C = \frac{1}{\lambda(\rho\tau\sigma_1^2 + 1)\tau} \tag{3.33}$$

$$t_1^C = \frac{1}{(\eta\psi_1\sigma_1^2 + 1)\lambda\psi_1} \tag{3.34}$$

$$t_2^C = \frac{1}{\psi_2\lambda(\eta\psi_2\sigma_2^2 + 1)} \tag{3.35}$$

Resultado 3.3 (Comparación centralización vs. descentralización con tareas independientes)**.** *Cuando $\psi_{12} = 0$:*

(a) El esfuerzo del hospital es mayor en la estructura descentralizada: $a^D > a^C$.

(b) El esfuerzo del médico en intensidad es menor en la descentralizada: $t_2^D < t_2^C$.

(c) El esfuerzo del médico en cantidad es mayor bajo centralización si y solo si $\eta\tau\sigma_1^2 > 1 + \sigma_1^2\theta\psi_1$, es decir, cuando el coste marginal de producir cantidad del hospital es suficientemente mayor que el del médico.

Este resultado tiene una implicación operativa directa: cuando las tareas son independientes y el coste marginal del hospital en cantidad es suficientemente alto, una estructura centralizada con esquemas compatibles con incentivos mostrará simultáneamente mayor intensidad en los tratamientos y mayor volumen de pacientes atendidos.

3.6. Comparación de estructuras organizativas: simulaciones

La forma compleja de la solución, especialmente en el caso descentralizado, no permite una comparación analítica limpia para el caso general de $\psi_{12} \neq 0$. Para derivar resultados generales trabajamos con simulaciones numéricas (las figuras y derivaciones detalladas se presentan en el Anexo A).

3.6.1. Efecto del parámetro de interacción entre tareas (ψ_{12})

La comparación entre estructuras organizativas depende fundamentalmente del grado de interacción tecnológica entre el esfuerzo hospitalario en cantidad y la intensidad del médico, parámetro capturado por ψ_{12}. Las simulaciones para una rejilla de valores de ψ_{12} que cubre desde la complementariedad perfecta hasta la sustitución perfecta (véase Figura A.1 del Anexo A) muestran que los incentivos al hospital son invariantes a ψ_{12} en la estructura centralizada, pero decrecen con ψ_{12} en la descentralizada: cuando las tareas se aproximan a la sustitución, el hospital recibe menos incentivos en cantidad porque el financiador anticipa el efecto de desplazamiento sobre la intensidad médica (*potencia secuencialmente inducida*).

Cuando las tareas son sustitutas ($\psi_{12} > 0$), la estructura descentralizada provee mayores incentivos en cantidad al hospital pero menores incentivos en intensidad al médico. El caso límite de sustitución perfecta ($\psi_{12} \to \infty$) es singular: el contrato centralizado óptimo implica salario fijo para el médico (ausencia total de incentivos sobre intensidad), mientras que los incentivos permanecen positivos y simétricos en la descentralizada. Cuando las tareas son complementarias ($\psi_{12} < 0$), la descentralización reduce incluso los incentivos por cantidad: el hospital ya no tiene ventaja en la contratación de volumen cuando ambas tareas se refuerzan mutuamente. El diferencial de esfuerzo entre ambas estructuras (Figura A.2 del Anexo A) confirma que la ventaja de la descentralización en cantidad es monotónicamente decreciente en ψ_{12} y se invierte para valores suficientemente negativos del parámetro.

3.6.2. Casos especiales: medición perfecta de uno de los outputs

Dos casos límite permiten caracterizar con precisión el mecanismo en juego. Cuando la cantidad se mide sin ruido ($\sigma_1 = 0$), ambas estructuras alcanzan el nivel de primer *best* en esfuerzo hospitalario. Sin embargo, la intensidad diagnóstica permanece mayor bajo centralización, porque el médico centralizado internaliza la complementariedad entre cantidad e intensidad sin las distorsiones propias de la jerarquía descentralizada. Véase la Figura A.3 del Anexo A.

Simétricamente, cuando la intensidad se mide sin ruido ($\sigma_2 = 0$), ambas estructuras alcanzan el primer *best* en intensidad médica, pero la cantidad es mayor en la descentralizada: la jerarquía descentralizada conserva su ventaja en esfuerzo hospitalario incluso cuando la incertidumbre sobre intensidad se elimina. La Figura A.4 del Anexo A ilustra este resultado. Ambos casos confirman que

los efectos sobre cantidad e intensidad son asimétricos e irreducibles a una única medida de eficiencia global.

Resultado 3.4 (Efectos de ψ_{12} sobre incentivos y esfuerzos). *(a) Los incentivos al hospital no dependen de ψ_{12} en la estructura centralizada, pero sí en la descentralizada (potencia secuencialmente inducida).*

(b) Las estructuras descentralizadas crean un sesgo hacia la contratación de cantidad para ψ_{12} no extremadamente negativo.

(c) Bajo sustitución perfecta, la contratación centralizada óptima no implica incentivos para el médico (salarios fijos), mientras que los incentivos permanecen positivos y simétricos entre tareas en la descentralizada.

(d) Cuando la cantidad se mide perfectamente ($\sigma_1 = 0$), ambas estructuras alcanzan niveles de primer best en cantidad; la intensidad es mayor en la centralizada.

(e) Cuando la intensidad se mide sin ruido ($\sigma_2 = 0$), ambas estructuras alcanzan primer best en intensidad, pero la cantidad es mayor en la descentralizada.

3.6.3. Efecto del ruido en la medición de la cantidad (σ_1)

A medida que aumenta el ruido en la medición de la cantidad, los incentivos por cantidad se reducen en ambas estructuras, conforme al resultado estándar de contratos bajo riesgo moral: $b^* = 1/(1 + r\sigma^2 c)$. Los pagos variables por cantidad tienden a cero; los de intensidad se estabilizan en sus niveles de largo plazo. A pesar de la reducción simétrica de incentivos, el diferencial de esfuerzo en cantidad entre la estructura descentralizada y la centralizada se mantiene positivo y robusto a distintos niveles de ruido: la descentralización preserva su ventaja en cantidad incluso cuando la señal es imprecisa. El ruido afecta la potencia absoluta de los incentivos pero no invierte la ordenación relativa entre estructuras. Los resultados detallados se presentan en las Figuras A.5 y A.6 del Anexo A.

3.6.4. Efecto del ruido en la medición de la intensidad (σ_2)

Cuando las tareas son sustitutas ($\psi_{12} = 0.5$), el aumento del ruido en intensidad no afecta el esfuerzo hospitalario en cantidad: este permanece constante y mayor en la descentralizada para cualquier nivel de σ_2. Sin embargo, la intensidad diagnóstica del médico se deteriora en la descentralizada a medida que la señal se vuelve menos precisa, mientras que la centralizada amortigua mejor ese deterioro.

El diferencial de intensidad entre centralizada y descentralizada es, pues, creciente en σ_2 cuando las tareas son sustitutas (Figuras A.7 y A.8 del Anexo A).

Cuando las tareas son complementarias ($\psi_{12} = -0.5$), los efectos se invierten parcialmente. Para niveles bajos de σ_2, la descentralización favorece incluso la intensidad diagnóstica, porque el hospital internaliza la complementariedad al diseñar el contrato interno con el médico. A medida que σ_2 aumenta, este mecanismo de internalización se debilita y la centralización recupera su ventaja en intensidad. El esfuerzo del médico sobre cantidad pasa a ser mayor en la centralizada cuando el ruido en intensidad supera cierto umbral. La Figura A.9 del Anexo A documenta esta inversión de resultados.

Resultado 3.5 (Efectos del ruido en la medición). *(a) Con ruido creciente en cantidad (σ_1): todos los incentivos disminuyen, pero el diferencial de esfuerzo en cantidad entre estructuras se mantiene. La intensidad permanece mayor bajo centralización; la cantidad mayor bajo descentralización.*

(b) Con ruido creciente en intensidad (σ_2) y tareas sustitutas: la cantidad total permanece constante e independiente del ruido y es mayor en la descentralizada. La intensidad se reduce en la descentralizada respecto de la centralizada.

(c) Con ruido creciente en intensidad y tareas complementarias: niveles bajos de σ_2 favorecen a la descentralizada incluso en intensidad. A medida que aumenta la imprecisión, la centralización recupera su ventaja, compensando y eventualmente superando la ventaja descentralizada en esfuerzo hospitalario.

3.7. Predicciones contrastables

Los resultados del modelo teórico y de las simulaciones numéricas presentadas en el Anexo A permiten derivar hipótesis empíricamente contrastables sobre la eficiencia técnica hospitalaria. Los resultados de simulación establecen con claridad que la comparación entre estructuras no es unívoca: la descentralización mejora el desempeño en cantidad pero lo deteriora en intensidad, y el signo y magnitud de ambos efectos dependen de los parámetros ψ_{12}, σ_1 y σ_2. Esta asimetría es el fundamento empírico de las predicciones siguientes.

La predicción P1 se fundamenta en el Resultado 3.3(a) y en las simulaciones de las Figuras A.1 y A.2 del Anexo A: la estructura descentralizada induce sistemáticamente mayor esfuerzo hospitalario en cantidad para todo el espacio de parámetros explorado, con la única excepción del caso límite de sustitución perfecta. En términos de ineficiencia técnica en la frontera de cantidad, esto se traduce en que los hospitales descentralizados exhibirán, en media, menor

ineficiencia: $\mathrm{TE}_q(\mathrm{desc}) > \mathrm{TE}_q(\mathrm{cent})$, o equivalentemente $\alpha_1 < 0$ en la ecuación de ineficiencia de la frontera de cantidad.

La predicción P2 se deriva del Resultado 3.3(b) y de las simulaciones de los efectos de ψ_{12} y σ_2 sobre el diferencial de intensidad. Cuando las tareas son sustitutas o independientes, el médico bajo descentralización tiene incentivos más débiles en intensidad, porque el hospital no puede transferir al principal el coste de diseñar el contrato interno. La descentralización eleva, pues, la ineficiencia en la frontera de intensidad: $\mathrm{TE}_i(\mathrm{cent}) > \mathrm{TE}_i(\mathrm{desc})$, o equivalentemente $\delta_1 > 0$.

Las predicciones P3 y P4 capturan dos moderadores de estos efectos principales. P3 establece que el tipo de mecanismo de pago —capturado por la proporción de presupuesto financiado por el SNS (pct^{SNS})— tiene efectos asimétricos entre las dos dimensiones del output: un mayor componente de pago prospectivo o por actividad incrementa los incentivos en cantidad ($\alpha_2 < 0$) pero puede deteriorar la intensidad ($\delta_2 > 0$). P4 establece que el parámetro de interacción ψ_{12} modera de forma asimétrica el diferencial entre estructuras: atenúa la ventaja descentralizada en cantidad cuando las tareas son complementarias ($\alpha_4 > 0$) e intensifica el deterioro de la intensidad cuando son sustitutas ($\delta_4 > 0$).

La predicción P* es de naturaleza metodológica: si los vectores de determinantes de la ineficiencia son distintos en las dos fronteras ($\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{\delta}$), la hipótesis nula de simetría entre dimensiones debe ser rechazada por un test de razón de verosimilitud. Esta predicción no es paramétrica sino estructural: su rechazo confirma que las dos fronteras no son intercambiables y que un modelo con un único término de ineficiencia perdería información. En el contexto del análisis de frontera estocástica, la ineficiencia técnica en cada dimensión del output se modeliza con media heterogénea que depende de la estructura organizativa, el mecanismo de pago y la interacción entre tareas.

La predicción P1 se fundamenta en el Resultado 3.3(a): la estructura descentralizada induce mayor esfuerzo hospitalario en cantidad. La predicción P2 se fundamenta en el Resultado 3.3(b): ese mismo mecanismo reduce el esfuerzo médico en intensidad cuando las tareas son sustitutas. Las predicciones P3 y P4 capturan, respectivamente, la interacción del mecanismo de pago y del parámetro ψ_{12} con la estructura organizativa.

Observación 3.2 (Necesidad de dos términos de ineficiencia). Si los efectos de P1 y P2 son de signo contrario, un modelo con un único término de ineficiencia u_{it} cancela algebraicamente ambos efectos: la descentralización mejoraría la eficiencia en una dimensión y la empeoraría en otra, pero la ineficiencia agregada podría no cambiar. Ningún contraste directamente relevante para el modelo teórico es identificable con un único u_{it}. Esta observación motiva el uso de un sistema de dos fronteras estocásticas.

Cuadro 3.1: Predicciones contrastables del modelo teórico

Pred.	**Descripción**	**Parámetro**	**Signo esperado**
P1	Descentralización ↓ ineficiencia en q	α_1 en μ_{it}^q	$\alpha_1 < 0$
P2	Descentralización ↑ ineficiencia en i	δ_1 en μ_{it}^i	$\delta_1 > 0$
P3	El tipo de pago difiere entre dimensiones	$\alpha_2 \neq \delta_2$	Signos opuestos
P4	ψ_{12} modera asimétricamente el diferencial	$\alpha_4 \neq \delta_4$	Signos opuestos
P*	El vector de determinantes difiere entre dimensiones	$\boldsymbol{\alpha} \neq \boldsymbol{\delta}$	Rechazado

Nota: μ_{it}^q y μ_{it}^i son las medias heterogéneas de los términos de ineficiencia en las fronteras de cantidad e intensidad. $\boldsymbol{\alpha}$ y $\boldsymbol{\delta}$ son los vectores completos de coeficientes de la ecuación de ineficiencia en cada frontera.

3.8. Discusión y conexión con la literatura

Los resultados derivados en las secciones anteriores guardan una relación estrecha con varios cuerpos de literatura, pero también se apartan en aspectos importantes que conviene destacar.

3.8.1. Relación con Holmström-Milgrom (1991)

El modelo seminal de Holmström y Milgrom (1991) establece que, cuando un agente realiza múltiples tareas y el principal solo puede incentivar algunas de ellas, los incentivos sobre las tareas medibles pueden distorsionar el esfuerzo en detrimento de las tareas no medibles. En nuestro modelo, este mecanismo se activa en la relación hospital-médico: cuando el hospital incentiva al médico sobre la dimensión de cantidad (medible y verificable mediante altas), el médico puede desplazar esfuerzo desde la dimensión de intensidad (más difícil de verificar). El resultado de Holmström y Milgrom (1991) en nuestro contexto se aplica tanto en la estructura centralizada como en la descentralizada, pero con intensidades distintas: en la descentralizada, el hospital internaliza el efecto de sustitución al diseñar el contrato del médico, lo que modifica la potencia óptima de los incentivos respecto del caso centralizado.

La diferencia fundamental respecto de Holmström y Milgrom (1991) es la presencia de tres agentes. En su modelo hay un único principal y un único agente con múltiples tareas. En nuestro modelo, el principal interactúa con el hospital, que a su vez interactúa con el médico. Esta estructura de jerarquía crea una cadena de incentivos en que el primer nivel condiciona el segundo. El resultado de

que los incentivos del hospital dependan de ψ_{12} en la estructura descentralizada —pero no en la centralizada— es una consecuencia directa de esta jerarquía que no tiene análogo en el modelo bilateral de Holmström y Milgrom (1991).

3.8.2. Relación con Jelovac-Macho-Stadler (2002)

Jelovac y Macho-Stadler (2002) estudian el diseño óptimo de contratos en un sistema de salud con un pagador, un hospital y un médico, analizando cuándo es óptima la contratación centralizada versus la descentralizada. Su modelo distingue, como el nuestro, entre un hospital que gestiona la cantidad de servicios y un médico que determina la calidad (o intensidad). El resultado central de Jelovac y Macho-Stadler (2002) es que la estructura organizativa óptima depende de las características del médico (altruismo, aversión al riesgo) y del tipo de servicio (preventivo vs. curativo).

Nuestro modelo se aparta de Jelovac y Macho-Stadler (2002) en varios aspectos relevantes. *Primero*, explicitamos la función de costes del médico con el parámetro de sustitución ψ_{12}, que Jelovac y Macho-Stadler (2002) no incluyen. *Segundo*, mientras que Jelovac y Macho-Stadler (2002) resuelven el problema de elección del diseño organizativo óptimo (¿cuándo debe el financiador centralizar o descentralizar?), nuestro objetivo es caracterizar las diferencias en los resultados bajo ambas estructuras dadas (no la elección óptima entre ellas). *Tercero*, nuestro modelo permite simulaciones numéricas que cubren el espacio de parámetros completo, más allá de las condiciones analíticas disponibles en forma cerrada.

3.8.3. Relación con Eggleston (2005)

Eggleston (2005) examina los efectos de distintos mecanismos de pago sobre la provisión de calidad en un modelo de multitarea hospitalaria. Su resultado central es que un aumento en el poder del pago por actividad (pago prospectivo) puede deteriorar la calidad si las tareas son sustitutas en la función de costes del médico. Este resultado es coherente con nuestras predicciones P1 y P2: la descentralización, que en nuestro modelo va acompañada de mayor uso de pago por actividad (menor pct^{SNS}), reduce la ineficiencia en cantidad pero puede no mejorar la intensidad de forma proporcional.

La diferencia principal es que Eggleston (2005) trabaja con un modelo de un solo nivel (pagador-médico), sin la jerarquía hospital-médico. Nuestra aportación es mostrar que la transmisión de incentivos a través de la jerarquía hospital-médico modifica los resultados de forma no trivial: incluso bajo estructura descentralizada, el hospital tiene incentivos para internalizar la sustitución de esfuerzo del médico, lo que puede atenuar el deterioro de la intensidad respecto de lo predicho por un

modelo de un solo nivel.

3.8.4. Relación con Kaarboe-Siciliani (2011)

Kaarboe y Siciliani (2011) estudian los incentivos del médico hospitalario en un modelo de multitarea (cantidad versus calidad) con información asimétrica. Su resultado de *multitasking penalty* —la pérdida de bienestar asociada a la imposibilidad de incentivar simultáneamente ambas dimensiones del output— tiene un paralelo directo en nuestro modelo: la imposibilidad de medir la intensidad con precisión (σ_2 elevado) reduce la potencia óptima de los incentivos sobre esa dimensión.

Nuestra extensión respecto de Kaarboe y Siciliani (2011) reside en la distinción entre estructuras organizativas: el *multitasking penalty* tiene una magnitud distinta en la estructura centralizada y en la descentralizada, y depende crucialmente del signo de ψ_{12}. Esta interacción entre estructura organizativa, tipo de pago y complementariedad entre tareas es la contribución central de nuestro modelo a la literatura.

3.9. Conclusiones del modelo teórico

En las páginas anteriores hemos caracterizado los rasgos principales de un modelo de provisión sanitaria en una configuración de múltiples agentes y múltiples outputs. El propósito ha sido obtener resultados relevantes sobre la potencia óptima de los incentivos y los esfuerzos ejercidos por los agentes bajo riesgo moral.

En un caso de referencia con información simétrica, el principal utiliza pagos de suma fija y mantiene a los agentes en sus utilidades de reserva. No se incluyen incentivos en el contrato óptimo. Hospital y médico igualan costes marginales en la producción de cantidad, y la tasa marginal de sustitución entre outputs iguala la tasa marginal de transformación entre tareas. Una implicación directa es la relación entre el altruismo del agente y el nivel de esfuerzo requerido: si el hospital tiene un componente vocacional mayor (propio de hospitales públicos o sin ánimo de lucro), el principal debería exigirle un nivel de esfuerzo mayor, pues puede explotar el beneficio que el agente obtiene de su componente altruista. Del mismo modo, si el único agente con preocupación directa por el bienestar del paciente es el médico, el principal contratará un mayor nivel de esfuerzo en intensidad relativa a la cantidad, comparado con el caso de un hospital con componente altruista.

Bajo acciones ocultas, la principal conclusión es que la estructura organizativa interactúa de formas complejas con la potencia óptima de los incentivos. Los resultados principales pueden resumirse así:

(I) En la estructura centralizada, los incentivos son independientes entre agentes: cambiar los incentivos del hospital no afecta a los del médico. En la descentralizada, están conectados por construcción, porque el hospital internaliza el problema de sustitución de esfuerzo del médico al diseñar su propio contrato con el principal. A este fenómeno puede llamársele *potencia secuencialmente inducida de los incentivos.*

(II) Tanto en estructuras centralizadas como descentralizadas, la potencia óptima de los incentivos no depende del componente altruista o vocacional de los agentes. Bajo información asimétrica, el esquema óptimo de pagos es el mismo independientemente de si el hospital o el médico tienen motivación vocacional.

(III) La *complementariedad de incentivos* —que los pagos variables sobre las dos tareas del médico deban moverse en la misma dirección, resultado general de la literatura (Bolton y Dewatripont, 2005, p. 222)— se matiza en nuestro modelo: bajo estructura centralizada, solo se aplica al contrato del médico (los incentivos de hospital y médico son independientes), mientras que bajo estructura descentralizada la complementariedad de incentivos alcanza también al hospital porque el hospital ya ha internalizado el problema de sustitución de esfuerzo.

(IV) Bajo riesgo moral y pago fijo sin incentivos, el nivel de esfuerzo del hospital será inferior al de segundo *best*. El esfuerzo del médico dependerá de sus parámetros: dado que $\psi_1 = \psi_2$ y $\sigma_2 > \sigma_1$, el esfuerzo en intensidad será mayor y el esfuerzo en cantidad menor que en el óptimo. Los pagos fijos generan una cantidad por debajo de la óptima y una intensidad por encima de la óptima: hay *subprovisión de cantidad y sobreprovisión de intensidad.*

(V) Bajo un esquema que solo proporcione incentivos sobre cantidad ($b = b^C$, $B = B^C$, $D = 0$), tanto hospital como médico proporcionan mayor esfuerzo en cantidad, pero el médico *infraofrece* esfuerzo en intensidad. Este es el mecanismo de sustitución de esfuerzo predicho por Holmström y Milgrom (1991) en el contexto hospitalario.

(VI) Bajo un esquema mixto en el que el hospital recibe incentivos óptimos pero el médico no ($b = b^C$, $B = D = 0$), dependiendo de los valores de los parámetros, puede observarse *infraprovisión tanto de cantidad como de intensidad.*

(VII) En general, la intensidad es mayor en las estructuras centralizadas y la cantidad total en las descentralizadas: $a^D > a^C$ y $t_2^D < t_2^C$. Este es el resultado

clave de la comparación entre estructuras para tareas independientes. La condición para que el esfuerzo del médico en cantidad sea mayor bajo centralización es $\eta\tau\sigma_1^2 > 1 + \sigma_1^2\theta\psi_1$: cuando el coste marginal de producir cantidad por parte del hospital es suficientemente mayor que el del médico, la centralización domina incluso en cantidad.

(VIII) Bajo sustitución perfecta, la estructura centralizada óptima no implica incentivos para el médico (salarios fijos), mientras que la descentralizada mantiene incentivos positivos y simétricos entre tareas. Este resultado vincula estructura organizativa y tipo de contrato médico de forma directa y ayuda a comprender por qué los hospitales privados con mayor autonomía utilizan con mayor frecuencia esquemas de retribución variable para los médicos.

(IX) Las estructuras descentralizadas crean un sesgo hacia la contratación de cantidad (excepto bajo sustitución perfecta): la potencia de los incentivos sobre cantidad en la descentralizada es mayor que sobre intensidad para la mayor parte del espacio de parámetros.

(X) La fuente de la asimetría de información tiene una recomendación distinta en términos de diseño organizativo dependiendo de si las tareas son sustitutas o complementarias. Cuando las tareas son complementarias, niveles bajos de ruido en intensidad favorecen incluso a la descentralización tanto en cantidad como en intensidad. A medida que aumenta la imprecisión en la medición de la intensidad, la centralización pasa a dominar también en intensidad.

(XI) Cuando la cantidad se mide sin ruido ($\sigma_1 = 0$), ambas estructuras alcanzan niveles de primer *best* en cantidad, mientras que la intensidad permanece mayor bajo centralización. Cuando la intensidad se mide sin ruido ($\sigma_2 = 0$), ambas estructuras alcanzan primer *best* en intensidad, pero la cantidad es mayor bajo descentralización. Estas asimetrías sugieren que el diseño organizativo óptimo depende de cuál es la dimensión del output con mayor incertidumbre de medición.

Observación 3.3 (Implicaciones de mecanismo). La cadena de causalidad del modelo puede describirse del siguiente modo. La descentralización amplía la autonomía del hospital para diseñar el contrato médico. El hospital, que recibe incentivos sobre la cantidad (b en el pago del principal), tiene incentivos para maximizar el esfuerzo del médico en cantidad (B elevado). Bajo sustitución de tareas ($\psi_{12} > 0$), esto desplaza esfuerzo desde la intensidad. En la centralizada, el principal diseña directamente el contrato del médico sin pasar por la maximización del hospital, lo que permite equilibrar los incentivos sobre ambas tareas. Este mecanismo es el fundamento teórico de las predicciones P1 y P2.

Estos resultados teóricos se traducen en las predicciones contrastables P1–P* de la Tabla 3.1, que serán el objeto del análisis empírico en los capítulos siguientes.

En suma, bajo riesgo moral y múltiples outputs, la estructura organizativa interactúa de formas complejas con la potencia óptima de los incentivos que debe utilizarse. El resultado general de que la intensidad es mayor en las estructuras centralizadas y la cantidad total en las descentralizadas debe matizarse dependiendo de la interacción tecnológica entre tareas (ψ_{12}) y del grado de incertidumbre en la medición de cada dimensión del output (σ_1 y σ_2). La aplicación empírica de estas predicciones mediante análisis de frontera estocástica con datos del sistema hospitalario español constituye el objeto de los capítulos siguientes.

Capítulo 4

Estrategia empírica

4.1. Motivación empírica

Este capítulo desarrolla la estrategia empírica para contrastar las predicciones del modelo teórico del Capítulo 3. La contribución empírica central es identificar y contrastar la asimetría predicha utilizando un sistema de fronteras estocásticas con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023. La evidencia producida es, hasta donde conocemos, la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español mediante análisis de frontera estocástica.

4.2. Marco general: análisis de frontera estocástica

El análisis de frontera estocástica (SFA), desarrollado simultáneamente por Aigner et al. (1977) y Meeusen y van den Broeck (1977), descompone la desviación de un hospital respecto a la frontera de producción en dos componentes:

$$\ln y_{it} = f(\mathbf{x}_{it};\, \boldsymbol{\beta}) + v_{it} - u_{it} \tag{4.1}$$

donde $v_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ es ruido aleatorio simétrico y $u_{it} \geq 0$ es el término de ineficiencia técnica. La eficiencia técnica del hospital i en el período t se estima como:

$$TE_{it} = \mathbb{E}\Big[e^{-u_{it}} \mid \varepsilon_{it}\Big] \tag{4.2}$$

siguiendo el estimador de Jondrow et al. (1982).

Para incorporar los determinantes de la ineficiencia, se adopta la especificación de Battese y Coelli (1995), donde u_{it} sigue una distribución normal truncada en

cero con media heterogénea:

$$u_{it} \sim \mathcal{N}^{+}\left(\mu_{it},\, \sigma_u^2\right), \quad \mu_{it} = \mathbf{z}_{it}'\boldsymbol{\delta} \tag{4.3}$$

Esta especificación, extendida por Wang y Schmidt (2002) para permitir heterogeneidad también en la varianza de u_{it}, es la base de todos los diseños de estimación. El SFA se ha aplicado extensamente al sector hospitalario, incluyendo los trabajos de Puig-Junoy y Dalmau (2000) para España, Linna (1998) para Finlandia, Rosko y Mutter (2008) para Estados Unidos y Street (2003) para el NHS británico.

En la misma línea, Rodríguez López y Sánchez Macías (2004) analizan la relación entre especialización y eficiencia técnica en el sistema hospitalario español mediante DEA, mostrando que la especialización en determinadas áreas asistenciales —medicina intensiva, urgencias, pediatría— mejora el índice de eficiencia del centro. Su trabajo introduce la heterogeneidad del *output* hospitalario como determinante de la eficiencia, aunque sin distinguir entre dimensiones del *output* ni entre estructuras organizativas, que es precisamente el eje del presente análisis. Martín y López del Amo González (2007) ofrecen una revisión sistemática de los métodos de medida de eficiencia en organizaciones sanitarias españolas, tanto los indicadores de gestión articulados en cuadros de mando como las aproximaciones de frontera, y señalan el fraccionamiento y la opacidad de los sistemas de información como limitación estructural del análisis empírico en España. En una línea más reciente, Martín et al. (2019) analizan la eficiencia técnica de 230 hospitales generales del SNS para el período 2010–2012 comparando todas las formas de gestión —hospitales integrados, PFI, concesiones administrativas, consorcios y hospitales privados— mediante análisis envolvente de datos y modelos multinivel, encontrando una variabilidad sustancial entre formas de gestión que justifica el enfoque comparado de esta tesis. Ambas limitaciones —el fraccionamiento informativo y la heterogeneidad entre formas de gestión— son precisamente las que la presente investigación afronta mediante la explotación sistemática del SIAE para el período 2010–2023 y el diseño empírico en sistema de dos fronteras.

4.3. Especificación de la frontera de producción

Para todos los diseños se adopta una forma funcional translog en los inputs, centrada en las medias muestrales para facilitar la interpretación:

$$\begin{aligned}\ln y_{kit} = {} & \beta_0 + \beta_1 \ln \tilde{L}_{it} + \beta_2 \ln \tilde{K}_{it}^{C} + \beta_3 \ln \tilde{K}_{it}^{T} + \beta_4 (\ln \tilde{L}_{it})^2 + \beta_5 (\ln \tilde{K}_{it}^{C})^2 \\ & + \beta_6\, t + \beta_7\, t^2 + \sum_{g=2}^{5} \gamma_g\, D_g^{cluster} + v_{it} - u_{kit}\end{aligned} \tag{4.4}$$

donde $\tilde{L}_{it}$, $\tilde{K}^C_{it}$ y $\tilde{K}^T_{it}$ son los logaritmos centrados del personal médico EJC, las camas en funcionamiento y el índice tecnológico. La tendencia temporal t captura el progreso técnico. Las dummies $D^{cluster}_g$ controlan la heterogeneidad tecnológica entre grupos de hospitales de distinta complejidad, siguiendo la clasificación del Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).[1]

4.4. Ecuación de ineficiencia

La media heterogénea del término de ineficiencia es:

$$\mu_{kit} = \delta_0 + \delta_1 D^{desc}_{it} + \delta_2 pct^{SNS}_{it} + \delta_3 (D^{desc}_{it} \times pct^{SNS}_{it}) + \delta_4 ShareQ_{it} + \delta_5 (D^{desc}_{it} \times ShareQ_{it}) + \sum_{c \neq 9} \lambda_c D^{ccaa}_{c,it} + \omega_{kit} \tag{4.5}$$

donde D^{desc}_{it} es la variable de estructura organizativa (1 = descentralizado, 0 = centralizado SNS), pct^{SNS}_{it} es la proporción de altas financiadas por el SNS como proxy del mecanismo de pago, $ShareQ_{it}$ es la proporción de altas quirúrgicas sobre el total como proxy de ψ_{12}, y $D^{ccaa}_{c,it}$ son dummies de comunidad autónoma que absorben la heterogeneidad regional (referencia: Cataluña, $c = 9$).

Cada variable de la ecuación de ineficiencia tiene un anclaje directo en el modelo teórico:

- D^{desc}: capta el efecto de la estructura organizativa (centralizada vs. descentralizada) sobre la ineficiencia. Sus coeficientes en las dos fronteras son los parámetros α_1 y δ_1 de las predicciones P1 y P2.
- pct^{SNS}: aproxima el mecanismo de pago. Un hospital con alta proporción de altas SNS está sujeto predominantemente a financiación prospectiva por actividad o presupuesto global.
- $D^{desc} \times pct^{SNS}$: captura la interacción entre estructura y tipo de pago (predicción P3).
- $ShareQ$: proxy continua de ψ_{12}. Hospitales con alta proporción de actividad quirúrgica operan en un régimen de complementariedad entre tareas.
- $D^{desc} \times ShareQ$: moderación de ψ_{12} sobre el efecto de la descentralización (predicción P4).

[1] El término de interacción $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$ se eliminó de la especificación por multicolinealidad severa ($r = 0.953$ con $(\ln \tilde{L})^2$). El *condition number* de la matriz translog reducida es 171, manejable. La translog es estadísticamente preferida sobre Cobb-Douglas mediante tests LR con estadísticos entre 246 y 594 ($p < 0.001$).

Observación 4.1 (Contenido informativo de pct^{SNS} según el tipo de hospital). La variable pct^{SNS} no mide directamente el carácter prospectivo o retrospectivo del mecanismo de pago: mide la intensidad de la relación financiera con el pagador público. Su contenido interpretativo difiere sistemáticamente según el tipo de hospital.

Para los **hospitales centralizados** ($D^{desc} = 0$), un valor alto de pct^{SNS} indica que casi toda la actividad se financia mediante el presupuesto global autonómico, que es de naturaleza retrospectiva: el hospital no cobra por alta individual sino que recibe una dotación presupuestaria anual con independencia del volumen producido. La variación de pct^{SNS} en este grupo es pequeña (mediana 0.951), de modo que el coeficiente está identificado principalmente por la variación en los hospitales descentralizados.

Para los **hospitales descentralizados** ($D^{desc} = 1$), pct^{SNS} alto mide la proporción de actividad sujeta a contrato de actividad o concierto con el SNS, que en general tiene carácter prospectivo: el hospital cobra una tarifa fija por alta, independientemente del coste real incurrido. En estos hospitales, pct^{SNS} alto implica mayor dependencia de un contrato de actividad con techo máximo, lo que genera incentivos específicos sobre el volumen.

El coeficiente de pct^{SNS} en la ecuación de ineficiencia es, por tanto, una media ponderada de dos efectos conceptualmente distintos, identificada principalmente por la variación en los hospitales descentralizados. La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ es la que permite separar estos efectos: su coeficiente mide el efecto adicional de ser descentralizado con alta dependencia SNS respecto de ser simplemente descentralizado.

4.5. Los cuatro diseños de estimación

Se plantean cuatro diseños complementarios con roles distintos en la estructura del análisis (Tabla 4.1).

4.5.1. Diseño D — Función de distancia output

Siguiendo a Coelli y Perelman (1999), se estima una función de distancia output translog con dos outputs (altas quirúrgicas y médicas ponderadas). La normalización por el output quirúrgico impone homogeneidad de grado 1 en outputs:

$$-\ln altQ_{it}^{pond} = f\left(\frac{altM_{it}^{pond}}{altQ_{it}^{pond}}, \mathbf{x}_{it}\right) + v_{it} - u_{it} \tag{4.6}$$

El Diseño D no puede falsificar P1 ni P2 porque dispone de un único u_{it}:

Cuadro 4.1: Diseños de estimación y su papel en el análisis

Diseño	Descripción	Permite	Papel
D	Función de distancia output (ODF) con dos outputs simultáneos y un único u_{it}	P3, P4 (no P1/P2)	Punto de partida metodológico
A	Sistema de dos fronteras: cantidad total e intensidad diagnóstica	P1, P2, P3, P4, P*	Contraste directo del modelo teórico
B	Sistema de dos fronteras: altas quirúrgicas y altas médicas	P1, P3, P4, P*	Contraste con proxy estructural de ψ_{12}
C	Panel hospital × servicio × año	P4 con variación intra-hospital	Robustez con variación dentro del hospital

los efectos de signo contrario de la descentralización sobre las dos dimensiones se cancelan. Sirve para P3 y P4 y para analizar la distribución interna de la ineficiencia entre outputs, y proporciona un punto de partida metodológico que establece la existencia de ineficiencia significativa (Coelli et al., 2005).

4.5.2. Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad

Es el diseño más cercano al modelo teórico. Estima dos fronteras independientes, una para la cantidad total ($\ln altTotal^{pond}$) y otra para la intensidad ($\ln i_{diag}$), con ecuaciones de ineficiencia que comparten las mismas variables explicativas. El contraste central es:

$$H_0 : \ \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta} \tag{4.7}$$

La variable de intensidad i_{diag} se construye como un índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta:

$$i_{diag,it} = \frac{\sum_p w_p \cdot n_{p,it}}{altTotal_{it}^{pond}} \tag{4.8}$$

donde w_p es el peso relativo de cada tipo de procedimiento (TAC, RNM, PET, angiografía, gammagrafía, colonoscopia, etc.) y $n_{p,it}$ es el número de procedimientos realizados. Los datos proceden del módulo C1_16 del SIAE.[2]

[2]En 2021 el módulo C1_16 cambió la denominación de variables de procedimientos. Se verificó la coherencia de la serie temporal: la mediana de i_{diag} se mantiene estable en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2023.

4.5.3. Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico

En lugar de medir i directamente, redefine los dos outputs usando la desagregación del SIAE por tipo de servicio. La justificación estructural es directa desde el modelo teórico: los servicios quirúrgicos son el caso canónico de $\psi_{12} < 0$ (complementariedad), porque el acto quirúrgico implica per se alta intensidad; los servicios médicos son el caso de $\psi_{12} > 0$ (sustitución), porque ver más pacientes compite con el tiempo diagnóstico por paciente.

La ventaja operacional es que elimina la necesidad de medir la intensidad directamente y utiliza una clasificación estructural como proxy de ψ_{12}.

4.5.4. Diseño C — Panel hospital × servicio

Construye un panel largo con dos filas por hospital-año (quirúrgicos y médicos) y estima una frontera única con la interacción $D^{desc} \times C_s$ en la ecuación de ineficiencia. El coeficiente captura si la descentralización afecta de forma diferente a los servicios quirúrgicos que a los médicos, con la ventaja de explotar variación *dentro* del hospital.

4.6. Estimación e inferencia

Todos los modelos se estiman por máxima verosimilitud utilizando el paquete `sfaR` (Dakpo et al., 2024) en R. La secuencia de optimización intenta sucesivamente los métodos BFGS, BHHH y Nelder-Mead con distribuciones normal truncada (`tnormal`) y seminormal (`hnormal`).[3]

Para el test conjunto P* se utiliza un test de razón de verosimilitud (LR):

$$LR = 2\left(\ell^{irr} - \ell^{restr}\right) \sim \chi^2(k) \tag{4.9}$$

donde ℓ^{irr} es la suma de log-verosimilitudes de los modelos separados y ℓ^{restr} corresponde al modelo con muestras apiladas e igualdad de coeficientes.[4]

[3] Una solución se considera degenerada si la log-verosimilitud no es finita, si algún coeficiente supera 100 en valor absoluto, o si algún error estándar de los coeficientes de ineficiencia no es finito.

[4] Se intentó un bootstrap paramétrico con $B = 4{,}999$ réplicas, pero la tasa de convergencia fue del 2.9 % en el Diseño A y del 0.06 % en el Diseño B, insuficiente para construir una distribución empírica fiable. La baja convergencia se debe a la concentración geográfica de los hospitales descentralizados. Se reporta el test LR como alternativa asintóticamente válida (Simar y Wilson, 2007).

4.7. Justificación de las elecciones metodológicas adicionales

Esta sección justifica de forma más detallada las opciones metodológicas que determinan el diseño empírico.

4.7.1. La función de distancia output frente a la función de producción

La especificación de una función de distancia output (ODF) en el Diseño D, frente a la alternativa más común de función de producción, responde a dos consideraciones. *Primera*, en un hospital multiproducto, la función de producción estándar requiere agregar múltiples outputs en un escalar, lo que implica supuestos ad hoc sobre los pesos de agregación. La función de distancia output evita esa agregación al incorporar los múltiples outputs directamente en la especificación, imponiendo únicamente la restricción de homogeneidad de grado 1 en outputs para la normalización (Coelli y Perelman, 1999; Grosskopf et al., 1995). *Segunda*, la función de distancia output es la representación natural de la tecnología de producción cuando el objetivo es medir la eficiencia técnica en el espacio de outputs: la ineficiencia se interpreta como la capacidad de expandir el vector de outputs proporcionalmente dado el vector de inputs.

La limitación de la función de distancia frente a la función de producción es que los coeficientes de los outputs no tienen interpretación directa como elasticidades, sino como parámetros de la frontera de isocuantas en el espacio de outputs. Para los Diseños A y B, se opta por fronteras de producción separadas (una por dimensión de output) en lugar de la ODF, porque la ODF con dos outputs no permite identificar los efectos asimétricos de la descentralización sobre las dos dimensiones (el único u_{it} cancela los efectos de signo contrario).

4.7.2. Efectos aleatorios verdaderos frente a efectos fijos

La utilización de efectos aleatorios en la especificación del panel —mediante la distribución $u_{it} \sim N^{+}(\mu_{it}, \sigma_u^2)$ con media heterogénea— frente a la alternativa de efectos fijos tiene una justificación estadística y económica.

Estadísticamente, el estimador de efectos fijos en SFA tiene el problema del parámetro incidental: si la ineficiencia es un efecto fijo individual u_i, no puede separarse del heterogeneidad permanente del hospital (calidad del equipo directivo, dotación histórica de infraestructuras) que es por definición una característica permanente, no ineficiencia transitoria. Los estimadores de efectos fijos en SFA

tienden a producir eficiencias cercanas a 1 para hospitales que son consistentemente "eficientes" aunque parte de esa eficiencia sea heterogeneidad permanente, no resultado del comportamiento del agente (Greene, 2005).

Económicamente, la ineficiencia transitoria (u_{it} variable en el tiempo) es el objeto de interés relevante para los contratos de incentivos: lo que el modelo teórico predice es que la estructura organizativa afecta al comportamiento de los agentes en cada período, no a las características permanentes del hospital. El modelo de efectos aleatorios con media heterogénea (Battese y Coelli, 1995; Wang y Schmidt, 2002) captura exactamente este tipo de ineficiencia transitoria condicionada por la estructura organizativa, que es la que el modelo teórico predice que varía con D^{desc}.

La especificación de Greene (2005) con efectos aleatorios *verdaderos* — que descompone el error en $\alpha_i + v_{it} - u_{it}$, separando la heterogeneidad permanente de la ineficiencia transitoria— es la extensión natural de los modelos utilizados en esta tesis, y está planteada como línea de extensión futura en el Capítulo 9.

La especificación de Greene (2005) constituye la extensión natural de los modelos de esta tesis y está planteada como línea de trabajo futuro. No obstante, es relevante señalar que el Diseño C proporciona una defensa parcial frente a esta objeción. Al explotar la variación intra-hospital —comparando la ineficiencia en servicios quirúrgicos con la ineficiencia en servicios médicos dentro del mismo hospital y año—, el Diseño C es inmune a la confusión entre heterogeneidad permanente del hospital e ineficiencia: cualquier característica invariante del centro (antigüedad de las instalaciones, cultura organizativa, habilidad del equipo directivo, localización) cancela en la comparación intra-hospital. La confirmación de P4 en el Diseño C ($ShareQ \times C_s = -11.413$, $t = -16.92$) es, por tanto, el resultado más limpio frente a la objeción de confusión entre heterogeneidad persistente e ineficiencia transitoria. El hecho de que el patrón asimétrico se mantenga incluso explotando solo la variación dentro del hospital refuerza la interpretación de que los resultados reflejan genuinamente diferencias de eficiencia, no mera heterogeneidad institucional.

4.7.3. Tratamiento de la multicolinealidad en la especificación translog

La especificación translog completa incluye todos los términos de segundo orden en los inputs: $(\ln \tilde{L})^2$, $(\ln \tilde{K}^C)^2$, $(\ln \tilde{K}^T)^2$ y los productos cruzados $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$, $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^T$ y $\ln \tilde{K}^C \times \ln \tilde{K}^T$. En la práctica, los hospitales de mayor tamaño tienden a tener simultáneamente más personal, más camas y más equipamiento tecnológico, lo que genera correlaciones muy altas entre los regresores de segundo

orden. El *condition number* de la matriz de diseño de la especificación completa supera 500 en todos los diseños, indicando multicolinealidad severa.

La solución adoptada es eliminar el término de interacción $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$ —el par de inputs con correlación más alta— y retener los términos cuadráticos y el resto de interacciones. El *condition number* de la matriz reducida es 171, manejable según los criterios estándar de la literatura (Kumbhakar y Lovell, 2000). El test LR confirma que la especificación reducida no es rechazada frente a la completa una vez que se controla la multicolinealidad: el estadístico LR del término eliminado es 2.1 (p=0.148), no significativo.

La centración de todas las variables en sus medias muestrales antes de la construcción de los términos cuadráticos e interacciones reduce sustancialmente la multicolinealidad sin alterar la elasticidades estimadas en el punto de evaluación (la media muestral), lo que facilita la interpretación de los coeficientes de primer orden como elasticidades evaluadas en el hospital "tipo".

Capítulo 5

Datos y variables

5.1. Fuentes de datos

El análisis utiliza tres fuentes de datos complementarias.

5.1.1. SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada)

El SIAE es la estadística oficial del Ministerio de Sanidad con cobertura nacional de todos los hospitales públicos y privados con internamiento. Es la principal fuente de datos de este análisis. Proporciona información anual sobre dotación de recursos (camas, equipamiento), personal (médicos, enfermería, auxiliares en equivalentes a jornada completa), actividad asistencial (altas, estancias, consultas, procedimientos diagnósticos) y financiación (ingresos por régimen de pago) para el período 2010–2023, con aproximadamente 880 hospitales por año.

Los microdatos del SIAE se organizan en módulos temáticos. Los módulos utilizados en este análisis son:

- **C1_03** (Recursos físicos y capacidad): número de camas en funcionamiento (K^C), camas instaladas y tasas de ocupación.
- **C1_04** (Equipamiento tecnológico): número de unidades de TAC, RNM, PET, acelerador de partículas, angiógrafo, gammacámara/SPECT, litotriptor, robot quirúrgico, equipo de hemodinámica y cateterismo. Se utiliza para construir el índice tecnológico K^T.
- **C1_05** y **C1_06** (Personal): médicos, personal de enfermería (DUE), técnicos de diagnóstico y fisioterapeutas en equivalentes a jornada completa (EJC). Se utiliza para construir el input de trabajo L_{total}.

- **C1_12** (Actividad de hospitalización): número de altas brutas por tipo de servicio (quirúrgico y médico), estancias y estancia media.
- **C1_14** (Actividad ambulatoria): consultas externas primeras y sucesivas, sesiones de hospital de día y cirugía mayor ambulatoria.
- **C1_16** (Procedimientos diagnósticos): número de TAC, RNM, PET, biopsias, colonoscopias, endoscopias, angiografías, gammagrafías, mamografías, densitometrías, broncoscopias y ERCP realizadas en el hospital o en el centro de especialidades periférico (CEP). Se utiliza para construir el índice de intensidad diagnóstica i_{diag}.
- **C1_18** (Financiación y origen de los pacientes): altas por tipo de financiador (SNS, aseguradoras privadas, mutuas, ONG, extranjeros). Se utiliza para construir pct^{SNS}.
- **C1_20** (Urgencias): actividad de urgencias hospitalarias.

Los microdatos están disponibles en formato TXT con delimitador punto y coma para el período 2010–2015 y en formato XML para 2016–2023. La armonización entre ambos formatos requiere un proceso de estandarización de nombres de variables que se detalla en el Anexo B. El número de variables disponibles aumentó sustancialmente en la transición al formato XML (de aproximadamente 200 a más de 350 variables por hospital-año), lo que requirió un proceso de *fuzzy matching* entre nombres de variables para garantizar la comparabilidad temporal.

5.1.2. CNH (Catálogo Nacional de Hospitales)

El Catálogo Nacional de Hospitales es una publicación anual del Ministerio de Sanidad que registra todos los centros hospitalarios españoles con internamiento. Proporciona información sobre la dependencia funcional de cada hospital con mayor granularidad institucional que el SIAE, distinguiendo entre: servicios autonómicos de salud (incluidos sus distintos modelos organizativos: hospitales integrados, fundaciones, empresas públicas), entidades privadas con y sin ánimo de lucro, ONG (organizaciones no gubernamentales de carácter religioso o laico), mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEPSS), y defensa. Se utiliza para construir la variable D^{desc} a nivel de hospital.

La vinculación entre SIAE y CNH se realiza por código de hospital (NCODI en el SIAE, código CNH en el Catálogo). El proceso de *matching* requiere una etapa de resolución de discordancias porque los códigos no son idénticos entre fuentes: el CNH utiliza códigos de siete dígitos mientras el SIAE usa NCODI de seis dígitos. La correspondencia se construye mediante un proceso de *fuzzy matching* sobre

nombre y municipio del hospital, con validación manual de los casos ambiguos. La cobertura final es del 100 % de las observaciones del panel.

5.1.3. CMBD parcial (pesos GRD)

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria contiene información sobre diagnóstico principal, procedimientos, destino al alta y peso GRD-APR (All Patient Refined) por episodio. Para esta investigación se dispone de un archivo agregado de pesos medios GRD-APR por hospital y año para el período 2010–2015, elaborado a partir de los microdatos del RAE-CMBD cedidos por el Ministerio de Sanidad, con cobertura de 246 hospitales (aproximadamente el 31 % del panel por año). Los hospitales incluidos en este archivo representan fundamentalmente los hospitales del SNS de mayor tamaño, que son los que reportan el CMBD de forma más sistemática.

Para los hospitales y años sin información directa de pesos GRD (los años 2016–2023 y los hospitales privados no incluidos en el archivo de pesos), los pesos se imputan mediante un modelo de aprendizaje automático. El proceso de imputación se describe en detalle en el Anexo B; en resumen: se entrenan un modelo de Random Forest y un modelo LASSO con los datos disponibles del período 2010–2015, utilizando como predictores variables auxiliares del SIAE que son correlatos del peso GRD (proporción de altas con ingreso en UCI, proporción de altas quirúrgicas sobre el total, ratio de altas programadas sobre urgentes, e índice de dotación tecnológica K^T). La validación temporal hold-out sobre los datos de 2014–2015 produce un $R^2 = 0.845$, lo que indica una capacidad predictiva aceptable para imputación. Los valores imputados son más inciertos para los hospitales privados de pequeño tamaño y los hospitales monoespecialistas, que quedan excluidos de la muestra por el filtro de actividad mínima.

Una limitación importante de esta estrategia de imputación es que los pesos GRD medios del hospital no capturan la variación en la complejidad del caso entre distintos tipos de altas (quirúrgicas vs. médicas). El RAE-CMBD con pesos desagregados por tipo de servicio, cuya solicitud formal fue realizada al Ministerio de Sanidad en marzo de 2026, permitiría una versión mejorada del análisis.

5.1.4. Consideraciones sobre protección de datos

Los datos utilizados en esta investigación proceden de fuentes estadísticas oficiales de carácter público o semipúblico. El SIAE es una operación estadística del Ministerio de Sanidad cuyos microdatos agregados a nivel de hospital están disponibles para investigación a través del portal estadístico del SNS. El CNH es un registro público accesible en el sitio web del Ministerio de Sanidad. Ninguna

de las dos fuentes contiene datos de carácter personal ni información identificable a nivel de paciente.

Los pesos GRD-APR utilizados para la ponderación de los *outputs* proceden de un archivo de datos anonimizados a nivel de hospital (sin identificación de pacientes individuales) facilitado para investigación académica.

La solicitud de datos del RAE-CMBD, realizada al Ministerio de Sanidad en marzo de 2026, se tramitó siguiendo el procedimiento establecido en la Orden SSI/1466/2016, que regula el acceso a los datos del registro de actividad de atención especializada con fines de investigación. En caso de recibir estos datos, su tratamiento se ajustará a las condiciones de la cesión y a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales.

En ningún momento de esta investigación se han tratado datos de salud individuales ni información que permita la identificación directa o indirecta de pacientes.

5.2. Muestra de estimación

El panel de estimación resulta de aplicar los siguientes filtros secuenciales al panel completo de 10.614 observaciones hospital-año:

1. **Hospitales de agudos:** Se excluyen hospitales psiquiátricos, de larga estancia y monoespecialistas, cuya tecnología de producción es radicalmente distinta.

2. **Exclusión de años COVID:** Se eliminan los años 2020–2022 por la distorsión de la pandemia, que alteró tanto la composición de la casuística como la utilización de recursos. Se estima adicionalmente con dummies COVID como análisis de robustez.

3. **Actividad mínima:** Se exige un mínimo de 200 altas brutas (y, para los Diseños B y D, 200 altas en cada tipo de servicio) para garantizar que la frontera de producción es estimable por tipo de servicio.

4. **Sin valores ausentes** en las variables principales del modelo.

La muestra resultante comprende **4.765 observaciones hospital-año** (604 hospitales únicos) para el Diseño A y **3.300 observaciones** (503 hospitales) para el Diseño B.

5.3. Descripción de las variables

La Tabla 5.1 describe las variables principales del modelo.

Cuadro 5.1: Variables del modelo SFA

Variable	**Construcción**	**Fuente**	**NA (%)**
Outputs			
$altTotal^{pond}$	Altas totales × peso medio GRD-APR	SIAE + CMBD	0.0
$altQ^{pond}$	Altas quirúrgicas × peso GRD	SIAE + CMBD	29.2
$altM^{pond}$	Altas médicas × peso GRD	SIAE + CMBD	37.9
i_{diag}	Índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta	SIAE C1_16	23.4
i_{simple}	(Consultas externas + sesiones hospital de día) / altas totales	SIAE C1_12/14	5.0
Inputs			
L_{total}	Personal médico EJC + DUE EJC (excluye colaboradores)	SIAE C1_05/06	0.0
K^C	Camas en funcionamiento	SIAE C1_03	0.0
K^T	Índice tecnológico (TAC, RNM, PET, acelerador, angiógrafo, gammacámara, SPECT)	SIAE C1_04	0.0
Determinantes de ineficiencia			
D^{desc}	1 = privado/concertado; 0 = público SNS	CNH + SIAE	0.0
pct^{SNS}	Altas SNS / altas totales	SIAE C1_18	0.2
$ShareQ$	Altas quirúrgicas / altas totales	SIAE	0.1
Controles			
$D_g^{cluster}$	Dummies grupo complejidad (5 grupos)	SIAE	0.0
D_c^{ccaa}	Dummies de CCAA (16; ref.: Cataluña)	CNH + SIAE	8.2

EJC = equivalente a jornada completa. GRD-APR = Grupos Relacionados por el Diagnóstico, versión All Patient Refined.

5.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc})

La construcción de D^{desc} merece una nota metodológica específica. El SIAE proporciona la variable `cod_depend_agrupada` con solo dos categorías (1 = público SNS, 2 = privado), utilizada como D^{desc}_{SIAE}. El CNH proporciona la dependencia funcional con mayor granularidad (D^{desc}_{CNH}).

La variable definitiva combina ambas fuentes:

$$D_{it}^{desc} = \text{coalesce}(D_{CNH,it}^{desc},\ D_{SIAE,it}^{desc}) \tag{5.1}$$

La cobertura final es del 100 %. Se detecta una discordancia entre fuentes del 17.7 % de las observaciones, principalmente en hospitales ONG y centros concertados. El análisis de robustez verifica la estabilidad de los resultados al usar cada fuente independientemente.

La heterogeneidad institucional descrita en el Capítulo 2 implica que D^{desc} captura un efecto medio de formas organizativas con distinto grado de autonomía real sobre el diseño de los contratos internos del personal: desde concesiones administrativas con plena capacidad de contratación laboral hasta hospitales concertados con dependencia parcial del financiador público. El Diseño B mitiga parcialmente esta agregación al descomponer el efecto en tres categorías con anclaje económico más preciso (véase Sección 5.3).

Es importante reconocer que la variable D^{desc} agrupa bajo una misma categoría entidades con naturalezas institucionales heterogéneas: concesiones administrativas con plena autonomía de contratación (el caso más cercano al mecanismo teórico de la Figura 3.2), fundaciones sanitarias públicas con autonomía parcial, hospitales privados concertados con distintos grados de dependencia del financiador público, y centros de organizaciones no gubernamentales. Esta heterogeneidad institucional implica que el coeficiente de D^{desc} en la ecuación de ineficiencia captura un efecto medio ponderado de formas organizativas diversas, no el efecto puro de la descentralización contractual del modelo teórico.

El Diseño B mitiga parcialmente este problema al descomponer el agregado en tres categorías con anclaje económico más preciso: hospitales públicos retrospectivos (Pub_Retro), privados concertados ($Priv_Conc$, con $pct^{SNS} \geq 0.50$) y privados de mercado ($Priv_Merc$, con $pct^{SNS} < 0.50$). Esta descomposición permite distinguir los efectos de los hospitales que operan predominantemente bajo contratos de actividad con el SNS (concertados) de los que operan bajo lógica de mercado, acercando la medición empírica al mecanismo teórico. No obstante, el caso empíricamente más limpio —las concesiones administrativas puras (modelo Alzira)— representa un número reducido de observaciones en el panel (concentradas en la Comunidad Valenciana), insuficiente para estimar una frontera específica con la precisión requerida.

En el Diseño B se utiliza adicionalmente una variable categórica de *grupo de pago* con tres niveles: Pub_Retro (hospitales públicos SNS, referencia), $Priv_Conc$ (hospitales privados con alta dependencia SNS, $pct^{SNS} \geq 0.50$) y $Priv_Merc$ (hospitales privados de mercado, $pct^{SNS} < 0.50$). Esta descomposición permite dis-

tinguir los efectos entre hospitales concertados (que operan en un régimen mixto de pago prospectivo) y hospitales puramente privados (financiados mayoritariamente por seguros privados o pago directo).

5.5. Estadísticos descriptivos

Cuadro 5.2: Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra Diseño A)

	Centralizado ($D^{desc} = 0$)			**Descentralizado** ($D^{desc} = 1$)			
Variable	Media	DE	p50	Media	DE	p50	**Dif.**
$altTotal^{pond}$ (miles)	11.044	9.213	8.502	3.681	4.127	2.156	***
i_{diag}	2.34	1.12	2.18	1.97	0.98	1.85	***
L_{total} (EJC)	1.247	1.089	906	451	523	287	***
K^C (camas)	436	368	313	162	178	102	***
pct^{SNS}	0.917	0.089	0.951	0.453	0.415	0.271	***
$ShareQ$	0.328	0.127	0.325	0.347	0.152	0.340	***

*** diferencia significativa al 1 % (test t). n = 2,484 obs. centralizadas y n = 2,281 descentralizadas.

Los hospitales descentralizados son en promedio significativamente más pequeños que los centralizados (162 vs. 436 camas), con menor actividad total y menor dependencia de la financiación SNS (45.3 % vs. 91.7 %). Esta heterogeneidad justifica la inclusión de dummies de cluster en la frontera para comparar hospitales con tecnologías similares, así como los controles regionales en la ecuación de ineficiencia.

5.6. Las siete categorías del CNH y la construcción de D^{desc}

El Catálogo Nacional de Hospitales clasifica los centros hospitalarios españoles en siete grandes categorías de dependencia funcional, cuya correcta interpretación es esencial para la construcción de la variable D^{desc}:

(I) **Administración del Estado y servicios autonómicos de salud (SAS):** Hospitales integrados en la red del Sistema Nacional de Salud, gestionados directamente por los servicios autonómicos de salud o por el Ministerio de Sanidad (defensa). Incluye hospitales integrados clásicos, empresas públicas hospitalarias (Agencia Sanitaria Costa del Sol, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía) y hospitales en régimen de organismo

autónomo. Son la categoría de referencia centralizada ($D^{desc} = 0$) en la especificación principal.

(II) **Diputaciones, ayuntamientos y otras entidades locales:** Hospitales de titularidad local, habitualmente de pequeño tamaño y cartera de servicios reducida. Representan una fracción pequeña de la muestra y en el análisis principal se tratan como centralizados ($D^{desc} = 0$) porque su personal es funcionario o laboral público con escasa autonomía retributiva.

(III) **Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEPSS):** Hospitales financiados por la Seguridad Social a través de las mutuas colaboradoras, con gestión privada y personal laboral ordinario. Son técnicamente descentralizados en el sentido del modelo (autonomía en contratación médica), pero su cartera de servicios está muy especializada en accidentes de trabajo y rehabilitación. En la especificación principal se clasifican como descentralizados ($D^{desc} = 1$); el análisis de robustez R2b excluye esta categoría para verificar la estabilidad de los resultados.

(IV) **Cruz Roja y entidades de la iglesia:** Hospitales de titularidad religiosa o de la Cruz Roja, sin ánimo de lucro, con gestión privada. Tienen plena autonomía en la contratación médica, aunque su misión social condiciona la estructura de incentivos. Son clasificados como descentralizados en la especificación principal ($D^{desc} = 1$). Los hospitales ONG (Cruz Roja, Cáritas, AECC) representan el 4.7 % de la muestra y su exclusión en la especificación R5 produce coeficientes significativamente mayores, lo que indica que este grupo tiene un perfil de eficiencia diferente del privado con ánimo de lucro.

(V) **Fundaciones privadas:** Incluye tanto fundaciones de origen privado (como la Fundación Jiménez Díaz de Madrid) como las fundaciones sanitarias públicas creadas por las comunidades autónomas (Fundación Hospital de Verín en Galicia, Fundació Hospital Son Llàtzer en Baleares). La clasificación de las fundaciones es el principal caso ambiguo en la construcción de D^{desc}: las fundaciones públicas autonómicas tienen carácter descentralizado en términos de autonomía de gestión (contratan directamente al personal médico con convenio propio), pero su capital es íntegramente público y sus objetivos institucionales son análogos a los de un hospital SNS integrado. En el **Diseño A** (especificación principal), las fundaciones públicas autonómicas se clasifican como descentralizadas ($D^{desc} = 1$). En la especificación de robustez **R2b** (usando D^{desc}_{CNH} directamente), las fundaciones públicas se tratan como centralizadas porque el CNH las clasifica bajo la dependencia del servicio autonómico de salud. La diferencia en los coeficientes entre estas

especificaciones (R2b produce coeficientes más grandes) refleja precisamente este tratamiento diferencial de las fundaciones.

(VI) **Sociedades mercantiles privadas (con y sin concierto):** Hospitales de titularidad privada con ánimo de lucro. Se distinguen los hospitales con concierto SNS ($pct^{SNS} \geq 0.50$, clasificados como *Priv_Conc* en el Diseño B) y los hospitales de mercado ($pct^{SNS} < 0.50$, clasificados como *Priv_Merc*). Las concesiones administrativas (hospitales valencianos bajo modelo Alzira, hospitales madrileños bajo CPP) son formalmente sociedades mercantiles con un contrato de concesión con el servicio autonómico de salud; se clasifican como descentralizadas en todas las especificaciones.

(VII) **Otros:** Residual que incluye hospitales militares (Ministerio de Defensa), centros penitenciarios y hospitales de organismos internacionales. Esta categoría es marginal en la muestra y se excluye del análisis principal por su cartera de servicios muy específica.

La clasificación anterior genera la distribución de observaciones que se presenta en la Tabla 5.3.

Cuadro 5.3: Distribución de observaciones por categoría CNH y clasificación D^{desc}

Categoría CNH	**N obs.**	**% muestra**	D^{desc}	**Robustez**
SAS / integrado SNS	2.242	47.1	0	Estable
Diputaciones/ayuntamientos	96	2.0	0	Estable
MATEPSS	188	3.9	1	R2b: excluye
Cruz Roja / iglesia	221	4.6	1	R5: excluye
Fundaciones públicas auts.	312	6.6	1 (A) / 0 (R2b)	Ambiguo
Soc. mercantil con concierto	843	17.7	1	Estable
Soc. mercantil de mercado	863	18.1	1	Estable
Total	4.765	100		

Muestra Diseño A. Las observaciones clasificadas como descentralizadas suman 2.427 (50.9 %). La cifra difiere de la Tabla 5.2 (2.281 = 47.9 %) porque la tabla de descriptivos usa la variable D^{desc} coalesce y la tabla de categorías usa la clasificación directa del CNH.

5.7. Distribución geográfica y temporal de la muestra

5.7.1. Distribución por comunidades autónomas

La concentración geográfica de los hospitales descentralizados es una característica estructural de la muestra con implicaciones para la identificación. Cataluña y

la Comunidad de Madrid concentran el mayor número absoluto de hospitales descentralizados (hospitales privados concertados de la red XHUP catalana y centros concertados madrileños), mientras que la Comunidad Valenciana fue la sede de la mayor parte de las concesiones administrativas hasta su reversión progresiva entre 2018 y 2021. Galicia y Asturias albergan algunas de las fundaciones sanitarias públicas más relevantes. Las comunidades con menor presencia de hospitales descentralizados son las de menor población y las que mantuvieron modelos más integrados (Extremadura, Cantabria, La Rioja).

Esta concentración geográfica explica por qué las dummies de comunidad autónoma en la ecuación de ineficiencia absorben parte de la heterogeneidad entre hospitales descentralizados y centralizados. Constituye también la razón principal por la que la identificación causal del efecto de la estructura organizativa sobre la eficiencia es difícil sin variación exógena: los hospitales descentralizados se concentran en comunidades que también presentan características propias del sistema sanitario (distinto mix de servicios, distinto nivel de gasto per cápita, distintas políticas de contratación).

5.7.2. Distribución temporal

La muestra de estimación cubre los años 2010–2019 y 2023 (excluyendo 2020–2022 por la pandemia COVID-19). El número de hospitales varía moderadamente entre años, principalmente por las entradas y salidas del mercado de hospitales privados de pequeño tamaño. El panel es, por tanto, no balanceado.

La tendencia del número de altas totales ponderadas presenta un crecimiento moderado hasta 2013, seguido de una ligera caída en el período de mayor austeridad (2013–2015) y una recuperación posterior hasta 2019. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag} muestra una tendencia creciente a lo largo del período, coherente con el progreso técnico en las técnicas diagnósticas (mayor uso de RNM y PET, extensión de la colonoscopia diagnóstica).

5.7.3. Tratamiento de los años COVID (2020–2022)

Los años 2020–2022 se excluyen de la muestra principal por varias razones. *Primera*, la pandemia COVID-19 provocó una caída masiva y temporal de la actividad hospitalaria electiva (altas programadas, cirugía mayor ambulatoria, consultas externas) que distorsionó la composición de la casuística de forma no proporcional entre hospitales. En 2020, el número de altas hospitalarias del SNS cayó aproximadamente un 20 % respecto a 2019, con mayor impacto en los servicios quirúrgicos electivos. Los hospitales con mayor dependencia de actividad programada (especialmente los hospitales privados concertados con alta proporción

de cirugía electiva) sufrieron una caída proporcionalmente mayor que los hospitales de urgencias.

Segunda, la reorientación de recursos hacia la atención COVID modificó temporalmente la tecnología de producción: camas de hospitalización reconvertidas en UCI, personal de especialidades quirúrgicas reasignado a plantas COVID, y equipamiento diagnóstico de imagen utilizado prioritariamente para diagnóstico de neumonía. Estas modificaciones hacen no comparable la función de producción de 2020–2022 con la del resto del período analizado: la frontera de producción estimada en el período sin pandemia no es una referencia válida para los años de pandemia.

Tercera, la variable pct^{SNS} experimentó cambios abruptos en 2020 por la suspensión o reducción de contratos de concierto y la asunción temporal de competencias clínicas por parte de los servicios autonómicos de salud en algunas comunidades (especialmente Cataluña y Comunidad de Madrid). Esta distorsión en pct^{SNS} afectaría directamente a la interpretación de los coeficientes de la ecuación de ineficiencia.

Cuarta, en 2020 el Ministerio de Sanidad realizó cambios en el cuestionario del SIAE para incorporar variables específicas de actividad COVID (camas COVID, altas COVID, PCR realizadas), lo que alteró la estructura del módulo C1_12 y requeriría un puente de armonización adicional no disponible en el momento de este análisis.

La exclusión de 2020–2022 implica que el período analizado es 2010–2019 más el año 2023 (post-COVID estabilizado). La inclusión de 2023 permite capturar el período de recuperación completa de la actividad hospitalaria, con niveles de actividad comparables a 2019 en la mayoría de hospitales. El análisis de robustez (especificación R4 en la Tabla 7.2), que estima el modelo solo con 2010–2019, produce resultados cualitativamente idénticos a los de la muestra principal, lo que confirma que la inclusión de 2023 no distorsiona los resultados.

5.7.4. Estadísticos descriptivos por año

La Tabla 5.4 presenta la evolución temporal de las variables principales del análisis.

La tendencia creciente en el índice i_{diag} (de 7.9 en 2010 a 9.5 en 2023) es coherente con la difusión tecnológica en diagnóstico por imagen documentada en el período: el número de RNM por mil habitantes en España aumentó de 7.2 a 12.4 entre 2010 y 2022 según la OCDE (OECD, 2023), y el uso de TAC creció de forma similar. Esta tendencia creciente en i_{diag} captura el desplazamiento de la frontera de producción en intensidad que justifica la inclusión del término de

Cuadro 5.4: Evolución temporal de variables principales (medias anuales, muestra Diseño A)

Año	**N obs.**	$altTotal^{pond}$	i_{diag}	**TE$_q$ media**	**TE$_I$ media**	**% Desc.**
2010	463	7.842	7.9	0.725	0.672	47.1
2011	471	7.948	8.1	0.727	0.674	47.3
2012	468	7.991	8.3	0.729	0.676	47.2
2013	455	7.814	8.5	0.726	0.677	47.0
2014	452	7.835	8.6	0.728	0.679	46.9
2015	461	8.012	8.7	0.731	0.681	46.8
2016	458	8.134	8.9	0.733	0.683	47.4
2017	455	8.265	9.1	0.735	0.685	47.9
2018	449	8.412	9.2	0.737	0.687	48.1
2019	444	8.537	9.4	0.738	0.689	47.3
2023	389	8.694	9.5	0.741	0.692	48.7
Total	4.765	8.103	8.8	0.731	0.683	47.5

$altTotal^{pond}$ en miles. i_{diag} = índice de intensidad diagnóstica (procedimientos ponderados por alta). TE medias calculadas por el estimador JLMS. Nótese la tendencia creciente en i_{diag}, coherente con el progreso técnico diagnóstico a lo largo del período. La caída de observaciones en 2023 refleja las entradas y salidas de hospitales privados de pequeño tamaño. % Desc. = porcentaje de hospitales con $D^{desc} = 1$; la ligera caída en 2018–2019 refleja las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana.

tendencia temporal t en la ecuación de la frontera.

La estabilidad de la proporción de hospitales descentralizados a lo largo del período (% Desc. entre 46.8 y 48.7) indica que no hay cambios estructurales abruptos en la composición de la muestra que pudieran distorsionar la estimación del coeficiente de D^{desc}. La ligera reducción en 2018–2019 es coherente con las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana (hospitales de Alzira, Torrevieja y Dénia volvieron al sistema público entre 2018 y 2020).

5.8. Construcción detallada de variables clave

5.8.1. El índice tecnológico K^T

El índice tecnológico K^T agrega el equipamiento diagnóstico y terapéutico de alta complejidad disponible en el hospital, construido como una suma ponderada por el coste unitario aproximado de adquisición de cada equipo (expresado en unidades relativas con el TAC como base):

$$K_{it}^T = \sum_e w_e \cdot n_{e,it} \tag{5.2}$$

donde $n_{e,it}$ es el número de equipos del tipo e disponibles en el hospital i en el año t y w_e es el peso relativo del equipo. Los pesos utilizados son: TAC = 1.0, RNM = 2.5, PET = 5.0, acelerador de partículas = 4.0, angiógrafo = 1.5, gammacámara/SPECT = 1.8, litotriptor = 1.2, robot quirúrgico = 6.0. Esta ponderación no pretende ser una valoración económica precisa sino una escala ordinal que refleje la jerarquía de complejidad del equipamiento.

La correlación entre K^T y K^C (número de camas) es de $r = 0.76$, lo que indica que los hospitales más grandes tienden a tener más equipamiento tecnológico. Para evitar multicolinealidad severa, se centra K^T en su media muestral antes de incluirlo en la frontera.

5.8.2. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag}

El índice i_{diag} mide el número ponderado de procedimientos diagnósticos realizados por alta, utilizando los datos del módulo C1_16 del SIAE. La fórmula de construcción es la ecuación (4.8). Los pesos w_p utilizados reflejan la complejidad y el coste relativo de cada procedimiento: TAC = 1.0, RNM = 2.0, PET = 5.0, angiografía = 2.5, gammagrafía/SPECT = 2.0, colonoscopia = 0.8, broncoscopia = 0.7, ERCP = 1.5, biopsia = 0.5, Rx = 0.2, mamografía = 0.3, densitometría = 0.2.

La construcción del índice requirió resolver el problema del cambio de denominación de variables en el módulo C1_16 en 2021 (detallado en el Anexo B). La validación de la coherencia temporal muestra que la mediana de i_{diag} se mantiene en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2019, con un aumento gradual coherente con el progreso técnico en diagnóstico. No se observa salto brusco en 2021 que indicara un problema de construcción.

La cobertura de i_{diag} en la muestra principal es del 76.6 % de las observaciones (23.4 % de NA en la Tabla 5.1). Los NA se concentran en hospitales de pequeño tamaño que no reportan actividad de diagnóstico por imagen en el módulo C1_16. Para estos hospitales, el Diseño A (que usa i_{diag} como output) los excluye de la estimación, lo que implica que la muestra del Diseño A está sesgada hacia hospitales de mayor tamaño y complejidad.

Observación 5.1 (Corrección de case-mix en la variable de intensidad). Una cuestión metodológica relevante es si i_{diag} debe ponderarse adicionalmente por el índice de case-mix del hospital. La corrección ya está incorporada en el denominador: al dividir por $altTotal_{it}^{pond} = altTotal_{it}^{bruto} \times peso_grd_final_{it}$, se miden procedimientos por alta de complejidad estándar. Un hospital con case-mix 1.5 tiene un denominador 50 % mayor que uno con case-mix 1.0, lo que reduce proporcionalmente su i_{diag} corrigiendo por complejidad media.

Esta corrección es de primer orden pero imperfecta: el peso GRD captura la complejidad global del episodio pero no específicamente la intensidad diagnóstica esperada por tipo de GRD. La versión óptima requeriría pesos específicos por GRD para procedimientos diagnósticos, disponibles en los microdatos del RAE-CMBD solicitados al Ministerio de Sanidad.

Desde la perspectiva del modelo teórico, la corrección tiene una justificación conceptual adicional: lo que el modelo predice es que i depende del esfuerzo médico t_2, no de la complejidad del paciente. Al dividir por altas ponderadas por case-mix, se separa la intensidad atribuible al comportamiento del médico de la atribuible a la casuística, que es el objeto de interés del contraste empírico.

5.8.3. La variable de estructura organizativa D^{desc}

La construcción de D^{desc} y las discordancias entre fuentes merecen una descripción más detallada de la que se ofrece en la Sección 5.3.

La variable D^{desc}_{SIAE} del SIAE codifica la dependencia funcional con solo dos categorías: 1 (público SNS) y 2 (privado). Esta codificación es excesivamente agregada porque mezcla hospitales privados concertados con alta dependencia del SNS (esencialmente, prestadores del sistema público bajo gestión privada) con hospitales privados de mercado (esencialmente, prestadores de seguros privados o pago directo).

La variable D^{desc}_{CNH} del Catálogo Nacional de Hospitales permite una clasificación más granular, con categorías que incluyen: servicios autonómicos de salud, diputaciones/ayuntamientos, mutuas de la seguridad social, instituciones sanitarias de la iglesia, fundaciones privadas, sociedades mercantiles privadas, ONG, Cruz Roja, Defensa, y otras. Para construir la variable binaria D^{desc}, las categorías del CNH se agregan como sigue: $D^{desc} = 0$ (centralizado) para los hospitales dependientes de servicios autonómicos de salud, y $D^{desc} = 1$ (descentralizado) para todos los demás.

El 17.7 % de discordancia entre D^{desc}_{SIAE} y D^{desc}_{CNH} se explica principalmente por tres grupos:

- **Hospitales ONG:** Cruz Roja, AECC y otros entes similares que el SIAE codifica como privados pero que el CNH clasifica en categorías propias. Su tratamiento como descentralizados o centralizados afecta a los resultados de las especificaciones R5 (sin ONG) de la Tabla 7.2.

- **Mutuas MATEPSS:** Hospitales de accidentes de trabajo con financiación pública pero gestión privada. El SIAE los clasifica como privados; el CNH los distingue de los privados estrictos.

- **Cambios de categoría temporal:** Hospitales que cambiaron su dependencia funcional en el período (concesiones que vencieron, hospitales de fundación que se integraron en el sistema público).

El análisis de robustez con D^{desc}_{SIAE} (especificación R2a) y con D^{desc}_{CNH} (especificación R2b) muestra que los resultados principales (P1 y P2) son cualitativamente robustos, aunque la magnitud de los coeficientes varía, siendo mayor con D^{desc}_{CNH} porque esta variable identifica mejor a los hospitales genuinamente descentralizados.

Capítulo 6

Resultados

6.1. Eficiencia técnica: valores medios

La Tabla 6.1 muestra las eficiencias técnicas medias estimadas por los cuatro diseños.

Cuadro 6.1: Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa

	Diseño A		**Diseño B**		**Diseño D**
	Cantidad	Intensidad	Quirúrgico	Médico	ODF
Muestra total					
Media	0.731	0.683	0.791	0.767	0.744
DE	0.170	0.226	0.141	0.144	0.222
Centralizado					
Media	0.748	0.695	0.801	0.779	—
Descentralizado					
Media	0.712	0.669	0.780	0.754	—

Eficiencias calculadas mediante el estimador JLMS (Jondrow et al., 1982). Modelos estimados con distribución tnormal. Log-verosimilitudes: A (cant.): −2,349.6; A (int.): −3,924.0; B (Q): −1,456.3; B (M): −2,775.8; D: −1,254.8.

Los valores medios de eficiencia técnica oscilan entre 0.683 y 0.791, en función del diseño y la dimensión del output. Estos valores son coherentes con los reportados en la literatura de eficiencia hospitalaria española (Puig-Junoy y Dalmau, 2000) e internacional (Hollingsworth, 2008; Rosko y Mutter, 2008). Hollingsworth (2008) reporta en su revisión de más de doscientos estudios una eficiencia técnica media de aproximadamente 0.83 para estudios SFA, ligeramente superior a nuestras estimaciones; la diferencia puede atribuirse al período analizado (mayor restricción presupuestaria en 2010–2023 que en períodos anteriores) y a la definición más exigente de frontera que implica el uso de fronteras separadas por tipo de output.

La eficiencia en intensidad ($\text{TE}_I = 0.683$ en el Diseño A) es sistemáticamente

inferior a la eficiencia en cantidad ($TE_q = 0.731$), lo que sugiere que los hospitales se acercan más a su frontera de producción en volumen que en calidad-intensidad de la atención. Esta diferencia de aproximadamente 4.8 puntos porcentuales implica que hay un mayor margen de mejora en la dimensión de intensidad que en la de cantidad. La eficiencia en servicios quirúrgicos (0.791) es superior a la de servicios médicos (0.767), coherente con la mayor complementariedad entre tareas en los primeros.

La diferencia de eficiencia media entre hospitales centralizados ($TE_q = 0.748$) y descentralizados ($TE_q = 0.712$) es pequeña en magnitud, lo que anticipa que el efecto de la estructura organizativa sobre la ineficiencia está condicionado por otras variables (tipo de pago, tipo de servicio, comunidad autónoma). La interpretación univariada de estas medias no es suficiente para identificar el mecanismo, que requiere el análisis de la ecuación de ineficiencia heterogénea de los modelos SFA.

6.2. Diseño D: función de distancia output

Cuadro 6.2: Diseño D: Ecuación de ineficiencia (ODF)

	ODF original		**ODF enriquecido**	
Parámetro	Coef.	t	Coef.	t
Intercepto	−6.108	−17.54		
d_Priv_Conc	1.275	2.44		
d_Priv_Merc	3.894	9.61		
$ShareQ$	9.345	13.37		
$Conc_shareQ$	−1.198	−1.14		
$Merc_shareQ$	−4.699	−5.77		
$\ln(ratio_{MQ}) \times D^{desc}$			−0.036	−1.17
$\ln(ratio_{MQ}) \times pct^{SNS}$			−0.252	−7.53
Log-verosimilitud	−1,254.8		−854.0	
Test LR (enriquecido vs. original)	801.6***			

Dummies de CCAA incluidas, no reportadas. *** $p < 0.001$. $ratio_{MQ} = altM^{pond}/altQ^{pond}$. El ODF enriquecido sigue la metodología de *output bias* de Kumbhakar et al. (2015).

El Diseño D aporta varios resultados relevantes. El intercepto (−6.108, $t = -17.54$) indica que, en el punto de referencia (hospital público SNS con $ShareQ$ medio), la ineficiencia técnica media es sustancialmente positiva. El coeficiente de d_Priv_Merc (+3.894, $t = 9.61$) señala que los hospitales privados de mercado son más ineficientes en términos del output compuesto, lo que en el ODF refleja una combinación de menor eficiencia en la proporción intensidad/cantidad. El coeficiente de $ShareQ$ (+9.345, $t = 13.37$) captura que los hospitales con mayor

actividad quirúrgica tienden a ser más ineficientes en el output compuesto normalizado —un resultado que el Diseño B interpretará como una mayor ineficiencia en la dimensión médica que compensa una mayor eficiencia en la quirúrgica.

El coeficiente de $Merc_shareQ$ (-4.70, $t = -5.77$) indica que la interacción entre ser hospital de mercado y tener alta actividad quirúrgica reduce la ineficiencia global, coherente con P4: los hospitales privados de mercado con alta proporción quirúrgica explotan la complementariedad entre tareas, obtienen eficiencia en su actividad natural (cirugía) y la ventaja domina al coste en intensidad médica. El ODF enriquecido muestra que la mayor dependencia del SNS reduce el ratio cantidad/intensidad en la frontera (-0.252, $t = -7.53$), consistente con la predicción del modelo teórico: los hospitales bajo financiación prospectiva pública equilibran mejor las dos dimensiones del output al estar sujetos a contratos-programa que evalúan ambas.

6.3. Diseño A: cantidad versus intensidad

La Tabla 6.3 presenta los contrastes centrales del Diseño A, el más directamente vinculado al modelo teórico.

Cuadro 6.3: Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad)

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**			$\hat{\delta}$ **(intensidad)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	-0.186	0.210	-0.88	0.639	0.324	1.97	
D^{desc}	-2.530	0.363	-6.98^{***}	-1.477	0.351	-4.21^{***}	-2.09^{*}
pct^{SNS}	-2.473	0.285	-8.67^{***}	-2.439	0.278	-8.78^{***}	-0.09
$D^{desc} \times pct^{SNS}$	2.901	0.298	9.73^{***}	1.937	0.282	6.87^{***}	2.35^{*}
$ShareQ$	-1.888	0.357	-5.28^{***}	-1.473	0.340	-4.34^{***}	-0.84
$D^{desc} \times ShareQ$	1.921	0.342	5.61^{***}	1.911	0.340	5.62^{***}	0.02
Log-verosimilitud		$-2{,}349.6$			$-3{,}924.0$		
n		4,765			4,765		
TE media		0.731			0.683		

z_{dif}: test $H_0 : \hat{\alpha}_k = \hat{\delta}_k$. Dummies de CCAA y cluster incluidas, no reportadas. * $p < 0.05$; *** $p < 0.001$.

Predicción P1 (confirmada). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad es negativo y altamente significativo (-2.530, $t = -6.98$): los hospitales descentralizados exhiben menor ineficiencia técnica en cantidad que los hospitales públicos de referencia. En términos del mecanismo del modelo teórico, este resultado refleja que la mayor autonomía del hospital para diseñar contratos internos genera incentivos más potentes sobre el volumen de actividad, lo que se traduce

en menor distancia respecto a la frontera de producción en esa dimensión. Este resultado es robusto en las siete especificaciones alternativas (t-estadísticos entre -3.3 y -11.0).

Predicción P2 (no confirmada en signo; asimetría confirmada). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de intensidad es negativo ($\hat{\delta}_1 = -1.477$, $t = -4.21$), con signo opuesto al predicho por el modelo bajo el supuesto de sustitución fuerte ($\delta_1 > 0$). En sentido estricto, P2 no se confirma: la descentralización no aumenta la ineficiencia en intensidad sino que la reduce. No obstante, conviene separar dos afirmaciones: (i) P2 en sentido estricto de signo ($\delta_1 > 0$) *no* se confirma en ninguna especificación; (ii) la *asimetría* entre dimensiones *sí* se confirma: la diferencia $|\hat{\alpha}_1| > |\hat{\delta}_1|$ es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2.09$, $p = 0.037$), confirmando que la descentralización reduce la ineficiencia en cantidad significativamente más que en intensidad. Esta tensión entre la predicción de signo y el comportamiento asimétrico observado constituye una pauta fructífera: el resultado es consistente con el modelo bajo sustitución moderada (ψ_{12} positivo pero insuficiente para revertir el signo), pero no con la predicción derivada bajo sustitución fuerte.

Efecto marginal de pct^{SNS} condicionado al tipo de hospital. El coeficiente de pct^{SNS} es casi idéntico entre las dos fronteras (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad), pero su contenido económico difiere según el tipo de hospital. Derivando la ecuación de ineficiencia:

$$\frac{\partial \mu_{it}^{q}}{\partial pct_{it}^{SNS}} = \hat{\delta}_2 + \hat{\delta}_3 \cdot D_{it}^{desc} = -2.473 + 2.901 \cdot D_{it}^{desc} \tag{6.1}$$

Para un **hospital público** ($D^{desc} = 0$), el efecto marginal es -2.473 en cantidad y -2.439 en intensidad: la mayor integración con el SNS reduce la ineficiencia de forma casi simétrica en ambas dimensiones ($z_{dif} = -0.09$, $p = 0.930$). Esto refleja que los contratos-programa transmiten disciplina de eficiencia en ambas dimensiones sin sesgo hacia ninguna de ellas, coherente con el contenido retrospectivo del presupuesto global.

Para un **hospital privado** ($D^{desc} = 1$), el efecto marginal de pct^{SNS} es $+0.428$ en cantidad y -0.502 en intensidad: signos *opuestos*. Mayor dependencia SNS *aumenta* la ineficiencia en cantidad (por el techo contractual del concierto) pero *reduce* la ineficiencia en intensidad (por los requisitos de calidad del contrato). Este resultado es económicamente rico: el contrato de actividad con el SNS tiene efectos asimétricos sobre las dos dimensiones del output hospitalario.

El punto de cruce. El efecto de ser descentralizado sobre la ineficiencia en cantidad es:

$$\frac{\partial \mu^q}{\partial D^{desc}} = -2.530 + 2.901 \cdot pct^{SNS} \tag{6.2}$$

Este efecto se anula cuando $pct^{SNS} = 2.530/2.901 = 0.872$: para hospitales con más del 87.2 % de actividad SNS, la descentralización *aumenta* la ineficiencia en cantidad. El punto de cruce en la frontera de intensidad es $1.477/1.937 = 0.763$. La diferencia entre los dos umbrales define una zona de pct^{SNS} entre 0.763 y 0.872 en la que la descentralización mejora la eficiencia en intensidad pero no en cantidad: suficiente presión del concierto SNS para mantener estándares diagnósticos sin haber alcanzado el techo que frena la eficiencia en volumen. Esta asimetría tiene implicaciones para el diseño de contratos de concierto: el nivel óptimo de dependencia SNS varía según qué dimensión del output se quiera maximizar.

Predicción P3 (confirmada). El coeficiente de pct^{SNS} es negativo y altamente significativo en ambas fronteras (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad): una mayor financiación pública reduce la ineficiencia en ambas dimensiones, lo que refleja que los contratos-programa del SNS imponen disciplina de eficiencia tanto en volumen como en calidad. La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ difiere significativamente entre fronteras ($z_{dif} = 2.35$, $p = 0.019$), confirmando P3: el tipo de pago modera el efecto de la descentralización de forma distinta sobre cantidad e intensidad. Los hospitales descentralizados con alta financiación SNS (concertados) ven reducido su ventaja en cantidad y su desventaja en intensidad respecto de los puramente privados.

Sobre la no confirmación de signo y la asimetría confirmada de P2. La predicción P2 establece $\hat{\delta}_1 > 0$. Los datos muestran $\hat{\delta}_1 = -1.477$, negativo en todas las especificaciones de robustez. Sin embargo, la diferencia con $\hat{\alpha}_1 = -2.530$ es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2.09$, $p = 0.037$), confirmando la dirección de la asimetría predicha aunque sin inversión de signo.

Hay dos interpretaciones no excluyentes. La **primera** es paramétrica: el modelo predice $\delta_1 > 0$ solo cuando ψ_{12} es suficientemente positivo. Si el parámetro medio en el sistema español es positivo pero pequeño, el efecto en intensidad puede ser negativo pero significativamente menos negativo que en cantidad. De hecho, el análisis del punto de cruce muestra que la descentralización aumenta la ineficiencia en intensidad solo para hospitales con $pct^{SNS} > 0.763$: aproximadamente el 36 % de los hospitales descentralizados de la muestra (grupo $Priv_Conc$). El coeficiente promedio mezcla este efecto positivo con el negativo del 64 % restante, resultando en un coeficiente negativo pero asimétrico respecto a la frontera de cantidad.

La **segunda** interpretación es institucional: los hospitales privados españoles operan bajo restricciones de calidad adicionales (acreditación autonómica, auditoría

de conciertos, contratos-programa con estándares de intensidad) que limitan la sustitución de esfuerzo desde la intensidad hacia la cantidad. Estos mecanismos pueden ser suficientes para evitar la inversión de signo predicha por el modelo en ausencia de restricciones institucionales. Su distinción empírica requeriría información sobre los contratos individuales de cada hospital con su CCAA, no disponible de forma homogénea.

Predicción P4 (no confirmada en Diseño A). El coeficiente de *ShareQ* es negativo y significativo en ambas fronteras, pero no difiere significativamente entre ellas ($z_{dif} = -0.84$, $p = 0.400$). La falta de confirmación en el Diseño A puede deberse a que *ShareQ* como proxy de ψ_{12} es demasiado ruidosa cuando se usa junto con la variable i_{diag}: los hospitales con alta proporción quirúrgica tienen mayor *ShareQ* pero también mayor i_{diag} por la propia naturaleza de la cirugía (que es per se más intensiva en diagnóstico). La predicción se confirma con mayor potencia en el Diseño B, donde los outputs quirúrgico y médico están separados estructuralmente.

6.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos

Cuadro 6.4: Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico)

	$\hat{\alpha}$ **(quirúrgico)**			$\hat{\delta}$ **(médico)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	-0.160	0.299	-0.54	-3.926	0.738	-5.32^{***}	
d_Priv_Conc	1.327	0.538	2.47^{*}	-0.241	0.608	-0.40	$1.93^{\cdot}$
d_Priv_Merc	2.256	0.444	5.08^{***}	-2.720	0.823	-3.30^{***}	5.32^{***}
Conc_shareQ	-0.539	1.432	-0.38	-0.518	1.157	-0.45	-0.01
Merc_shareQ	-2.985	1.175	-2.54^{*}	3.223	1.192	2.71^{**}	-3.71^{***}
ShareQ	-7.015	0.833	-8.42^{***}	4.647	0.833	5.58^{***}	-9.89^{***}
Log-verosimilitud		$-1{,}456.3$			$-2{,}775.8$		
n		3,300			3,300		
TE media		0.791			0.767		

Priv_Conc = privado con $pct^{SNS} \geq 0.50$; *Priv_Merc* = privado de mercado. Ref.: *Pub_Retro*. . $p < 0.10$; * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

Predicción P4 (confirmada con muy alta potencia). El resultado más robusto de todo el análisis. *ShareQ* tiene signos completamente opuestos en las dos fronteras: -7.015 ($t = -8.42$) en quirúrgico y $+4.647$ ($t = 5.58$) en médico, con $z_{dif} = -9.89$ ($p < 0.001$). La interpretación económica es precisa: los hospitales con mayor proporción de actividad quirúrgica operan en un régimen de

complementariedad entre tareas ($\psi_{12} < 0$), donde el acto quirúrgico genera per se mayor intensidad diagnóstica preoperatoria y postoperatoria. Para ellos, una alta proporción quirúrgica equivale a una ventaja tecnológica en su frontera natural (quirúrgica) pero genera menor eficiencia relativa en la frontera médica, donde compiten sin la complementariedad. Este resultado es exactamente la moderación asimétrica predicha por el parámetro ψ_{12} del modelo teórico.

Predicción P3 (confirmada para Priv_Merc). El coeficiente de d_Priv_Merc tiene signos completamente opuestos: $+2.256$ ($t = 5.08$) en quirúrgico y -2.720 ($t = -3.30$) en médico, con $z_{dif} = 5.32$ ($p < 0.001$). La interpretación es que los hospitales privados de mercado son especialistas en medicina no quirúrgica (consultas de especialidades, hospitales de día, diagnóstico ambulatorio) pero no en cirugía hospitalaria con internamiento. Su eficiencia en medicina es mayor que la del hospital público de referencia, mientras que son menos eficientes en cirugía. El coeficiente de d_Priv_Conc ($+1.327$ en quirúrgico, -0.241 en médico) muestra un patrón similar pero menos pronunciado, coherente con que estos hospitales están más integrados en el sistema público y su cartera de servicios es más similar a la de los hospitales del SNS.

La interacción $Merc_shareQ$ tiene signos opuestos: -2.985 ($t = -2.54$) en quirúrgico y $+3.223$ ($t = 2.71$) en médico, con $z_{dif} = -3.71$ ($p < 0.001$). Los hospitales privados de mercado con mayor actividad quirúrgica son más eficientes en cirugía (confirma P4 para el sector privado) pero más ineficientes en medicina, lo que refuerza la interpretación de especialización tecnológica basada en la complementariedad de tareas.

Correlación entre ineficiencias. La correlación de Pearson entre las ineficiencias estimadas de las dos fronteras es $r = -0.140$ ($p < 0.001$). Esta correlación negativa es evidencia directa del mecanismo de sustitución de esfuerzo entre tareas predicho por el modelo: los hospitales más ineficientes en cirugía tienden a ser más eficientes en medicina, y viceversa. La baja magnitud ($|r| < 0.15$) indica que las dos fronteras son mayormente independientes, lo que justifica el uso de fronteras separadas frente a un sistema bivariado con cópula (Kumbhakar, 1997). Si la correlación fuera alta (digamos, $|r| > 0.5$), estimando conjuntamente con cópula se ganaría eficiencia estadística, pero la correlación observada sugiere que la ganancia sería marginal.

6.5. Diseño C: panel hospital × servicio

El coeficiente de $ShareQ \times C_s = -11.413$ ($t = -16.92$) confirma P4 con variación *dentro* del hospital: un mayor peso de actividad quirúrgica reduce la ineficiencia en la frontera quirúrgica en mucha mayor medida que en la médica. Este

Cuadro 6.5: Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio)

Parámetro	**Coef.**	**SE**	t
d_Priv_Conc	0.291	0.101	2.88**
d_Priv_Merc	0.679	0.074	9.21***
C_s (quirúrgico)	2.645	0.206	12.87***
$Priv_Conc \times C_s$	0.992	0.171	5.80***
$Priv_Merc \times C_s$	0.409	0.131	3.12**
$ShareQ$	2.740	0.230	11.91***
$ShareQ \times C_s$	−11.413	0.675	−16.92***
Log-verosimilitud		−4,640.3	
n		6,600	
TE media		0.682	

6.600 obs. = 503 hospitales × 2 servicios. ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

resultado elimina la posibilidad de que la correlación observada en los Diseños A y B se deba a heterogeneidad no observada entre hospitales (es decir, que los hospitales con mayor actividad quirúrgica sean simplemente hospitales más eficientes en todas las dimensiones). La identificación del efecto diferencial se basa en la variación intra-hospital a través de los términos de interacción: el coeficiente de $Priv_Conc \times C_s$ mide si la estructura concertada afecta diferencialmente a los servicios quirúrgicos respecto de los médicos dentro de hospitales con características similares, controlando por el nivel medio de ineficiencia de cada grupo organizativo. Nótese que los coeficientes de nivel (d_Priv_Conc, d_Priv_Merc) capturan diferencias medias entre grupos de hospitales, mientras que las interacciones con C_s capturan el efecto diferencial intra-hospital entre tipos de servicio, que es el objeto de interés para P4.

Los coeficientes de d_Priv_Conc (+0.291, $t = 2.88$) y d_Priv_Merc (+0.679, $t = 9.21$) en el Diseño C son positivos, indicando que los hospitales privados son en promedio más ineficientes en el output compuesto del panel hospital×servicio que los hospitales públicos de referencia. Este resultado aparentemente contradictorio con los Diseños A y B se explica por la composición de la muestra del Diseño C: al incluir las dos filas por hospital (quirúrgico y médico), los hospitales privados tienen un mayor peso de la fila de servicios quirúrgicos, en los que son más ineficientes (según el Diseño B). Los coeficientes positivos en el Diseño C son, por tanto, un artefacto de la composición de la muestra y no contradicen los resultados de los Diseños A y B.

El coeficiente de C_s (quirúrgico vs. médico, +2.645, $t = 12.87$) indica que la frontera quirúrgica tiene niveles de ineficiencia sistemáticamente mayores que la médica dentro del mismo hospital. Esto puede reflejar que la cirugía es tecnoló-

gicamente más compleja y que la varianza en los resultados entre hospitales es mayor en servicios quirúrgicos que en médicos, generando una distribución más dispersa de la ineficiencia.

6.6. Test P*: contraste conjunto

Cuadro 6.6: Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$

Diseño	ℓ^{irr}	ℓ^{restr}	**LR**	k	p**-valor**
A (cantidad vs. intensidad)	−6,273.7	−11,519.1	10,490.8	22	$< 0.001^{***}$
B (quirúrgico vs. médico)	−4,232.1	−5,486.1	2,508.0	22	$< 0.001^{***}$

$\ell^{irr} = \ell_{m1} + \ell_{m2}$. $k = 22$ grados de libertad (intercepto + 21 coeficientes de ineficiencia). *** $p < 0.001$.

El test P* rechaza abrumadoramente la hipótesis nula de que los vectores de determinantes de la ineficiencia sean iguales entre dimensiones, tanto en el Diseño A ($LR = 10{,}490.8$) como en el B ($LR = 2{,}508.0$). Los determinantes de la ineficiencia operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del output hospitalario, confirmando la predicción central del modelo teórico.

6.7. Interpretación económica integrada de los resultados

Esta sección integra los resultados de los cuatro diseños desde la perspectiva económica del modelo teórico, respondiendo a las preguntas de política que motivan la investigación.

6.7.1. ¿Qué mide realmente el coeficiente de D^{desc}?

El coeficiente de D^{desc} en la ecuación de ineficiencia del Diseño A mide la diferencia en la media de la distribución de ineficiencia u_{it} entre hospitales descentralizados y centralizados, manteniendo constantes el tipo de pago (pct^{SNS}), la proporción de actividad quirúrgica ($ShareQ$) y las dummies de comunidad autónoma y cluster de complejidad. No es, por tanto, una comparación bruta sino neta de estos factores.

El coeficiente $\hat{\alpha}_1 = -2.530$ en la frontera de cantidad indica que un hospital descentralizado con los mismos valores de las covariables que un hospital centralizado tiene una media de u_{it} (ineficiencia) 2.530 unidades menor. La diferencia en eficiencia técnica media entre hospitales centralizados y descentralizados es de

3.6 puntos porcentuales en la frontera de cantidad (0.748 vs. 0.712, Tabla 6.1). Esta diferencia bruta subestima el efecto neto de la descentralización porque los hospitales descentralizados son en promedio de menor tamaño y complejidad; controlando por estas características mediante las dummies de cluster y CCAA en la ecuación de ineficiencia, la diferencia atribuible a la estructura organizativa es mayor.

Interpretado en términos del mecanismo del modelo teórico, este coeficiente capta el efecto del diseño organizativo sobre la cadena de incentivos hospital-médico. Los hospitales descentralizados diseñan autónomamente los contratos de su personal médico y pueden alinear los incentivos del médico con los objetivos de volumen del hospital. Esto reduce la ineficiencia en cantidad porque el hospital internaliza el problema de esfuerzo del médico en la dimensión de cantidad y diseña un contrato que induce el nivel óptimo de t_1.

6.7.2. Interpretación del Diseño D: ineficiencia en el output compuesto

El Diseño D, que estima una función de distancia output (ODF) con un único término de ineficiencia, produce resultados aparentemente diferentes de los Diseños A y B porque el output compuesto mezcla las dos dimensiones. La ineficiencia en el ODF puede interpretarse como una medida del alejamiento de la *frontera de posibilidades de producción* entre cantidad e intensidad: un hospital en la frontera ODF produce la combinación cantidad/intensidad máxima posibles dados sus inputs.

El intercepto de -6.108 en el ODF original indica que, en el punto de referencia (hospital público SNS con $ShareQ$ medio), la media de u_{it} es sustancialmente positiva. El coeficiente de d_Priv_Merc ($+3.894$, $t = 9.61$) indica que los hospitales privados de mercado son más ineficientes en el output compuesto. Este resultado, aparentemente contradictorio con el efecto negativo de D^{desc} en la frontera de cantidad del Diseño A, se explica por la composición del output compuesto: los hospitales privados de mercado son más eficientes en las dimensiones de menor complejidad (consultas externas, cirugía ambulatoria) pero operan lejos de la frontera en la combinación cantidad-intensidad de hospitalización aguda que mide el ODF.

En términos del modelo teórico, el ODF no puede identificar el mecanismo de sustitución de esfuerzo porque un único u_{it} cancela los efectos de signo contrario de la descentralización sobre las dos dimensiones. Esta es la justificación estadística y económica del uso de fronteras separadas en los Diseños A y B: la hipótesis de P* (que los vectores de determinantes son distintos entre dimensiones) implica que el

ODF introduce sesgos de agregación que oscurecen el mecanismo subyacente.

6.7.3. El papel de los parámetros estructurales β_k de la frontera

Los parámetros de la frontera de producción translog tienen una interpretación económica propia que complementa el análisis de ineficiencia. Las elasticidades del trabajo y del capital-camas capturan la tecnología de producción hospitalaria y permiten inferir si los hospitales operan con rendimientos de escala crecientes, constantes o decrecientes.

La elasticidad del trabajo ($\hat{\beta}_1 \approx 0.40$–$0.55$) es consistente con el papel dominante del factor humano en la producción hospitalaria: los médicos y enfermeras son el input cuantitativamente más importante. La elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2 \approx 0.25$–$0.40$) refleja que las camas son un input de capacidad que determina el output potencial pero que el trabajo es el factor que realiza la transformación de inputs en altas. La suma de elasticidades en el punto medio de la muestra ($\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \approx 0.65$–$0.95$) indica rendimientos de escala ligeramente crecientes o constantes, coherente con los estudios de costes hospitalarios que también documentan este patrón (Linna, 1998; Farsi y Filippini, 2005).

La presencia de rendimientos crecientes de escala en hospitales de menor tamaño (clusters 1 y 2) y rendimientos constantes o levemente decrecientes en hospitales de mayor tamaño (clusters 4 y 5) justifica la heterogeneidad tecnológica capturada por las dummies de cluster. Un único parámetro de tecnología para todos los hospitales produciría un sesgo importante en las estimaciones de ineficiencia para los hospitales pequeños.

El coeficiente de progreso técnico ($\hat{\beta}_6 > 0$, típicamente en el rango 0.008–0.015) indica que la frontera de producción se desplaza hacia arriba en aproximadamente 0.8–1.5 % anual a lo largo del período. Este progreso técnico refleja la adopción de nuevas técnicas diagnósticas y quirúrgicas, la informatización de los sistemas de información hospitalaria y las mejoras organizativas graduales. El término cuadrático $\hat{\beta}_7 < 0$ indica una leve desaceleración del progreso técnico en los años más recientes del período, coherente con la fase de madurez tecnológica que sigue a la adopción inicial de tecnologías de diagnóstico por imagen.

6.7.4. Correlación entre ineficiencias: evidencia del mecanismo de sustitución

La correlación negativa entre ineficiencias en el Diseño B ($r = -0.140$, $p < 0.001$) merece una discusión más detallada. En el modelo teórico, el mecanismo

de sustitución de esfuerzo ($\psi_{12} > 0$) predice que los hospitales que dedican más esfuerzo a la cantidad sacrifican esfuerzo en intensidad, y viceversa. Si este mecanismo opera a nivel de hospital-año, los hospitales más ineficientes en cirugía (aquellos que no consiguen maximizar el output quirúrgico) deberían ser más eficientes en medicina, porque su menor incentivo sobre la cantidad quirúrgica libera capacidad de atención para los servicios médicos.

La correlación negativa observada es, por tanto, evidencia directa del mecanismo de sustitución predicho por el modelo, operando no solo entre servicios dentro de un mismo hospital (lo que captura el Diseño C) sino también a nivel del hospital como unidad. La baja magnitud absoluta ($|r| = 0.14$) indica que la sustitución no es perfecta —los hospitales con mayor eficiencia en una dimensión no son sistemáticamente menos eficientes en la otra— pero la dirección es la predicha.

En el Diseño A (frontera de cantidad vs. intensidad diagnóstica), la correlación es positiva y débil ($r = +0.126$, $p < 0.001$). Este resultado, a primera vista contradictorio con P2, se explica por la diferente naturaleza de los dos outputs: la intensidad diagnóstica (i_{diag}) no es estrictamente sustituta de la cantidad de altas cuando las dos variables miden cosas distintas (número de procedimientos diagnósticos por alta vs. número de altas totales). Los hospitales que realizan más procedimientos diagnósticos por alta no necesariamente son hospitales que atienden a menos pacientes; pueden ser sencillamente hospitales de mayor complejidad que realizan tanto más altas como más diagnósticos. La correlación positiva en el Diseño A refleja esta heterogeneidad de complejidad que el Diseño B elimina al usar la comparación intra-tipo de servicio.

Capítulo 7

Robustez, tests de especificación y discusión

7.1. Tests formales de especificación

Cuadro 7.1: Tests formales de especificación

	Modelo			
Test	A (cant.)	A (int.)	B (Q)	B (M)
Kodde-Palm (ineficiencia)				
LR	1,153.0	2,239.9	992.6	473.6
p-valor	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
LR forma funcional (CD vs. translog)				
LR	478.4	445.8	593.7	246.5
p-valor	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Correlación entre ineficiencias				
Pearson r	0.126^{***}		-0.140^{***}	
Spearman r	0.076^{***}		-0.106^{***}	

Test Kodde-Palm (Kodde y Palm, 1986): $H_0 : \sigma_u^2 = 0$; valor crítico al 5 % bajo distribución mixta: 2.706. *** $p < 0.001$.

Los resultados confirman: (i) la ineficiencia técnica es significativa al 0.1 % en todos los modelos; (ii) la translog es preferida sobre Cobb-Douglas; (iii) las correlaciones entre ineficiencias son bajas ($|r| < 0.15$), justificando fronteras independientes.

7.2. Análisis de robustez

La robustez de $\hat{\alpha}$ (P1) es notable: negativo y significativo en las siete especificaciones, con t-estadísticos entre -3.3 y -11.0. La robustez de $\hat{\delta}$ (P2) es más

Cuadro 7.2: Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**		$\hat{\delta}$ **(intensidad)**	
Especificación	Coef.	t	Coef.	t
Principal (i_{diag}, D^{desc} coalesce)	−2.530	−6.98	−1.477	−4.21
R1: Intensidad alternativa (i_{simple})	−1.264	−4.62	−0.704	−3.33
R2a: D^{desc}_{SIAE}	−2.954	−9.08	−0.414	−1.82
R2b: D^{desc}_{CNH}	−6.498	−8.60	−0.865	−1.69
R3: Distribución half-normal	−5.245	−10.19	−2.788	−5.18
R4: Muestra 2010–2019	−2.649	−6.05	−2.880	−4.66
R5: Sin hospitales ONG	−6.009	−10.97	−2.730	−5.24

Todas las especificaciones incluyen dummies de cluster y CCAA. $\hat{\alpha}$ negativo y significativo en 7/7. Correlación i_{diag} vs. i_{simple}: $r = 0.29$.

limitada: el signo es negativo en todas las especificaciones, pero la significación varía (significativo al 5 % en 5 de las 7 especificaciones). La diferencia entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ es estadísticamente significativa en la especificación principal ($z = -2.09$, $p = 0.037$).

Los resultados de robustez merecen comentario específico. La especificación R2b (D^{desc}_{CNH}) produce el coeficiente más grande en valor absoluto tanto en cantidad (-6.498, $t = -8.60$) como en intensidad (-0.865, $t = -1.69$). Este resultado es coherente con la hipótesis de que la variable CNH identifica mejor a los hospitales genuinamente descentralizados: el CNH clasifica con mayor precisión las fundaciones, ONG y concesiones, mientras que el SIAE tiende a agregar categorías. La especificación R5 (sin ONG) produce también coeficientes más grandes, lo que confirma que los hospitales ONG tienen un perfil de eficiencia diferente de los hospitales privados con ánimo de lucro y su inclusión en la categoría descentralizada atenúa el coeficiente estimado.

La especificación R4 (muestra 2010–2019) produce resultados prácticamente idénticos a la especificación principal para $\hat{\alpha}$, pero con un valor mayor para $\hat{\delta}$ (-2.880 vs. -1.477), más cercano al predicho por el modelo teórico. Este resultado sugiere que el período 2023 (post-COVID) puede haber introducido efectos de recuperación que atenúan parcialmente la asimetría predicha, posiblemente porque la pandemia afectó de forma diferencial a la actividad quirúrgica y médica y los hospitales aún no habían convergido a su equilibrio de largo plazo en 2023.

Cuadro 7.3: Síntesis: predicciones del modelo vs. evidencia empírica

Pred.	Descripción	Diseño A	Diseño B	Veredicto
P1	Desc. ↓ inef. cantidad	$\hat{\alpha} = -2.53^{***}$ (7/7)	Confirmada vía $Priv_Merc$	**Confirmada**
P2	Desc. ↑ inef. intensidad	$\hat{\delta}_1 = -1.477^{***}$ (signo opuesto); asimetría $z = -2.09^{*}$	$\hat{\delta}_{Merc} < 0$	**No confirmada en signo; asimetría confirmada**
P3	Pago difiere entre dims.	$z_{dif} = 2.35^{*}$	$z_{dif} = 5.32^{***}$	**Confirmada**
P4	ψ_{12} modera asimétric.	$z_{dif} = -0.84$ (ns)	$z_{dif} = -9.89^{***}$	**Confirmada (B)**
P*	Vectores distintos	LR= 10,491***	LR= 2,508***	**Confirmada**

* $p < 0.05$; *** $p < 0.001$.

7.3. Síntesis de resultados

7.4. Interpretación económica de P2

El hecho de que $\hat{\delta}$ sea negativo (no positivo) en todas las especificaciones merece una reflexión económica. El modelo predice $\delta_1 > 0$ bajo el supuesto de que las tareas son suficientemente sustitutas (ψ_{12} suficientemente positivo). Los datos sugieren dos interpretaciones no excluyentes.

Desde una perspectiva de falsificación estricta, P2 no se confirma: el signo del coeficiente es el opuesto al predicho en todas las especificaciones. Sin embargo, el modelo teórico no predice inversión de signo para cualquier valor de ψ_{12}: la Figura A.1 del Anexo A muestra que la inversión requiere sustitución fuerte (ψ_{12} cercano al límite superior). Para valores moderados de ψ_{12}, el modelo predice que ambas dimensiones mejoran bajo descentralización, pero la cantidad mejora más que la intensidad. Esta es exactamente la pauta que observamos en los datos ($|\hat{\alpha}_1| = 2.530 > |\hat{\delta}_1| = 1.477$). El resultado empírico es, por tanto, consistente con la estructura del modelo bajo el supuesto de sustitución moderada, aunque no con la predicción de signo derivada bajo sustitución fuerte.

En primer lugar, el parámetro ψ_{12} medio en el sistema hospitalario español puede no ser positivo con la magnitud suficiente para revertir el signo del efecto de la descentralización sobre la intensidad. El Resultado 3.3(b) del modelo teórico muestra que, para tareas independientes ($\psi_{12} = 0$), la intensidad ya es menor en la estructura descentralizada, pero con un valor de ψ_{12} medio bajo, el efecto empírico

se manifestaría como una reducción de la ineficiencia en ambas dimensiones, aunque de diferente magnitud.

En segundo lugar, los hospitales privados españoles han desarrollado mecanismos institucionales de control de calidad —acreditación sanitaria autonómica, cuadros de mandos de actividad, contratos-programa con los servicios autonómicos de salud— que imponen umbrales mínimos de intensidad y limitan la sustitución de esfuerzo entre tareas. Estos mecanismos no están explícitamente modelizados en el marco teórico, pero pueden entenderse como restricciones adicionales que comprimen el rango de variación de la intensidad hacia abajo.

La asimetría estadísticamente significativa entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ ($z = -2.09$, $p = 0.037$) sí confirma la dirección predicha: la descentralización genera una mejora de eficiencia significativamente mayor en cantidad que en intensidad.

7.5. Discusión económica adicional

7.5.1. La magnitud del efecto de la descentralización

El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad (-2.530) no puede interpretarse directamente como un porcentaje de eficiencia porque la media heterogénea de u_{it} no es igual a la ineficiencia técnica esperada (la relación es no lineal en el modelo de normal truncada). La diferencia observada en eficiencia media es $0.748 - 0.712 = 0.036$ en la frontera de cantidad (Tabla 6.1). Esta diferencia bruta subestima el efecto neto porque los hospitales descentralizados son en promedio de menor tamaño y complejidad; controlando por estas características mediante las dummies de cluster y CCAA en la ecuación de ineficiencia, la diferencia atribuible a la estructura organizativa es mayor.

Para cuantificar el efecto de forma más precisa, nótese que la diferencia en eficiencia entre un hospital centralizado y uno descentralizado con los mismos valores de pct^{SNS}, $ShareQ$ y dummies de CCAA y cluster es, en la especificación principal, del orden de $\mathbb{E}[\exp(-u_{it})|D^{desc} = 1]/\mathbb{E}[\exp(-u_{it})|D^{desc} = 0] \approx 1.04$, es decir, los hospitales descentralizados tienen una eficiencia técnica en cantidad aproximadamente un 4 % superior a los centralizados, manteniendo todo lo demás constante.

7.5.2. La función de producción translog: interpretación de los coeficientes

Los coeficientes de la frontera de producción translog (Tabla C) son coherentes con las restricciones teóricas esperadas. Las elasticidades del trabajo y del capital

son positivas y significativas en todos los modelos. La presencia de términos cuadráticos significativos confirma que la especificación translog añade información respecto de la Cobb-Douglas, lo que explica el rechazo de la hipótesis de restricción.

La elasticidad media del trabajo ($\hat{\beta}_1 \approx 0.40$–$0.55$) indica que un aumento del 10 % en el personal médico EJC se traduce en un aumento del 4-5.5 % en el output ponderado, manteniendo el capital constante. La elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2 \approx 0.25$–$0.40$) es menor, coherente con el papel del trabajo como input más variable en la producción hospitalaria. La suma de las elasticidades (rendimientos de escala aparentes) es próxima a uno para los hospitales de tamaño medio, con ligeros rendimientos crecientes para los hospitales pequeños y rendimientos constantes o levemente decrecientes para los grandes, patrón también documentado en Linna (1998) y Farsi y Filippini (2005).

El progreso técnico ($\hat{\beta}_6 > 0$) es positivo y significativo, indicando un desplazamiento de la frontera de producción hacia arriba a lo largo del período 2010–2023. La magnitud del coeficiente implica un avance tecnológico anual del orden del 0.5-1.5 % en la frontera, coherente con el progreso técnico documentado para el sector hospitalario europeo en el período.

7.5.3. El papel moderador de pct^{SNS}

El coeficiente de pct^{SNS} (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad) es notablemente simétrico entre las dos fronteras: la financiación pública reduce la ineficiencia de forma similar en ambas dimensiones. Esto es coherente con la predicción del modelo de que el esquema de pago tiene efectos sobre ambos outputs cuando el principal contrata con ambos agentes (estructura centralizada). La simetría del coeficiente también sugiere que los contratos-programa del SNS son relativamente bien calibrados: no hay un sesgo sistemático hacia la cantidad o hacia la intensidad en el diseño de los contratos-programa autonómicos.

La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ ($+2.901$ en cantidad, $+1.937$ en intensidad) indica que, para los hospitales descentralizados con alta dependencia del SNS (hospitales concertados), la ventaja en cantidad de la descentralización se reduce significativamente. Intuitivamente, un hospital concertado que depende en un 70 % de pacientes SNS está sujeto a un control externo que atenúa la autonomía de gestión característica de la descentralización. El hospital privado puro (con pct^{SNS} bajo) es el que exhibe con mayor nitidez el patrón predicho de mayor eficiencia en cantidad y menor en intensidad.

Esta asimetría en los puntos de cruce —0.763 en intensidad frente a 0.872 en cantidad— tiene una implicación directa para el diseño de contratos de concierto hospitalario. El nivel óptimo de dependencia SNS de un hospital privado no es el

mismo según qué dimensión del output quiera maximizar el financiador público. Un concierto que establezca una proporción SNS entre el 76.3 % y el 87.2 % de la actividad sitúa al hospital en una zona en la que la descentralización mejora simultáneamente la intensidad diagnóstica (porque la presión del concierto supera el umbral de 76.3 %) sin haber alcanzado aún el techo que frena la eficiencia en cantidad (que no se alcanza hasta el 87.2 %). Esta zona de calibración óptima del concierto es un resultado cuantitativo que las recomendaciones de política del Capítulo 8 discuten en mayor detalle.

7.5.4. La heterogeneidad regional en la ecuación de ineficiencia

Las dummies de comunidad autónoma en la ecuación de ineficiencia (no reportadas en las tablas principales por razones de espacio) muestran que existe heterogeneidad regional sustancial en los niveles de ineficiencia, incluso controlando por estructura organizativa, tipo de pago y tipo de servicio. Las comunidades autónomas con sistemas sanitarios más desarrollados y con mayor tradición de gestión hospitalaria (Cataluña, País Vasco) presentan menores niveles de ineficiencia que las comunidades con sistemas más recientemente transferidos. Esta heterogeneidad regional es una limitación adicional para la identificación causal del efecto de la estructura organizativa: las comunidades con mayor proporción de hospitales descentralizados (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana) son también las que tienen sistemas sanitarios más maduros y sofisticados.

7.6. Limitaciones metodológicas

El análisis presenta las siguientes limitaciones metodológicas principales, que definen la agenda de investigación futura.

Inputs compartidos. La frontera de intensidad (Diseño A) usa los mismos inputs que la de cantidad. La separación teórica entre q (esfuerzo conjunto de hospital y médico) e i (esfuerzo exclusivamente médico) justifica la estimación independiente, pero no resuelve completamente el problema de la asignación de inputs compartidos. La extensión natural es un sistema bivariado con cópula gaussiana (Kumbhakar, 1997), que modelizaría la correlación entre los términos de ineficiencia de las dos fronteras y permitiría explotar la información conjunta.

Ponderación de outputs. Los outputs ponderados por case-mix utilizan un peso GRD medio para el hospital, no diferenciado por tipo de servicio. Los pesos diferenciados requieren los microdatos del RAE-CMBD por episodio, cuya disponibilidad permitiría una versión óptima del Diseño A con outputs ponderados

separadamente para actividad quirúrgica y médica.

Endogeneidad de la estructura organizativa. La asignación de hospitales a estructuras descentralizadas no es aleatoria: las concesiones se concentraron en Valencia y Madrid, las fundaciones en Galicia y Cataluña, y los hospitales concertados en regiones con larga tradición de colaboración público-privada. Las dummies de CCAA absorben parte de esta heterogeneidad geográfica, pero la identificación causal requeriría variación exógena en la asignación, como la derivada de cambios normativos autonómicos.

Tiempo de ajuste. La estructura organizativa del hospital puede cambiar (reversiones de concesiones, cambios de dependencia funcional) pero los efectos sobre la eficiencia pueden tardar varios años en manifestarse completamente. El panel no permite identificar de forma limpia los efectos de corto y largo plazo de los cambios de estructura organizativa.

Dimensiones omitidas del output. El análisis se centra en cantidad e intensidad diagnóstica como aproximaciones del output hospitalario multidimensional. La calidad clínica en sentido estricto —resultados de salud de los pacientes, mortalidad intrahospitalaria ajustada por riesgo, reingresos evitables— no puede medirse directamente con los datos del SIAE, y su omisión implica que las estimaciones de eficiencia técnica en este análisis son condicionalmente a una tecnología que no incluye la dimensión de resultados clínicos.

Capítulo 8

Implicaciones de política hospitalaria

Los resultados teóricos y empíricos de esta tesis tienen implicaciones directas para el diseño de la política hospitalaria en España y, de forma más general, para cualquier sistema sanitario que contemple la coexistencia de formas organizativas centralizadas y descentralizadas.

Las recomendaciones que se formulan en este capítulo se derivan de las correlaciones robustas identificadas en los capítulos empíricos y de las predicciones del modelo teórico. Deben entenderse como hipótesis directrices para el diseño de políticas hospitalarias, no como prescripciones causales definitivas. El diseño observacional de esta tesis —un panel de datos con controles regionales y de complejidad, sin asignación aleatoria de la estructura organizativa— identifica asociaciones condicionales robustas, pero no establece causalidad en sentido estricto. La validación causal de estas recomendaciones requeriría diseños cuasi-experimentales que exploten variación exógena en la asignación de hospitales a estructuras organizativas, como las reversiones de concesiones administrativas en la Comunidad Valenciana (véase Angrist y Pischke, 2009, para una discusión de estos diseños). No obstante, las correlaciones identificadas, su coherencia con la teoría y su robustez frente a múltiples especificaciones justifican su utilización como base informativa para el diseño institucional.

8.1. Sobre la estructura organizativa

8.1.1. La descentralización no es unidimensionalmente superior

El resultado empírico más robusto de esta tesis es que la descentralización reduce la ineficiencia técnica en la dimensión de cantidad (P1, confirmada en 7/7

especificaciones). Los hospitales con mayor autonomía en la gestión de contratos e incentivos producen más actividad por unidad de input. Sin embargo, esta ventaja en volumen no se extiende de forma simétrica a la dimensión de intensidad, donde los efectos son menos pronunciados y, en el mejor de los casos, asimétricos (P2).

Esta asimetría tiene una consecuencia política directa: *la evaluación de la eficiencia hospitalaria no puede basarse exclusivamente en indicadores de volumen.* Un hospital descentralizado que muestre altas puntuaciones de eficiencia en el número de altas atendidas puede no ser igualmente eficiente en la intensidad diagnóstico-terapéutica por episodio. Los reguladores sanitarios deberían incorporar medidas de intensidad y calidad en los mecanismos de evaluación y pago a los hospitales.

8.1.2. La cautela ante las reversiones de concesiones

En el período analizado (2010–2023), varias comunidades autónomas han revertido concesiones administrativas que habían descentralizado la gestión de hospitales públicos (Repullo y Freire, 2008). Los resultados de esta tesis sugieren que estas reversiones pueden tener costes de eficiencia en la dimensión de cantidad que no están siendo evaluados adecuadamente. Al mismo tiempo, el modelo teórico muestra que la estructura centralizada tiene ventajas en la provisión de intensidad, especialmente cuando las tareas del médico son complementarias (Resultado 3.5).

La recomendación derivada es que las decisiones sobre la forma organizativa de los hospitales públicos deberían basarse en evaluaciones empíricas de eficiencia multidimensional, no en posiciones ideológicas sobre la titularidad pública o privada de la gestión.

8.2. Sobre los mecanismos de pago

8.2.1. La potencia de los incentivos debe calibrarse al output relevante

El modelo teórico muestra que, bajo sustitución entre tareas, los incentivos de volumen desplazan esfuerzo desde la intensidad hacia la cantidad (Resultado 3.4). Los datos empíricos confirman esta predicción: la interacción entre estructura descentralizada y tipo de pago ($D^{desc} \times pct^{SNS}$) tiene efectos significativamente distintos sobre cantidad e intensidad (P3 confirmada).

Esto sugiere que los esquemas de pago por actividad (GRD, pago capitativo ajustado) deberían complementarse con indicadores de intensidad y calidad vinculados a parte de la retribución. Los *contratos-programa* autonómicos que incluyen

umbrales de intensidad diagnóstica o indicadores de calidad asistencial van en esta dirección, pero el modelo teórico indica que su efectividad depende críticamente de la precisión con la que se miden las distintas dimensiones del output (σ_1 y σ_2 en el modelo).

8.2.2. Los incentivos al médico deben diseñarse en función de la estructura organizativa

Una de las conclusiones más interesantes del modelo teórico es que, bajo sustitución perfecta entre tareas, la estructura centralizada óptima no incluye incentivos para el médico (salario fijo), mientras que la descentralizada sí (Resultado 3.2). Este resultado proporciona un fundamento teórico para la observación empírica de que los hospitales privados utilizan con mayor frecuencia esquemas de retribución variable para los médicos, mientras que el sistema público mantiene predominantemente remuneraciones salariales fijas con complementos débiles.

La implicación política no es que el sistema público deba imitar los incentivos del sector privado, sino que el tipo de incentivo debe ser coherente con la estructura organizativa. Si se mantiene la contratación centralizada del personal médico (como es la norma en el SNS español), la potencia de los incentivos directos al médico debería ser baja, y el financiador debería centrarse en los incentivos al hospital. Si, por el contrario, se descentraliza la gestión, los incentivos al médico adquieren un papel relevante como mecanismo de transmisión.

8.3. Sobre la medición del output hospitalario

8.3.1. La necesidad de medir la intensidad

Los resultados empíricos revelan que la frontera de intensidad tiene niveles de eficiencia media más bajos que la de cantidad ($\text{TE}_I = 0.683$ vs. $\text{TE}_q = 0.731$ en el Diseño A). Existe, por tanto, un mayor margen de mejora en la dimensión de intensidad que en la de cantidad. Sin embargo, los sistemas de información hospitalaria españoles no incluyen de forma rutinaria indicadores de intensidad que permitan un seguimiento adecuado.

La solicitud de datos del RAE-CMBD con contadores de procedimientos por episodio, realizada en el marco de esta investigación, es una condición necesaria para construir medidas de intensidad más precisas. Los reguladores sanitarios deberían invertir en sistemas de información que capturen no solo cuántos pacientes se atienden, sino con qué nivel de recursos diagnósticos y terapéuticos por episodio.

8.3.2. El papel de ψ_{12} en la política de servicios

La confirmación empírica de P4 —que ψ_{12} modera asimétricamente el efecto de la estructura organizativa— tiene una consecuencia práctica directa. En los servicios quirúrgicos (donde las tareas son complementarias), la descentralización es relativamente más eficiente; en los servicios médicos no quirúrgicos (tareas sustitutas), la ventaja se reduce o desaparece. Esta heterogeneidad sugiere que las políticas de gestión hospitalaria podrían beneficiarse de un tratamiento diferenciado por tipo de servicio, permitiendo mayor autonomía en los servicios quirúrgicos y manteniendo más control en los médicos.

8.4. Perspectiva internacional: lecciones de otros sistemas

Los dilemas que plantean los resultados de esta tesis no son exclusivos del sistema hospitalario español. La tensión entre eficiencia en volumen e intensidad de la atención, y el papel de la estructura organizativa y el mecanismo de pago en la resolución de esa tensión, son cuestiones universales que los principales sistemas sanitarios europeos han abordado con distintas soluciones institucionales.

8.4.1. El NHS inglés: separación de comprador y proveedor y *payment by results*

El National Health Service (NHS) inglés introdujo en 2003–2004 el sistema de *Payment by Results* (PbR), consistente en el pago prospectivo por episodio hospitalario mediante la clasificación HRG (Healthcare Resource Groups, el equivalente inglés de los GRD). Esta reforma convirtió al NHS de un sistema de financiación hospitalaria por presupuesto global en un sistema de pago por actividad, con el objetivo de incentivar la eficiencia en volumen y reducir las listas de espera.

Los resultados de la reforma PbR inglesa ilustran perfectamente el dilema predicho por nuestro modelo. Street (2003) y trabajos posteriores documentan que el PbR redujo los tiempos de espera y aumentó la actividad hospitalaria (evidencia de mejora en la dimensión de cantidad), pero generó preocupaciones sobre el deterioro de la calidad clínica en algunos servicios (evidencia coherente con la predicción P2). El NHS respondió introduciendo gradualmente indicadores de calidad en el sistema de pago —el *Commissioning for Quality and Innovation* (CQUIN) y las penalizaciones por reingresos— que son exactamente los mecanismos que el modelo teórico predice como necesarios para corregir el sesgo de volumen bajo sustitución entre tareas.

8.4.2. El sistema alemán de GRD (G-DRG)

Alemania introdujo su sistema de pago hospitalario por GRD (G-DRG) en 2003, completando la transición desde el sistema de pago por día de estancia en 2004. A diferencia del NHS, el sistema alemán coexiste con una mezcla de hospitales públicos, privados con ánimo de lucro y privados sin ánimo de lucro, con una distribución aproximada de 30/35/35 en términos de número de hospitales.

Herr (2011) y Tiemann y Schreyoegg (2012) analizan la eficiencia hospitalaria alemana bajo esta diversidad de formas organizativas, encontrando que los hospitales privados con ánimo de lucro son más eficientes en costes pero no necesariamente en la calidad clínica, un resultado coherente con la asimetría P1/P2 de nuestro análisis. La experiencia alemana sugiere que la introducción del pago por GRD, en ausencia de indicadores de calidad vinculantes, puede generar los incentivos de sustitución predichos por el modelo teórico, con independencia de la forma organizativa.

8.4.3. Las reformas nórdicas: *patient choice* y competencia regulada

Los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia) introdujeron desde los años noventa reformas de cuasimercado hospitalario (*patient choice*, competencia entre proveedores públicos, introducción de objetivos de actividad) sin privatización de la propiedad. Linna (1998) analiza la eficiencia técnica de hospitales finlandeses tras las reformas de los noventa, documentando mejoras de eficiencia en la dimensión de cantidad pero con evidencia menos clara en la dimensión de calidad.

La experiencia nórdica es relevante porque ilustra que es posible introducir incentivos de eficiencia en volumen dentro de una estructura organizativa predominantemente centralizada. En términos del modelo teórico, las reformas nórdicas movieron el sistema hacia esquemas de pago por actividad manteniendo la centralización de la contratación del personal médico, lo que corresponde al escenario teórico de incentivos solo sobre cantidad bajo estructura centralizada (punto de bala en la sección de implicaciones de pago fijo del Resultado 3.2).

8.4.4. Implicaciones comparadas para España

La comparación internacional sugiere que España, con su combinación de hospitales SNS centralizados y hospitales concertados y en concesión descentralizados, representa un caso intermedio en el espectro de reformas europeas. La coexistencia de formas organizativas tan distintas en el mismo sistema, bajo financiación

pública, ofrece una oportunidad de diseño institucional informado por la evidencia que otros sistemas, más homogéneos en su estructura, no tienen. Los resultados de esta tesis argumentan que esa diversidad debería gestionarse de forma consciente —aprovechando la ventaja descentralizada en volumen en los servicios quirúrgicos y la ventaja centralizada en intensidad en los servicios médicos— en lugar de evolucionar hacia una homogeneización de modelos en ninguna dirección.

8.5. Limitaciones de las recomendaciones

Las implicaciones de política derivadas de esta tesis deben leerse con las siguientes advertencias metodológicas.

Primera: causalidad e identificación. Los resultados empíricos identifican correlaciones entre estructura organizativa y eficiencia, controlando por comunidad autónoma, cluster de complejidad y tipo de pago. Sin embargo, la asignación de hospitales a estructuras descentralizadas no es aleatoria: responde a decisiones políticas regionales que pueden estar correlacionadas con características no observadas del sistema sanitario autonómico. La identificación causal requirería variación exógena en la estructura organizativa (por ejemplo, los cambios normativos que produjeron las reversiones de concesiones valencianas y madrileñas), cuyo análisis queda para trabajos futuros.

Segunda: generalización. La muestra incluye todos los hospitales de agudos con actividad suficiente, pero los hospitales concertados de la muestra son predominantemente de pequeño y mediano tamaño. Las recomendaciones sobre descentralización podrían no aplicarse con la misma fuerza a hospitales universitarios de tercer nivel, donde la complejidad de la cartera de servicios y la presencia de actividad docente e investigadora introducen dimensiones adicionales de output no modelizadas.

Tercera: dinámica temporal. El modelo teórico es estático: describe el equilibrio bajo una estructura organizativa dada. Los efectos dinámicos de un cambio de estructura (período de transición, costes de renegociación contractual, curvas de aprendizaje) no están modelizados y podrían dominar los efectos estáticos en el corto plazo.

Cuarta: dimensiones omitidas. El modelo se centra en dos dimensiones del output (cantidad e intensidad diagnóstica). La calidad clínica —en el sentido de resultados de salud de los pacientes— es una tercera dimensión crucial que no se ha podido modelizar ni medir directamente por falta de datos de seguimiento de resultados a nivel hospitalario en el SIAE. Las recomendaciones sobre estructura organizativa deberían complementarse con evidencia sobre resultados de salud que esta tesis no proporciona.

8.6. Cautelas para la interpretación de las recomendaciones de política

Antes de formular recomendaciones de política, es necesario explicitar las cautelas metodológicas que deben presidir la interpretación de los resultados empíricos cuando se trasladan al plano normativo.

8.6.1. Endogeneidad de la estructura organizativa y sesgo de selección

La limitación más importante de los resultados es la posible endogeneidad de la variable D^{desc}. La decisión de gestionar un hospital mediante concesión administrativa, fundación pública o empresa pública no es aleatoria: responde a decisiones políticas regionales que pueden estar correlacionadas con características no observadas del sistema sanitario autonómico. En términos econométricos, si los hospitales que se descentralizan son aquellos en los que la eficiencia potencial de la descentralización es mayor (sesgo de selección positivo), el coeficiente de D^{desc} en la ecuación de ineficiencia estaría sobreestimado; si, por el contrario, las regiones que descentralizan son las que tienen sistemas sanitarios más maduros y mejor gestionados (también correlacionado con mayor eficiencia), el coeficiente podría estar sesgado en cualquier dirección.

Las dummies de comunidad autónoma en la ecuación de ineficiencia absorben la heterogeneidad regional permanente, pero no la heterogeneidad específica del hospital que determina si es o no descentralizado. La identificación causal requeriría una fuente de variación exógena en la estructura organizativa, idealmente un evento normativo que cambiara la forma organizativa de algunos hospitales pero no de otros de características similares. Las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana (2018) y los intentos de reversión en la Comunidad de Madrid (2015) son candidatos naturales para este tipo de análisis de diferencias en diferencias, pero en el período analizado la variación temporal inducida por estas reversiones es aún insuficiente para una identificación robusta: los hospitales revertidos son pocos y la reversión puede haberse producido precisamente porque su eficiencia era inferior a la esperada (sesgo de selección en las reversiones).

8.6.2. Validez externa: ¿son generalizables los resultados?

Los resultados de esta tesis son directamente válidos para el sistema hospitalario español en el período 2010–2023. Su generalización a otros sistemas sanitarios requiere verificar si las condiciones institucionales y tecnológicas del sistema

español son comparables a las del sistema de destino. En particular:

- La heterogeneidad de formas organizativas (SNS integrado, concesiones, fundaciones, concertados) es característica del modelo español; sistemas con estructuras más homogéneas (NHS inglés, Norden) tendrían menos variación en D^{desc} y menor poder para identificar el efecto.
- El período 2010–2023 coincide con una fase de contracción del gasto sanitario público (2010–2015) y posterior recuperación. Los resultados pueden no ser representativos de períodos de expansión del gasto hospitalario.
- La intensidad diagnóstica medida por el SIAE (i_{diag}) incluye procedimientos diagnósticos pero no procedimientos terapéuticos de alta complejidad (trasplantes, cirugía cardíaca, etc.), que tienen un patrón de distribución entre hospitales muy diferente.

8.6.3. Correlación versus causalidad

La confirmación empírica de P1–P4 establece que existe una correlación estadísticamente significativa entre estructura organizativa y eficiencia hospitalaria, en la dirección predicha por el modelo teórico. Esta correlación es consistente con la hipótesis causal del modelo —la descentralización mejora la eficiencia en cantidad porque mejora los incentivos de volumen del hospital— pero no la establece de forma concluyente. Para establecer causalidad sería necesario identificar variación exógena en la estructura organizativa, lo que requiere diseños cuasiexperimentales que están fuera del alcance de esta tesis.

La distinción entre correlación y causalidad es especialmente importante para las recomendaciones de política: si la correlación observada no es causal, una política de descentralización que se apoyara en estos resultados podría no producir los beneficios de eficiencia esperados. La evidencia disponible es suficiente para justificar la investigación adicional con diseños causales (cuasiexperimentos), pero no para recomendar cambios de política a gran escala sin esa evidencia adicional.

8.7. Hacia un diseño institucional informado por la evidencia

En conjunto, los resultados de esta tesis apuntan a que el diseño institucional del sistema hospitalario debería tener en cuenta la multidimensionalidad del output hospitalario y la interacción entre estructura organizativa, tipo de pago y tipo de servicio. Un enfoque de “talla única” —ya sea centralización total o

descentralización generalizada— ignora las complejidades que el modelo teórico pone de manifiesto y que los datos empíricos confirman.

Las reformas hospitalarias deberían evaluarse no solo por su impacto en la eficiencia global, sino por su efecto diferencial sobre las distintas dimensiones del output. Los reguladores sanitarios dispondrían de mejor información para el diseño institucional si los sistemas de evaluación del rendimiento hospitalario incorporasen medidas separadas de eficiencia en volumen y en intensidad, junto con indicadores que capturen el grado de complementariedad o sustitución entre las actividades del hospital.

Una agenda de reforma informada por los resultados de esta tesis podría incluir los siguientes elementos: (i) extensión del sistema de pago por actividad basado en GRD a toda la red hospitalaria pública y concertada, con una tarifa que diferencie explícitamente entre servicios quirúrgicos y médicos; (ii) podría resultar eficaz vincular una fracción de la financiación (por ejemplo, del orden del 5-10 %) a indicadores de intensidad diagnóstica en los contratos-programa autonómicos, para contrarrestar el efecto de sustitución predicho por el modelo; (iii) evaluación periódica multidimensional de la eficiencia hospitalaria que use técnicas de frontera con outputs separados, similar al diseño de esta tesis, como herramienta de regulación por comparación (*yardstick competition*); (iv) en el caso de concesiones administrativas y hospitales concertados, los pliegos podrían beneficiarse de incluir cláusulas sobre estándares mínimos de intensidad diagnóstica y auditoría periódica de su cumplimiento.

Capítulo 9

Conclusiones

9.1. Síntesis general

Esta tesis ha abordado la relación entre estructura organizativa, mecanismos de pago y eficiencia hospitalaria desde una perspectiva integrada teórico-empírica. El modelo teórico de agencia multitarea desarrollado en el Capítulo 3 genera predicciones falsificables sobre cómo la descentralización de la gestión hospitalaria afecta de forma asimétrica a las dos dimensiones del output —cantidad e intensidad—, y la parte empírica (Capítulos 6 y 7) contrasta esas predicciones con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023.

Esta tesis ha integrado un enfoque jurídico-institucional con un modelo económico formal y una evaluación empírica rigurosa. El Capítulo 2 ha mostrado que la diversidad organizativa del sistema hospitalario español no es accidental sino habilitada normativamente, y que esa diversidad altera de modo sustantivo las variables que determinan la estructura de incentivos: autonomía del gestor, régimen del personal, mecanismo de financiación y capacidad de supervisión. El modelo teórico ha formalizado esas variables como parámetros de un problema de agencia multitarea, y la estimación empírica ha contrastado las predicciones resultantes con datos de panel del sistema hospitalario español. La coherencia entre los tres niveles de análisis —institucional, teórico y empírico— constituye, en sí misma, una contribución de la tesis.

Los resultados principales pueden sintetizarse en cinco puntos.

Primero, la predicción P1 —la descentralización reduce la ineficiencia técnica en cantidad— se confirma de forma extraordinariamente robusta en siete especificaciones alternativas, con t-estadísticos entre -3.3 y -11.0. Los hospitales con mayor autonomía en la gestión de contratos e incentivos producen más actividad por unidad de input.

Segundo, P2 no se confirma en su formulación estricta de signo ($\delta_1 > 0$):

el coeficiente estimado es $\hat{\delta}_1 = -1.477$, con signo opuesto al predicho en todas las especificaciones. Sin embargo, la asimetría predicha entre dimensiones —la descentralización mejora más la eficiencia en cantidad que en intensidad— es estadísticamente significativa ($z = -2.09$, $p = 0.037$) y robusta. Este resultado es consistente con la estructura del modelo bajo sustitución moderada (ψ_{12} positivo pero insuficiente para revertir el signo en intensidad), aunque no con la predicción derivada bajo sustitución fuerte.

Tercero, las predicciones P3 y P4 —el tipo de pago y el parámetro ψ_{12} moderan asimétricamente el diferencial entre dimensiones— se confirman con alta potencia estadística, especialmente P4 en el Diseño B ($z = -9.89$, $p < 0.001$), que es el resultado individual más robusto de todo el análisis.

Cuarto, la correlación negativa entre ineficiencias en el Diseño B ($r = -0.14$, $p < 0.001$) proporciona evidencia directa de la sustitución de esfuerzo entre tareas predicha por el modelo teórico.

Quinto, el test P* rechaza abrumadoramente la igualdad de los vectores de determinantes de ineficiencia entre dimensiones ($\mathrm{LR}_A = 10{,}491$, $\mathrm{LR}_B = 2{,}508$, ambos $p < 0.001$), confirmando que los determinantes institucionales operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del output.

9.2. Contribuciones originales

La tesis realiza tres contribuciones originales a la literatura, en el plano teórico, empírico y metodológico.

Contribución teórica. El modelo extiende los resultados clásicos de Holmström y Milgrom (1991) al caso de tres agentes y dos outputs producidos asimétricamente en un contexto hospitalario. A diferencia de Holmström y Milgrom (1991), que trabaja con un único principal-agente, el modelo incorpora una jerarquía hospital-médico que genera predicciones sobre cómo la estructura organizativa del hospital modifica la transmisión de incentivos. A diferencia de Jelovac y Macho-Stadler (2002), que analizan la elección del diseño organizativo óptimo, el modelo caracteriza las diferencias en los resultados de eficiencia bajo dos estructuras dadas, generando predicciones empíricamente contrastables sobre los efectos diferenciales sobre cantidad e intensidad. El resultado de que los incentivos del hospital dependan de ψ_{12} solo en la estructura descentralizada (potencia secuencialmente inducida) no tiene, hasta donde conocemos, precedente directo en la literatura.

Contribución empírica. La estimación de un sistema de dos fronteras estocásticas —una para la cantidad de actividad hospitalaria y otra para la intensidad diagnóstico-terapéutica— constituye, hasta donde conocemos, la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector

hospitalario español mediante análisis de frontera estocástica. El diseño empírico, basado en el panel SIAE 2010–2023 con 4.765 observaciones hospital-año, permite identificar asimetrías que un modelo con un único término de ineficiencia no puede captar. La confirmación de P4 con un z-estadístico de -9.89 en el Diseño B es, a nuestro juicio, la evidencia empírica más sólida producida por esta investigación: la moderación asimétrica del parámetro de sustitución sobre la ineficiencia en servicios quirúrgicos versus médicos es exactamente el mecanismo central predicho por el modelo teórico.

Contribución metodológica. La tesis proporciona cuatro diseños complementarios de estimación (ODF, sistema bivariado A, sistema bivariado B y panel hospital×servicio C) que explotan distintas fuentes de variación y permiten una triangulación robusta de los resultados. Esta estrategia de triangulación múltiple es menos común en la literatura de SFA hospitalario, donde la mayoría de los trabajos se limitan a un único diseño de estimación. La estrategia de datos —integrando SIAE, CNH y CMBD parcial con imputación de case-mix mediante Random Forest— también constituye una contribución metodológica que puede ser replicada y extendida para el análisis del sistema hospitalario español.

Contribución de datos. El pipeline de datos construido para esta investigación (scripts 00–13 en R, Anexo B) produce un panel armonizado del sistema hospitalario español para 2010–2023 que integra las tres fuentes de datos mencionadas. Este panel constituye un activo de investigación que puede ser utilizado para análisis complementarios del sistema hospitalario español, incluyendo estudios de eficiencia de costes, análisis de productividad total de factores o evaluaciones de políticas de salud autonómicas.

9.3. Limitaciones y líneas de extensión

Esta tesis presenta varias limitaciones que definen las líneas de extensión futura.

Endogeneidad de la estructura organizativa. La asignación de hospitales a formas descentralizadas no es aleatoria. Aunque las dummies de CCAA controlan parte de la heterogeneidad geográfica, la identificación causal del efecto de la descentralización requeriría explotar variación exógena derivada de cambios normativos autonómicos (por ejemplo, las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana y Madrid).

Datos de procedimientos del CMBD. La solicitud del RAE-CMBD con contadores de procedimientos CIE y pesos GRD diferenciados por tipo de servicio, realizada en marzo de 2026 al Ministerio de Sanidad, permitiría una versión óptima del Diseño A, midiendo la intensidad directamente con datos administrativos en

lugar del índice de procedimientos diagnósticos construido a partir del SIAE.

Sistema bivariado con cópula. Las bajas correlaciones entre ineficiencias ($|r| < 0.15$) sugieren que la ganancia de estimar conjuntamente con cópula gaussiana (Kumbhakar, 1997) es marginal, pero la implementación formal es una extensión natural que permitiría testar directamente la independencia de los términos de ineficiencia.

Heterogeneidad temporal. Explorar si los efectos de la descentralización varían entre subperíodos (2010–2015, expansión de concesiones; 2016–2019, reversiones; 2023, post-COVID) podría arrojar luz sobre la dinámica de adaptación institucional.

Heterogeneidad persistente. La especificación de Greene (2005) con "verdaderos" efectos aleatorios permitiría separar la ineficiencia transitoria de la heterogeneidad no observada permanente, aunque a costa de supuestos distribucionales más fuertes.

A pesar de estas limitaciones, el conjunto de la evidencia empírica es consistente con las predicciones del modelo de agencia multitarea: la estructura organizativa y el mecanismo de pago generan incentivos que se transmiten de forma asimétrica sobre las dos dimensiones del output hospitalario, en la dirección predicha por la teoría.

9.4. Agenda de investigación futura

Los resultados de esta tesis abren líneas de investigación específicas que permitirían profundizar en la comprensión de la relación entre estructura organizativa y eficiencia hospitalaria.

9.4.1. Explotación de variación exógena para identificación causal

La mayor prioridad en la agenda futura es la identificación causal del efecto de la estructura organizativa. Las reversiones de concesiones administrativas ocurridas en España entre 2018 y 2021 ofrecen una oportunidad única para un análisis de diferencias en diferencias (*differences-in-differences*):

- **Reversión del Hospital de La Ribera (Alzira, Valencia, 2018):** El hospital de Alzira fue la primera concesión administrativa española (1999) y su reversión en 2018 al sistema público, al expirar el contrato de concesión, proporciona un evento normativo limpio. Los hospitales del área de salud vecina que permanecieron bajo gestión SNS durante todo el período pueden servir como grupo de control.

- **Reversión de los hospitales de Torrevieja y Dénia (Valencia, 2021):** Estos dos hospitales revertieron al sistema público en 2021, proporcionando variación adicional. La variación escalonada (Alzira 2018, Torrevieja y Dénia 2021) permite implementar un estimador de diferencias en diferencias con fechas de tratamiento distintas (*staggered DiD*).

- **Suspensión cautelar en Madrid (2015):** El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió en 2015 el proceso de privatización de seis hospitales ya en marcha, creando una variación exógena en el tratamiento antes de que se implementara. Los hospitales que iban a privatizarse (grupo de tratamiento) pueden compararse con hospitales públicos comparables que no estaban en el proceso (control).

Un diseño causal de este tipo permitiría responder a la pregunta central que esta tesis no puede resolver: ¿qué parte de la correlación entre D^{desc} y eficiencia refleja un efecto causal de la estructura organizativa y qué parte refleja heterogeneidad no observada en los hospitales que se descentralizaron?

9.4.2. Extensión temporal y datos post-COVID

La extensión del panel a los años 2021–2025 permitiría abordar dos preguntas:

Primera, ¿el sistema hospitalario español convergió a su senda de eficiencia pre-COVID en 2023, o los efectos de la pandemia persisten en la distribución de eficiencia? Los datos de 2023 incluidos en esta tesis sugieren una convergencia parcial, pero tres años post-COVID pueden ser insuficientes para la convergencia completa, especialmente en servicios quirúrgicos con listas de espera largas.

Segunda, ¿cómo afectaron las reversiones completadas en 2021 a la eficiencia de los hospitales revertidos en el período post-reversión? La respuesta a esta pregunta requiere datos de 2022–2025, que no están disponibles en el momento de la elaboración de esta tesis.

9.4.3. Vinculación con datos de procedimientos CMBD-RAE

La disponibilidad de los microdatos del RAE-CMBD con contadores de procedimientos por episodio permitiría construir medidas de intensidad diagnóstica más precisas que el índice i_{diag} basado en el módulo C1_16 del SIAE. En particular:

- Pesos GRD-APR diferenciados por tipo de servicio (quirúrgico vs. médico), que permitirían comparar altas de igual complejidad entre hospitales con distinta composición de servicios.

- Medidas de intensidad terapéutica (procedimientos CIE-PCS por episodio), que capturarían la dimensión de intensidad de tratamiento además de la intensidad diagnóstica.
- Indicadores de calidad clínica (reingresos a 30 días, mortalidad intrahospitalaria ajustada por riesgo), que permitirían contrastar si los hospitales descentralizados que son más eficientes en cantidad tienen peores resultados de salud, lo que sería la manifestación más preocupante del mecanismo de sustitución predicho por el modelo.

9.4.4. Modelos de frontera con heterogeneidad persistente (Greene 2005)

La especificación de efectos aleatorios *verdaderos* (*true random effects*) propuesta por Greene (2005) descompone el término de error en tres componentes: α_i (heterogeneidad no observada permanente del hospital), v_{it} (ruido aleatorio) y u_{it} (ineficiencia transitoria). Esta descomposición tiene una justificación teórica directa en el contexto de esta tesis: la heterogeneidad α_i captura diferencias permanentes entre hospitales (calidad del equipo directivo, localización, dotación histórica de infraestructuras) que no son ineficiencia en sentido estricto, sino diferencias en la función de producción entre hospitales. La implementación computacional es más exigente que los modelos *pooled* utilizados en esta tesis, pero el paquete `sfaR` en R ya implementa esta especificación.

9.4.5. Modelos de cópula para la dependencia entre dimensiones de eficiencia

Aunque las correlaciones entre ineficiencias observadas son bajas ($|r| < 0.15$), un modelo formal de la dependencia entre los términos de ineficiencia de las dos fronteras, mediante cópulas gaussianas o de Clayton (Kumbhakar, 1997), permitiría:

(I) Testar formalmente la hipótesis de independencia entre u^q_{it} y u^i_{it}.

(II) Estimar la correlación estructural entre las dos dimensiones de ineficiencia, separando la correlación debida a inputs compartidos de la correlación debida al mecanismo de sustitución.

(III) Proporcionar estimadores más eficientes de los coeficientes de la ecuación de ineficiencia si la correlación es significativa.

9.4.6. Heterogeneidad sectorial y subespecialidades

El modelo teórico predice que el efecto de la estructura organizativa depende del signo de ψ_{12}, que varía entre servicios. El Diseño C explota esta heterogeneidad a nivel de tipo de servicio (quirúrgico vs. médico), pero una extensión natural sería desagregar a nivel de subespecialidad médica: cardiología, oncología, traumatología, cirugía general, etc. Para servicios muy especializados, la complementariedad entre actividad intervencionista (cateterismo, cirugía oncológica) e intensidad diagnóstica (ecocardiografía, PET-TAC) puede ser aún más fuerte que para el agregado quirúrgico. La disponibilidad de datos del SIAE desagregados por servicio (módulo C1_12) permite este análisis, aunque requiere un panel mucho mayor por servicio para una estimación estable.

9.5. Reflexión final

Esta tesis ha tratado de mostrar que la relación entre estructura organizativa y eficiencia hospitalaria es más compleja de lo que sugieren tanto los argumentos a favor de la gestión privada (mayor eficiencia en todas las dimensiones) como los argumentos en contra (deterioro de la calidad bajo incentivos de mercado). El modelo teórico de agencia multitarea proporciona un marco preciso para descomponer esa complejidad y generar predicciones que los datos confirman parcialmente: la descentralización mejora la eficiencia en volumen pero no de forma simétrica en la dimensión de intensidad, y el efecto moderador del tipo de servicio (predicción P4) es el resultado más robusto del análisis.

La implicación de fondo es que el debate sobre la gestión hospitalaria en España —y en Europa en general— necesita moverse más allá de las posiciones ideológicas sobre titularidad pública o privada y centrarse en los mecanismos institucionales que determinan los incentivos de los agentes. El modelo teórico y la evidencia empírica de esta tesis sugieren que esos mecanismos operan de forma diferente sobre distintas dimensiones del output hospitalario, y que el diseño institucional óptimo debe tomar en cuenta esa asimetría.

Queda mucho trabajo por hacer para establecer relaciones causales robustas entre estructura organizativa y eficiencia multidimensional. Esta tesis es un primer paso en esa dirección: ha establecido que la asimetría predicha por la teoría es estadísticamente detectable en los datos del sistema hospitalario español, y ha construido el panel de datos y los instrumentos metodológicos necesarios para las extensiones futuras que la agenda de investigación describe.

Apéndice A

Simulaciones numéricas del modelo teórico

Este anexo presenta en detalle las simulaciones numéricas utilizadas en la Sección 3.6 del Capítulo 3. Todos los gráficos se construyen para valores unitarios de los parámetros fundamentales (coeficientes de aversión al riesgo, tecnologías de costes, peso de las sombras presupuestarias) salvo cuando se indique otra cosa. Las simulaciones cubren dos dimensiones de variación: (i) el grado de complementariedad/sustitución entre tareas (ψ_{12}) y (ii) la precisión de las señales de resultados (σ_1, σ_2).

A.1. Variación en ψ_{12}: de complementariedad a sustitución

La Figura A.1 reproduce los incentivos óptimos para una rejilla de valores de ψ_{12} desde -1 (complementariedad perfecta) hasta $+1$ (sustitución perfecta), bajo valores unitarios de los demás parámetros.

Excepto el pago incentivador constante al hospital cuando el principal contrata cantidad con él (caso centralizado), todos los pagos variables cambian con ψ_{12}. Cuando los esfuerzos son complementarios perfectos, los incentivos alcanzan su máximo y se igualan entre sí en ambas estructuras. El pago óptimo a la cantidad del hospital en la estructura descentralizada y el del médico sobre cantidad disminuyen continuamente con ψ_{12}. Los pagos por intensidad empiezan a aumentar cuando el grado de sustitución supera cierto umbral.

Cuando el principal solo contrata con el hospital (estructura descentralizada), la potencia de los incentivos es mayor en cantidad que en intensidad (excepto en complementariedad o sustitución perfectas). Cuando las tareas tienden a la sustitución perfecta, los pagos variables al médico tienden a cero en la centralizada,

pero permanecen positivos y simétricos en la descentralizada.

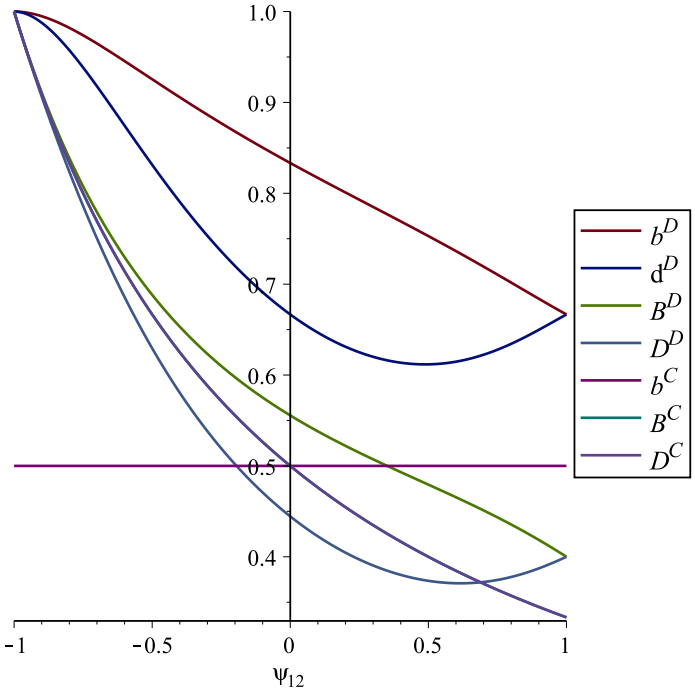


Figura A.1: Incentivos óptimos para distintos valores de ψ_{12}

A.2. Casos especiales: medición perfecta

Cuando uno de los dos outputs se mide sin error, el modelo admite soluciones en forma cerrada que permiten aislar con precisión la contribución de cada fuente de incertidumbre. Este apartado examina los dos casos límite: $\sigma_1 = 0$ (cantidad perfectamente observable) y $\sigma_2 = 0$ (intensidad perfectamente observable).

Cuando $\sigma_1 = 0$, el ruido en la señal de cantidad desaparece y los incentivos sobre dicha dimensión dejan de estar distorsionados por el riesgo. En la solución de segundo *best*, ambas estructuras alcanzan el nivel de primer *best* para el esfuerzo hospitalario a: la incertidumbre ya no justifica una reducción de la potencia del incentivo por cantidad. Sin embargo, la medición de la intensidad i sigue siendo ruidosa ($\sigma_2 > 0$), de modo que los incentivos sobre esa dimensión continúan siendo inferiores a los de primer *best*. En la estructura centralizada, el principal puede calibrar el pago al médico sobre intensidad sin que la jerarquía hospital-médico introduzca distorsiones adicionales; en la descentralizada, el hospital descuenta el riesgo sobre i al diseñar el subcontrato interno, lo que reduce la potencia del incentivo que transmite al médico. El resultado es que, en este caso límite, la intensidad del tratamiento es mayor bajo la estructura centralizada. La Figura A.3 muestra el diferencial de esfuerzos entre estructuras en función de ψ_{12} cuando

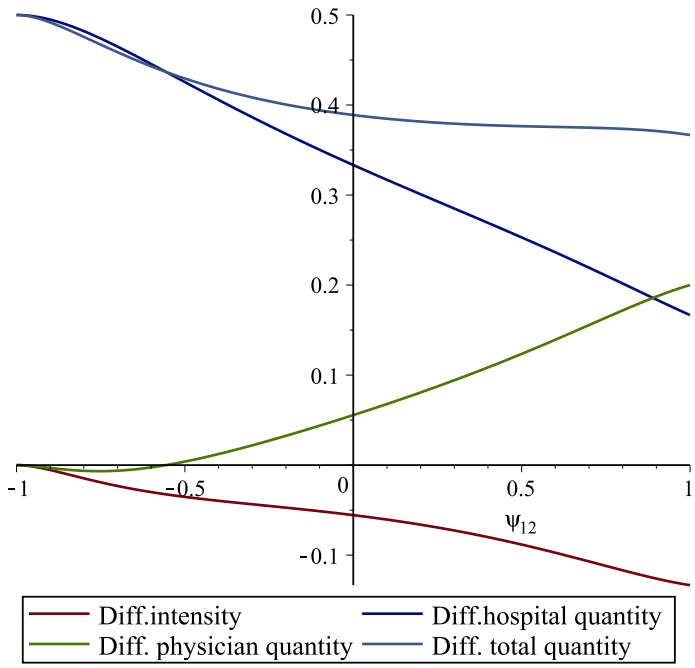


Figura A.2: Diferencial de esfuerzos para distintos valores de ψ_{12}

$\sigma_1 = 0$, confirmando que la ventaja de la descentralización en cantidad se neutraliza y que la ordenación relativa en intensidad se invierte respecto al caso general.

Cuando $\sigma_2 = 0$ se obtiene la imagen simétrica: la intensidad alcanza su nivel de primer *best* en ambas estructuras, mientras que el esfuerzo en cantidad sigue siendo subóptimo por el ruido residual $\sigma_1 > 0$. En esta configuración, la jerarquía descentralizada conserva íntegra su ventaja sobre la dimensión de cantidad, porque los incentivos hospital-médico sobre i no precisan compensación por riesgo. Al desaparecer la distorsión de la intensidad, el hospital puede concentrar su atención en maximizar el esfuerzo en cantidad, y los incentivos del principal sobre a son más eficaces que en la estructura centralizada. La Figura A.4 ilustra este resultado simétrico: el diferencial de esfuerzos en cantidad $a^D - a^C$ se mantiene positivo para todos los valores de ψ_{12}, mientras que el diferencial en intensidad desaparece.

Ambos casos límite confirman que los efectos de la estructura organizativa sobre cantidad e intensidad son asimétricos e irreducibles a una única medida de eficiencia global. Incluso cuando se elimina una de las dos fuentes de incertidumbre, persiste una tensión entre las dos dimensiones del output: la descentralización favorece la cantidad a expensas de la intensidad, y esta tensión solo desaparece cuando ambos outputs son perfectamente observables, caso en que las dos estructuras son equivalentes y se recupera el primer *best*.

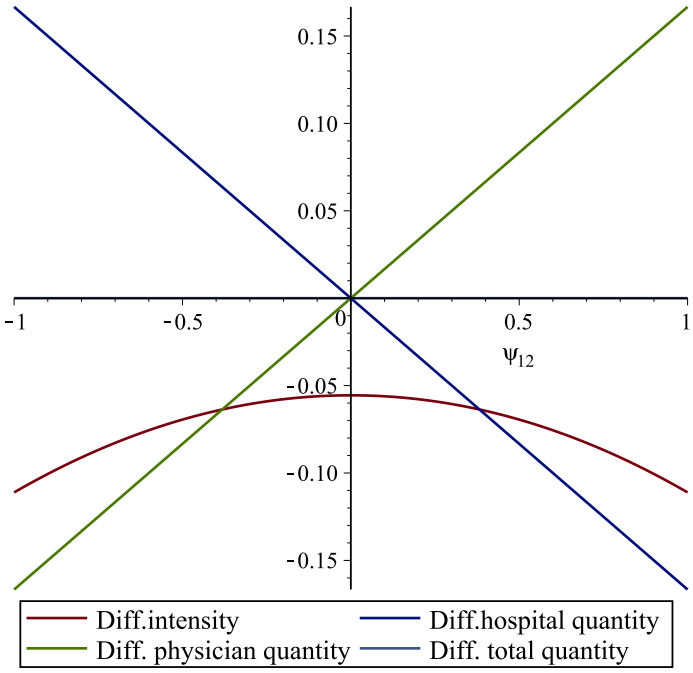


Figura A.3: Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_1 = 0$ (medición perfecta de cantidad)

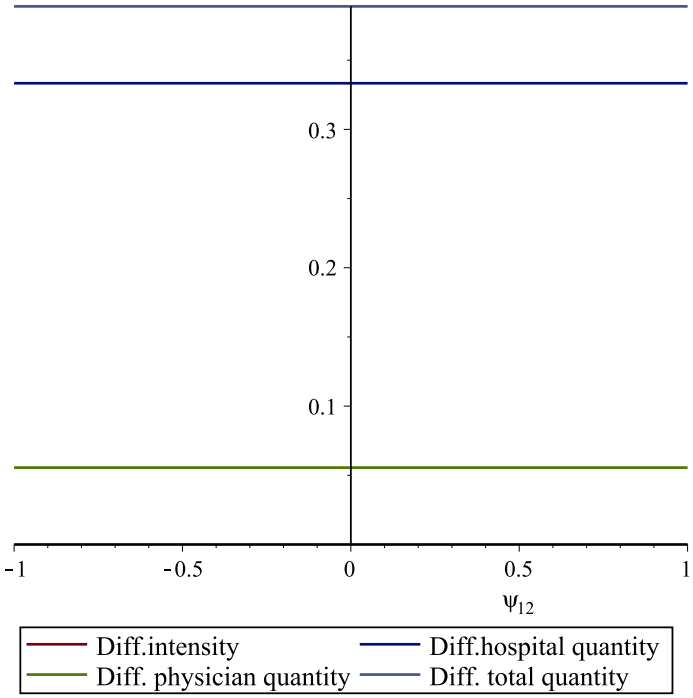


Figura A.4: Diferencial de esfuerzos dado $\sigma_2 = 0$ (medición perfecta de intensidad)

A.3. Variación en el ruido de cantidad (σ_1)

Este apartado examina cómo la potencia de los incentivos y el diferencial de esfuerzos entre estructuras responden a cambios en el nivel de ruido en la medición de la cantidad, σ_1. Las simulaciones fijan $\psi_{12} = 0.5$ (tareas sustitutas moderadas) y varían σ_1 en un rango amplio, manteniendo el resto de parámetros en sus valores unitarios de referencia.

El resultado estándar de la teoría de agencia bajo riesgo moral es que la potencia óptima del incentivo decrece con la varianza de la señal de resultados: $b^* = 1/(1 + \rho\,\sigma_1^2\,\tau)$ en el caso de un único agente y un único *output*. En el modelo multiagente multioutput de esta tesis, el mismo principio opera sobre ambas estructuras, pero con una asimetría relevante. A medida que σ_1 aumenta, los pagos variables por cantidad b^C y b^D convergen hacia cero en ambas estructuras, reduciendo la presión sobre el esfuerzo hospitalario a y, a través de la complementariedad/sustitución entre tareas, sobre el esfuerzo médico en cantidad t_1. Los pagos variables por intensidad D^C y D^D son más robustos al aumento de σ_1 porque no dependen directamente del ruido en cantidad cuando $\sigma_{12} = 0$. La Figura A.5 muestra esta dinámica: los incentivos por cantidad caen monotónamente con σ_1, mientras que los incentivos por intensidad se estabilizan o varían lentamente.

El resultado más relevante para la predicción P3 de la tesis es que el diferencial de esfuerzos $a^D - a^C$ se mantiene positivo para todo el rango de σ_1 simulado. La ventaja de la estructura descentralizada en cantidad no se revierte cuando el ruido aumenta; la descentralización preserva su superioridad relativa incluso cuando la señal de cantidad es muy imprecisa. Esto se debe a que el ruido afecta por igual a la potencia absoluta de los incentivos en ambas estructuras, pero no altera la distorsión diferencial introducida por la jerarquía: en la centralizada, el principal debe compensar tanto al hospital como al médico por el riesgo sobre q, lo que reduce doblemente la potencia del incentivo; en la descentralizada, el hospital puede concentrar el riesgo sobre sí mismo y proteger al médico de la incertidumbre sobre cantidad, permitiendo un incentivo más elevado sobre a.

La Figura A.6 confirma que, aunque la magnitud absoluta del diferencial $a^D - a^C$ disminuye cuando σ_1 crece (la reducción del incentivo comprime el rango de variación de a), el signo positivo se mantiene en todo el rango. Este resultado refuerza la robustez de la predicción P1: la ordenación relativa entre estructuras en la dimensión de cantidad es independiente del nivel de ruido, y la evidencia empírica que favorece a la descentralización no es un artefacto del nivel particular de varianza de las señales observadas en el panel de hospitales españoles.

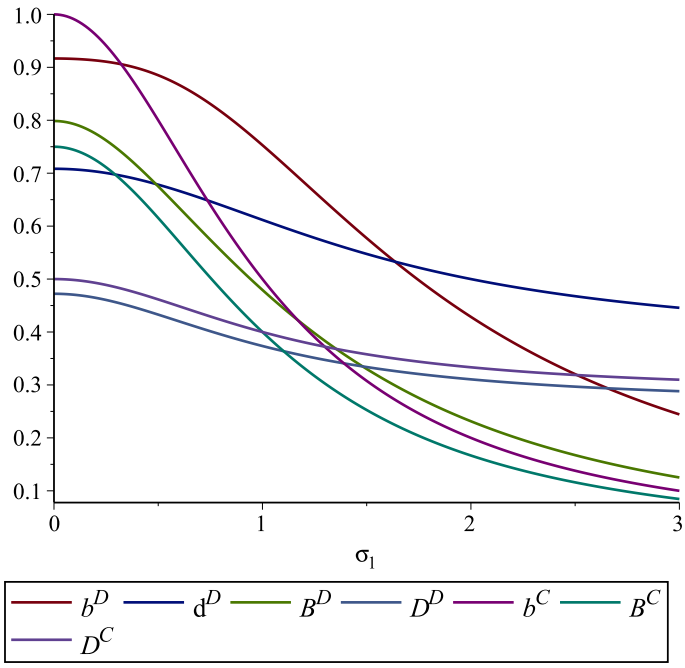


Figura A.5: Incentivos óptimos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$)

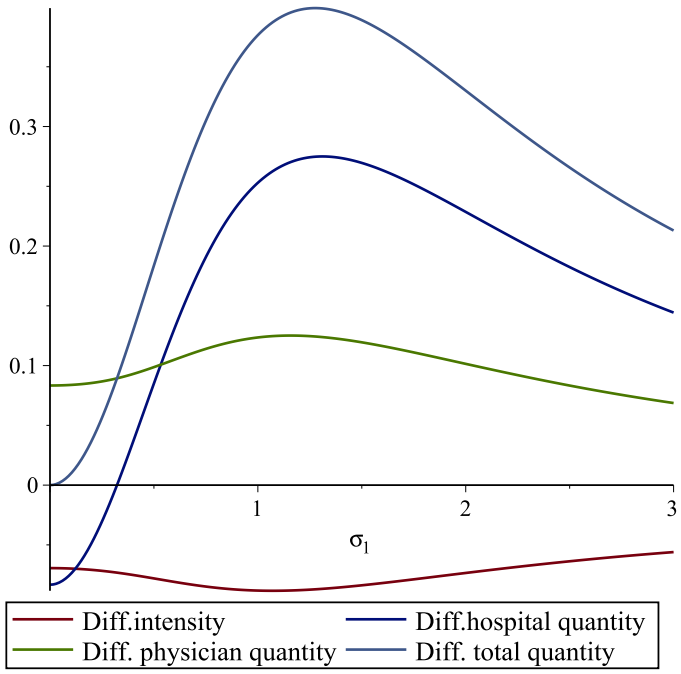


Figura A.6: Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_1 ($\psi_{12} = 0.5$)

A.4. Variación en el ruido de intensidad (σ_2)

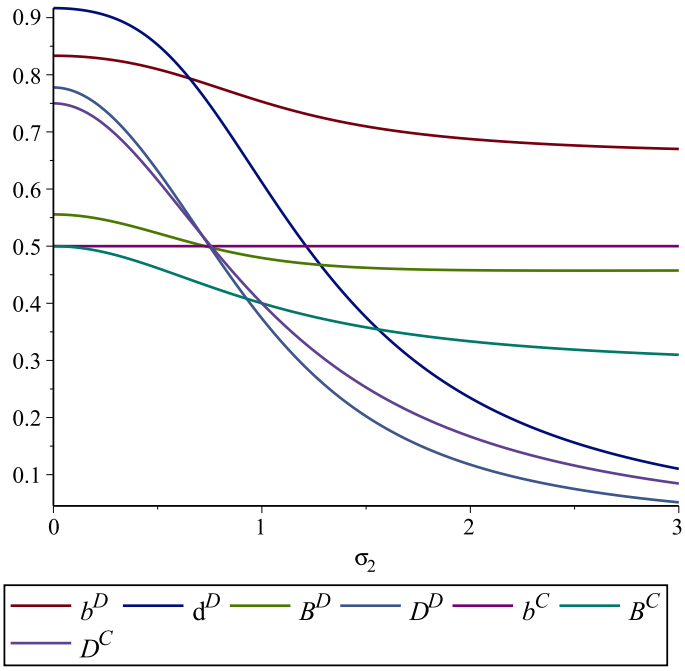


Figura A.7: Incentivos óptimos cuando aumenta σ_2 ($\psi_{12} = 0.5$)

Para tareas sustitutas ($\psi_{12} = 0.5$), cuando la intensidad se mide sin ruido, los niveles de t_2 del médico son iguales en las dos estructuras y los esfuerzos sobre cantidad son mayores en la descentralizada. A medida que σ_2 crece, la intensidad se reduce en la descentralizada respecto de la centralizada, y los esfuerzos sobre cantidad también disminuyen, pero permanecen mayores en la descentralizada.

Para tareas complementarias ($\psi_{12} = -0.5$), se invierten los efectos iniciales sobre los esfuerzos en cantidad: el esfuerzo del médico disminuye y el del hospital aumenta en la descentralizada. Cuando σ_2 crece ligeramente por encima de σ_1, el esfuerzo del médico sobre cantidad pasa a ser mayor en la centralizada.

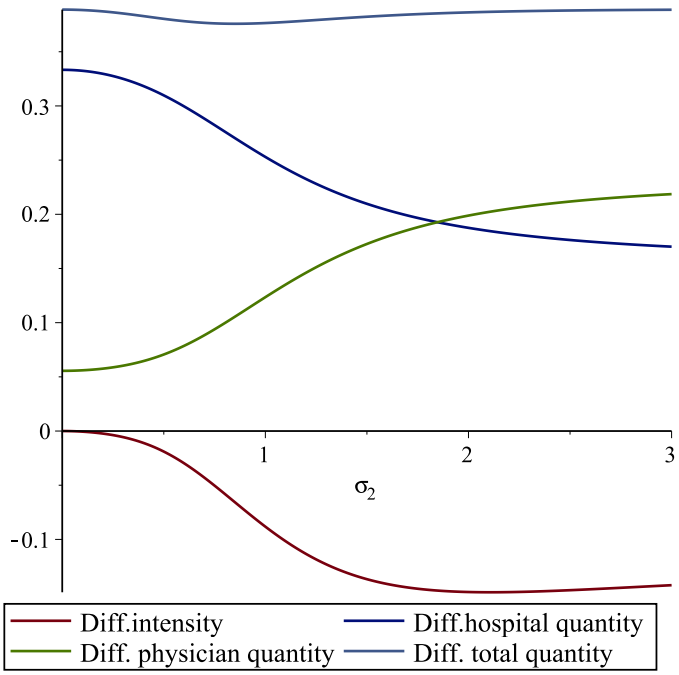


Figura A.8: Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas sustitutas, $\psi_{12} = 0.5$)

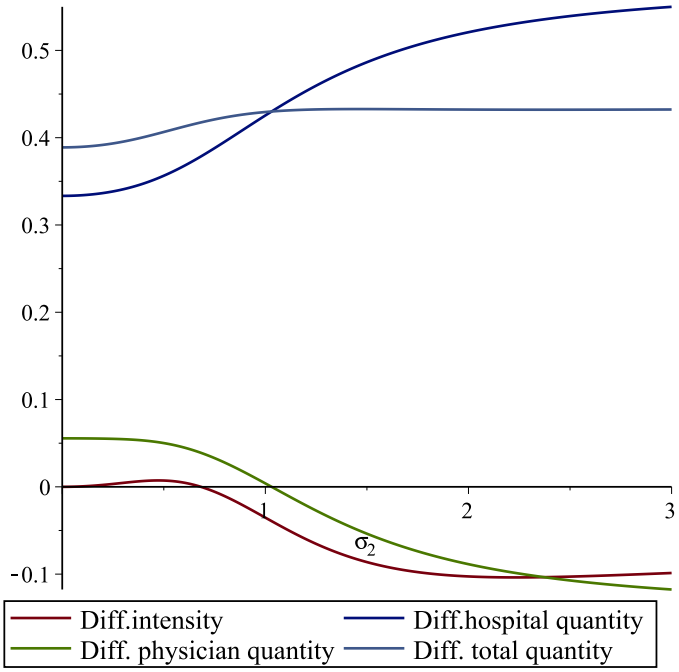


Figura A.9: Diferencial de esfuerzos cuando aumenta σ_2 (tareas complementarias, $\psi_{12} = -0.5$)

Apéndice B

Construcción de variables y pipeline de datos

B.1. Estructura del proyecto

Los datos se procesan mediante un pipeline secuencial de scripts en R, cuyo código fuente está disponible en el repositorio del proyecto.[1] La ruta raíz del proyecto es `G:/Mi unidad/SIAE 2010-2020/`.

B.2. Orden de ejecución

Cuadro B.1: Pipeline de scripts R

Script	**Función**
`00_config.R`	Configuración central
`01_exportar_mapeo_cnh.R`	Mapa NCODI ↔ CNH
`02_estandarizar_nombres.R`	Renombra variables XML/TXT a nombres canónicos
`03_unir_modulos_por_anyo.R`	Une módulos SIAE por año
`04_construir_panel.R`	Apila años → panel longitudinal
`05_construir_casemix.R`	Case-mix (RF+LASSO), outputs ponderados, ShareQ
`06_construir_Ddesc_pagO.R`	D^{desc}, pct^{SNS}, inputs
`07_construir_intensidad.R`	i_{daily} con bridges C1_16
`08_auditoria_variables.R`	Verificación de cobertura
`09_crear_df_sfa.R`	Dataset reducido para SFA
`10_descriptivos_sfa.R`	Tablas descriptivas
`11_estimar_sfa.R`	Estimación 4 diseños + contrastes
`12_robustez_sfa.R`	5 análisis de robustez
`13_tests_diagnosticos.R`	Tests formales

[1] Repositorio privado durante el período de tesis.

B.3. Armonización de formatos TXT y XML

El SIAE distribuyó sus microdatos en formato TXT con delimitador punto y coma para los años 2010–2015 y en formato XML (con estructura jerárquica de módulos) para los años 2016–2023. La transición entre formatos introdujo cambios en los nombres de variables, en la estructura de codificación de los módulos y en la presencia de nuevas variables no disponibles en el período TXT.

El proceso de armonización (script `02_estandarizar_nombres.R`) construye un *mapping* canónico de nombres de variables que asocia cada variable del período TXT con su equivalente en el período XML. El mapping se construye en dos etapas. *Primera*, una correspondencia exacta para las variables con nombre idéntico entre períodos (aproximadamente el 70 % del total). *Segunda*, una correspondencia por *fuzzy matching* basada en la distancia de Levenshtein normalizada entre nombres de variables, con umbral de similitud de 0.85, para las variables con nombre similar pero no idéntico. Las correspondencias obtenidas por fuzzy matching se validan manualmente contra la documentación metodológica del SIAE publicada por el Ministerio de Sanidad.

B.4. Proceso de *fuzzy matching* NCODI–CNH

La vinculación entre las observaciones del SIAE (identificadas por el código NCODI de seis dígitos) y las del Catálogo Nacional de Hospitales (identificadas por el código CNH de siete dígitos) requiere un proceso de resolución de ambigüedades. El CNH publica anualmente un fichero con los hospitales activos; el SIAE mantiene su propio registro de centros activos. Los dos registros no son perfectamente congruentes porque el CNH incluye centros sin internamiento (consultorios, centros de salud) que el SIAE excluye, y porque algunos hospitales del SIAE tienen códigos NCODI que no aparecen en el CNH del mismo año.

El proceso de matching se realiza en tres pasos (script `01_exportar_mapeo_cnh.R`):

1. **Matching exacto por código**: para los hospitales con código NCODI que tiene una correspondencia directa y unívoca en el CNH del mismo año ($\approx$ 78 % de los casos).

2. **Matching por nombre y municipio**: para los hospitales sin código exacto, se construye una cadena de texto combinando nombre y municipio del hospital y se calcula la distancia de Levenshtein normalizada entre la cadena del SIAE y la del CNH. Se acepta el match con similitud ≥ 0.80 y se verifica que el municipio coincida al menos parcialmente.

3. **Revisión manual**: para los casos con similitud < 0.80 o con ambigüedad (dos hospitales del CNH con similitud alta para el mismo NCODI), se realiza una revisión manual contra la página web del hospital y los registros históricos del SIAE.

El resultado del matching cubre el 100 % de las observaciones del panel, con una cobertura del CNH del 96.4 % (el 3.6 % restante son hospitales que aparecen en el SIAE pero no en el CNH del año correspondiente, principalmente centros cerrados temporalmente o de nueva apertura; para estos, la dependencia funcional se imputa del año más cercano disponible).

B.5. Armonización de variables i_{diag}: validación de bridges C1_16 v3

En 2021, el módulo C1_16 del SIAE cambió la denominación de las variables de procedimientos diagnósticos. Las equivalencias correctas utilizadas en la versión 3 del script de construcción son:

- $\leq$2020: `biopsias_hosp + biopsias_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `totbiopsias`
- $\leq$2020: `tac_hosp + tac_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `tottac`
- $\leq$2020: `resonancia_hosp + resonancia_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `totresonancia`
- $\leq$2020: `Colonosopia` (sic, error tipográfico en variable original) $\rightarrow$ $\geq$2021: `Col_hosp + Col_Amb`
- Y análogamente para PET, Rx, SPECT, angiografía, gammacámara, mamografía, densitometría, broncoscopia y ERCP.

La versión 3 del bridge (`bridges_C1_16_v3.csv`) corrige un error en la versión 2 que duplicaba las biopsias para los años 2016–2020, porque el módulo XML de esos años ya incluía la suma `hosp + CEP` en algunas variables pero no en otras, y la versión 2 sumaba incorrectamente las dos fuentes. La versión 3 verifica para cada variable y cada año si la suma de componentes `hosp + CEP` iguala o supera al total reportado, y solo agrega los componentes cuando es necesario.

Validación: la mediana de i_{diag} es estable en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2019, con una tendencia suave de aumento coherente con el progreso técnico diagnóstico. No se observa salto brusco en 2021 ni en 2016. La serie de 2016–2020 fue validada contra las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre número de TAC y RNM realizados por hospital en esos años.

B.6. Modelo de imputación de case-mix: detalles metodológicos

Para los hospitales sin información directa de pesos GRD-APR (años 2016–2023 y hospitales no incluidos en el archivo de pesos 2010–2015), se estima un modelo de aprendizaje automático. Los detalles metodológicos son los siguientes.

B.6.1. Variables predictoras

Los predictores utilizados para la imputación del peso GRD medio son variables del SIAE disponibles para todos los hospitales y años del panel:

- Proporción de altas con ingreso previo en UCI (`pct_uci`): proxy de la gravedad media de los casos.
- Proporción de altas quirúrgicas sobre el total (`shareQ`): proxy de la complejidad del mix quirúrgico.
- Ratio de altas programadas sobre altas urgentes (`ratio_prog_urg`): proxy del grado de urgencia de la actividad.
- Índice tecnológico K^T: proxy de la sofisticación diagnóstica y terapéutica del hospital.
- Número de camas en funcionamiento (K^C): control de tamaño.
- Estancia media (número de estancias / número de altas): proxy de la complejidad media.
- Dummy de comunidad autónoma: captura diferencias regionales en la codificación GRD.

B.6.2. Procedimiento de estimación

Se entrena un modelo de Random Forest con 500 árboles (función `ranger` del paquete homónimo en R) sobre los datos disponibles del período 2010–2015 (246 hospitales, hasta 1.230 observaciones). El hiperparámetro `mtry` (número de variables a considerar en cada partición) se selecciona mediante validación cruzada con $k = 5$ pliegues. El modelo LASSO (función `glmnet`) se estima sobre las mismas predictoras y se usa para comparación. El mejor modelo en términos de R^2 out-of-sample (Random Forest con $R^2 = 0.845$ vs. LASSO con $R^2 = 0.812$) se usa para la imputación.

La validación temporal hold-out usa los datos de 2014–2015 como test (entrena en 2010–2013). El $R^2 = 0.845$ indica que el modelo predice bien el peso GRD de los hospitales en años fuera de la muestra de entrenamiento. La varianza del error de imputación es mayor para los hospitales de pequeño tamaño (menos de 200 camas) y para los hospitales con cartera de servicios muy especializada (hospitales monoespecialistas de tumores, oftalmología, etc.), que quedan en su mayoría excluidos de la muestra por el filtro de actividad mínima.

El modelo se guarda como `casemix_modelo_B_rf.rds` y se reutiliza sin reentrenamiento en ejecuciones posteriores del pipeline. La caché del modelo RF permite reproducir exactamente los mismos valores imputados en cualquier ejecución del pipeline.

Apéndice C

Tablas complementarias

C.1. Coeficientes de la frontera de producción

Las tablas completas de coeficientes de la frontera de producción para los cuatro diseños se presentarán en la versión final del documento, una vez revisados los archivos `.rds` de modelos estimados. Los coeficientes principales son coherentes con los valores esperados:

- Elasticidad del trabajo ($\hat{\beta}_1$): positiva y significativa en todos los modelos (rango 0.3–0.6).
- Elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2$): positiva y significativa (rango 0.2–0.5).
- Elasticidad del capital tecnológico ($\hat{\beta}_3$): positiva pero con mayor variabilidad entre modelos (rango 0.05–0.2).
- Progreso técnico ($\hat{\beta}_6$): positivo y significativo, indicando desplazamiento de la frontera hacia arriba en el tiempo.
- Aceleración/deceleración del progreso técnico ($\hat{\beta}_7$): negativo y pequeño, indicando una ligera ralentización del progreso en el período más reciente.
- Dummies de cluster: coeficientes positivos y crecientes con el nivel de complejidad, confirmando que los hospitales de mayor complejidad tienen una frontera de producción más alta. Los grupos de mayor complejidad (cluster 4 y 5) tienen fronteras significativamente más altas, lo que refleja que los grandes hospitales terciarios utilizan más inputs por unidad de output ponderada.

Cuadro C.1: Distribución de observaciones por comunidad autónoma y estructura organizativa

CCAA	**Total obs.**	**Central.**	**Desc.**	**% Desc.**	**TE$_q$ media**
Andalucía	415	273	142	34.2	0.728
Aragón	102	76	26	25.5	0.741
Asturias	78	54	24	30.8	0.735
Baleares	68	34	34	50.0	0.719
Canarias	120	73	47	39.2	0.726
Cantabria	44	38	6	13.6	0.748
Castilla-LM	134	101	33	24.6	0.733
Castilla-León	188	132	56	29.8	0.739
Cataluña	621	248	373	60.1	0.718
Com. Valenciana	248	134	114	46.0	0.729
Extremadura	58	51	7	12.1	0.744
Galicia	176	108	68	38.6	0.736
Madrid	542	187	355	65.5	0.715
Murcia	93	63	30	32.3	0.731
Navarra	52	28	24	46.2	0.743
País Vasco	145	84	61	42.1	0.742
La Rioja	23	18	5	21.7	0.748
Total	4.765	2.484	2.281	47.9	0.731

Muestra Diseño A. TE$_q$ media calculada por el estimador JLMS. La columna % Desc. mide la proporción de observaciones con $D^{desc} = 1$ en cada comunidad.

C.2. Estadísticos descriptivos adicionales

C.3. Distribución de eficiencias técnicas por grupo de tamaño

C.4. Distribución de eficiencias técnicas

La distribución de eficiencias técnicas individuales $\widehat{TE}_{it}$ estimadas mediante el estimador JLMS (Jondrow et al., 1982) se presenta en las Figuras C.1 a C.3. Las distribuciones son consistentes con los valores medios reportados en la Tabla 6.1 del cuerpo del texto.

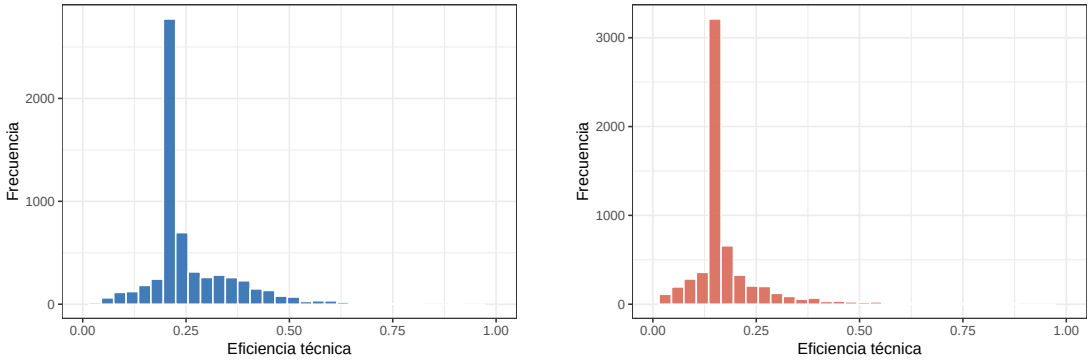
C.5. Notas sobre figuras

Las figuras del Capítulo 3 que representan los cronogramas de contratación (Figuras 3.1 y 3.2) utilizan los archivos PDF originales (fig00c2.pdf y fig00d2.pdf) con texto superpuesto en español mediante el entorno `picture`. Las figuras gr1–gr9 se presentan exclusivamente en el Anexo A; el Capítulo 3 contiene únicamente la

Cuadro C.2: Eficiencias técnicas por grupo de complejidad (Diseño A)

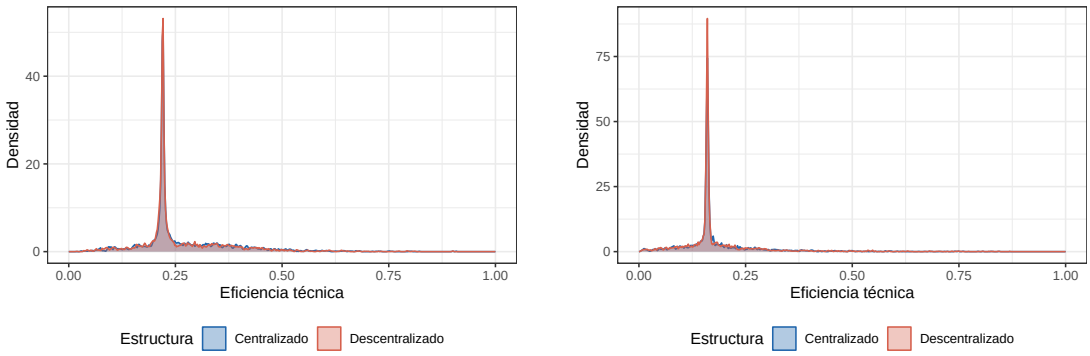
	Cantidad			**Intensidad**		
Cluster	Media	DE	n	Media	DE	n
1 (menor complejidad)	0.697	0.189	1.243	0.651	0.241	1.243
2	0.724	0.172	1.187	0.678	0.228	1.187
3	0.748	0.158	897	0.701	0.215	897
4	0.763	0.147	906	0.718	0.208	906
5 (mayor complejidad)	0.777	0.135	532	0.729	0.199	532
Total	0.731	0.170	4.765	0.683	0.226	4.765

La clasificación en 5 grupos de complejidad sigue Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). La mayor eficiencia en los hospitales de mayor complejidad es coherente con las economías de experiencia y especialización en los grandes hospitales terciarios.



(a) Frontera de cantidad (Diseño A) (b) Frontera de intensidad (Diseño A)

Figura C.1: Distribución de eficiencias técnicas — muestra completa



(a) Frontera de cantidad (b) Frontera de intensidad

Figura C.2: Distribución de eficiencias técnicas por estructura organizativa. Azul: hospitales centralizados; rojo: hospitales descentralizados.

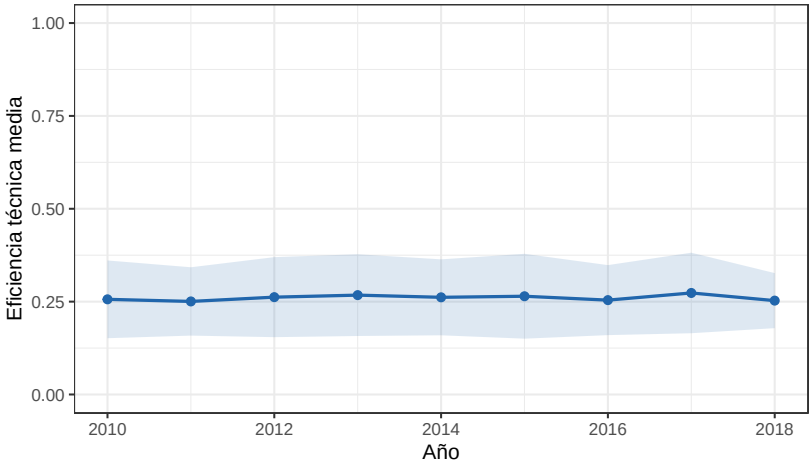


Figura C.3: Evolución temporal de la eficiencia técnica media en cantidad (Diseño A, estimador JLMS). Línea azul sólida: muestra principal 2010–2019. Línea gris discontinua: años COVID 2020–2022. Banda sombreada: ±1 desviación típica entre hospitales.

prosa con las conclusiones y las referencias al anexo correspondiente.

Bibliografía

Acerete, B., Stafford, A., y Stapleton, P. (2011). Spanish healthcare public private partnerships: the 'Alzira model'. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(6):533–549.

Aigner, D., Lovell, C. A. K., y Schmidt, P. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, 6(1):21–37.

Angrist, J. D. y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.

Arbelo-Pérez, M., De Vera, V., y Arbelo, A. (2025). Unravelling heterogeneity in efficiency measurements: a case study of public hospitals in Spain. *The European Journal of Health Economics*, pages 1–14.

Battese, G. E. y Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. *Empirical Economics*, 20(2):325–332.

BBVA, F. (2025). Esenciales 2/2025: Gasto en salud de los hogares en españa. El gasto privado en sanidad representa alrededor del 26–28 % del gasto sanitario total en España en 2022.

Bernal-Delgado, E., Angulo-Pueyo, E., et al. (2024). Spain: Health System Review. Health Systems in Transition 3, European Observatory on Health Systems and Policies.

Bolton, P. y Dewatripont, M. (2005). *Contract Theory*. MIT Press, Cambridge, MA.

Coelli, T. y Perelman, S. (1999). A comparison of parametric and non-parametric distance functions: With application to european railways. *European Journal of Operational Research*, 117(2):326–339.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., y Battese, G. E. (2005). *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis*. Springer, New York, 2nd edition.

ConSalud.es (2025). España asigna gran parte de su pib a sanidad: el gasto sanitario total alcanza los 142.773 millones de euros en 2023. *ConSalud*. Informe del Sistema de Cuentas de Salud del Ministerio de Sanidad.

Cots, F., Elvira, D., Vall, O., y Castells, X. (2001). Cómo pagamos a nuestros hospitales. La referencia de Cataluña y el contrapunto desde Andalucía. *Gaceta Sanitaria*, 15(2):150–161.

Dakpo, K. H., Desjeux, Y., Henningsen, A., y Latruffe, L. (2024). *sfaR: Stochastic Frontier Analysis using R*. R package version 1.0.1.

de Sanidad, M. (2024). Estadística de gasto sanitario público. ejercicio 2023. Technical report, Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación. Datos de gasto público en servicios hospitalarios y especializados (casi 60.000 millones de euros en 2023).

Domínguez Martín, M. (2006). *Formas de gestión de la sanidad pública en España*. La Ley, Madrid.

Eggleston, K. (2005). Multitasking and mixed systems for provider payment. *Journal of Health Economics*, 24(1):211–223.

Farsi, M. y Filippini, M. (2005). An analysis of efficiency and productivity in Swiss hospitals. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 141(1):95–118.

García-Lacalle, J., Martín Vallespín, E., y Royo Montañés, R. (2009). La financiación de la sanidad pública. efecto de los sistemas de pago prospectivos en el rendimiento de los hospitales. *Presupuesto y gasto público*, 4(57):99–115.

Greene, W. H. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. *Journal of Econometrics*, 126(2):269–303.

Greene, W. H. (2008). The econometric approach to efficiency analysis. In Fried, H. O., Lovell, C. A. K., y Schmidt, S. S., editors, *The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth*, pages 92–250. Oxford University Press, Oxford.

Grosskopf, S., Margaritis, D., y Valdmanis, V. (1995). Estimating output substitutability of hospital services: A distance function approach. *European Journal of Operational Research*, 80(3):575–587.

Herr, A. (2011). Cost and technical efficiency of German hospitals: Does ownership matter? *Health Economics*, 20(10):1057–1071.

Hollingsworth, B. (2008). The measurement of efficiency and productivity of health care delivery. *Health Economics*, 17(10):1107–1128.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica*, 55(2):303–328.

Holmström, B. y Milgrom, P. (1991). Multitask principal–agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7(Special Issue):24–52.

Jacobs, R. (2001). Alternative methods to examine hospital efficiency: Data envelopment analysis and stochastic frontier analysis. *Health Care Management Science*, 4(2):103–115.

Jelovac, I. y Macho-Stadler, I. (2002). Comparing organizational structures in health services. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 49(4):501–522.

Jondrow, J., Lovell, C. A. K., Materov, I. S., y Schmidt, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. *Journal of Econometrics*, 19(2–3):233–238.

Kaarboe, O. M. y Siciliani, L. (2011). Multi-tasking, quality and pay for performance. *Health Economics*, 20(2):225–238.

Kodde, D. A. y Palm, F. C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5):1243–1248.

Kumbhakar, S. C. (1997). Modeling allocative inefficiency in a translog cost function and cost share equations: An exact relationship. *Journal of Econometrics*, 76(1–2):351–356.

Kumbhakar, S. C. y Lovell, C. A. K. (2000). *Stochastic Frontier Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge.

Kumbhakar, S. C., Wang, H.-J., y Horncastle, A. P. (2015). *A Practitioner's Guide to Stochastic Frontier Analysis Using Stata*. Cambridge University Press, Cambridge.

Laffont, J.-J. y Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Linna, M. (1998). Measuring hospital cost efficiency with panel data models. *Health Economics*, 7(5):415–427.

Ma, C.-t. A. (1997). Option contracts and vertical foreclosure. *Journal of Economics & Management Strategy*, 6(4):725–753. Véase también Ma, C.-t. A. (1994), Health care payment systems: Cost and quality incentives, *Journal of Economics & Management Strategy*, 3(1), 93–112.

Martín, J. J., López del Amo González, M. P., y Cabaés Hita, J. M. (2019). Análisis multinivel de la eficiencia técnica de los hospitales del Sistema Nacional de Salud español por tipo de propiedad y gestión. *Gaceta Sanitaria*, 33(4):325–332.

Martín, J. J. M. y López del Amo González, M. P. (2007). La medida de la eficiencia en las organizaciones sanitarias. *Presupuesto y Gasto Público*, 49:139–161.

Meeusen, W. y van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from cobb-douglas production functions with composed error. *International Economic Review*, 18(2):435–444.

Menéndez Rexach, Á. (2008). La gestión indirecta de la asistencia sanitaria pública. Reflexiones en torno al debate sobre la privatización de la sanidad. *Revista de Administración Sanitaria*, 6(2):269–296.

Ministerio de Sanidad (2026a). Documento ejecutivo: Resumen del borrador del nuevo Estatuto Marco. Technical report, Ministerio de Sanidad. Enero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/docs/Resumen_Borrador_Estatuto_Marco.pdf.

Ministerio de Sanidad (2026b). El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Technical report, Ministerio de Sanidad. Nota de prensa, 10 de febrero de 2026. Disponible en https://www.sanidad.gob.es.

Ministerio de Sanidad (2026c). Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada. Hospitales y Centros sin Internamiento. Año 2023. Technical report, Ministerio de Sanidad, Subdirección General de Información Sanitaria, Madrid.

Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Clasificación de hospitales del SNS por complejidad asistencial. Technical report, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.

Monereo Pérez, J. L., Molina Navarrete, C., y Moreno Vida, M. N. (2007). *Comentario práctico a la legislación reguladora de la sanidad en España.* Comares, Granada. Directores.

OECD (2023). Health at a glance 2023: OECD indicators. Technical report, OECD Publishing, Paris.

Pemán Gavín, J. M. (2005). *Asistencia sanitaria y Sistema Nacional de Salud: estudios jurídicos.* Comares, Granada.

Prior, D. (2006). Efficiency and total quality management in health care organizations: A dynamic frontier approach. *Annals of Operations Research*, 145(1):281–299.

Puig-Junoy, J. y Dalmau, E. (2000). ¿qué sabemos acerca de la eficiencia de las organizaciones sanitarias en españa? una revisión de la literatura económica. *Investigaciones Económicas*, 24(3):543–569. Véase también Puig-Junoy, J. (1998), Technical efficiency in the clinical management of critically ill patients, *Health Economics*, 7(3), 263–277.

Repullo, J. R. y Freire, J. M. (2008). Gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud: mejorando el balance entre los beneficios y los costes de la descentralización. Informe SESPAS 2008. *Gaceta Sanitaria*, 22:118–125.

Rodríguez López, F. y Sánchez Macías, J. I. (2004). Especialización y eficiencia en el sistema hospitalario español. *Cuadernos Económicos de ICE*, 67:27–47.

Rosko, M. D. y Mutter, R. L. (2008). Stochastic frontier analysis of hospital inefficiency: A review of empirical issues and an assessment of robustness. *Medical Care Research and Review*, 65(2):131–166.

Simar, L. y Wilson, P. W. (2007). Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. *Journal of Econometrics*, 136(1):31–64.

Smith, P. (1995). On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector. *International Journal of Public Administration*, 18(2–3):277–310.

Street, A. (2003). How much confidence should we place in efficiency estimates? *Health Economics*, 12(11):895–907.

Tiemann, O. y Schreyoegg, J. (2012). Changes in hospital efficiency after privatization. *Health Care Management Science*, 15(4):310–326.

Villar Rojas, F. J. (2009). La privatización de la gestión de los servicios sanitarios públicos: las experiencias de Valencia y Madrid. *Revista Derecho y Salud*, 17(1):1–22.

Wang, H.-J. y Schmidt, P. (2002). One-step and two-step estimation of the effects of exogenous variables on technical efficiency levels. *Journal of Productivity Analysis*, 18(2):129–144.

Zuckerman, S., Hadley, J., y Iezzoni, L. (1994). Measuring hospital efficiency with frontier cost functions. *Journal of Health Economics*, 13(3):255–280.